

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM DIREITO POLÍTICO E
ECONÔMICO**

HILTON ARAUJO DE MELO

APLICAÇÕES DA ECONOMIA COMPORTAMENTAL NA SAÚDE SUPLEMENTAR

São Paulo

2025

HILTON ARAUJO DE MELO

APLICAÇÕES DA ECONOMIA COMPORTAMENTAL NA SAÚDE SUPLEMENTAR

Dissertação apresentada ao curso de mestrado em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito à obtenção de título de Mestre em Direito Político e Econômico.

Linha de Pesquisa: O Poder Econômico e seus Limites Jurídicos.

ORIENTADOR: Prof. Dr. Marco Antonio Loschiavo de Barros

São Paulo

2025

M528a Melo, Hilton Araujo de Melo.
Aplicação da economia comportamental na saúde
suplementar [recurso eletrônico] / Hilton Araujo de Melo.
947 KB

Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico)
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2026.
Orientador: Prof. Dr. Marco Antonio Loschiavo de Barros.
Referências bibliográficas: f. 134-144.

1. Saúde suplementar. 2. Economia comportamental. 3.
Nudges. 4. IDSS. 5. Promoprev. I. Barros, Marco Antonio
Loschiavo de, *orientador*. II. Título.

Biblioteca Responsável: Ana Maria Fernandes Neta - CRB 8/11286

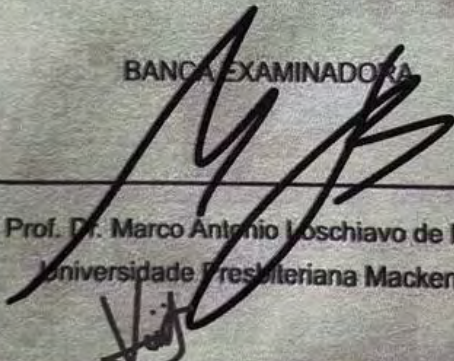
HILTON ARAUJO DE MELO

APLICAÇÕES DA ECONOMIA COMPORTAMENTAL NA SAÚDE
SUPLEMENTAR.

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Direito Político e Econômico.

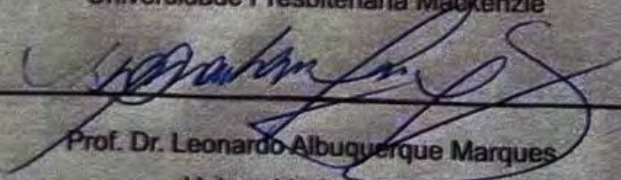
Aprovada em 11 de fevereiro de 2026.

BANCA EXAMINADORA



Prof. Dr. Marco Antonio Loschiavo de Barros
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Vicente Bagnoli
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dr. Leonardo Albuquerque Marques
Universidade Ceuma

RESUMO

O setor de saúde suplementar brasileiro, responsável pela cobertura de mais de 50 milhões de beneficiários, enfrenta crise de sustentabilidade caracterizada por custos assistenciais crescentes, transformações demográficas aceleradas e assimetrias informacionais que comprometem a qualidade dos serviços e a capacidade decisória dos consumidores. Este trabalho investiga a aplicação de conceitos da economia comportamental como ferramenta regulatória de baixo custo para aprimoramento da regulação exercida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), analisando criticamente dois instrumentos regulatórios centrais: o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) e o Programa de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças (Promoprev). A pesquisa parte da fundamentação teórica do *law and economics* tradicional, identificando seus limites ao desconsiderar falhas de mercado comportamentais decorrentes de desvios cognitivos sistemáticos dos agentes. Demonstra-se que o modelo teórico de racionalidade plena do *homo economicus* revela-se insuficiente para explicar padrões decisórios subótimos observados empiricamente na escolha de planos de saúde e na adesão a comportamentos preventivos. A análise empírica evidencia que o IDSS, concebido para reduzir assimetrias informacionais, apresenta deficiências relacionadas à baixa divulgação, complexidade de acesso e ausência de consequencialidade efetiva. O Promoprev, voltado ao cuidado preventivo, ainda não explora plenamente o potencial dos nudges e da arquitetura de escolhas para superar barreiras comportamentais como inércia, presenteísmo e otimismo irrealista. A contribuição central da dissertação reside em demonstrar que a regulação da saúde suplementar deve incorporar sistematicamente os fundamentos da economia comportamental como complemento essencial às abordagens tradicionais, oferecendo ferramentas de baixo custo com potencial para melhorar simultaneamente a qualidade decisória individual, a eficiência alocativa setorial e o bem-estar dos beneficiários.

Palavras-chave: saúde suplementar. economia comportamental. nudges. IDSS. Promoprev.

ABSTRACT

The Brazilian supplementary health sector, responsible for providing coverage to more than 50 million beneficiaries, faces a sustainability crisis characterized by rising healthcare costs, accelerated demographic transformations, and information asymmetries that compromise both the quality of services and consumers' decision-making capacity. This work investigates the application of behavioral economics concepts as a low-cost regulatory tool to improve the regulation exercised by the National Supplementary Health Agency (ANS), critically analyzing two central regulatory instruments: the Supplementary Health Performance Index (IDSS) and the Health Promotion and Disease Prevention Program (Promoprev). The research builds upon the theoretical foundations of traditional *law and economics*, identifying its limitations in disregarding behavioral market failures resulting from systematic cognitive biases of agents. It is demonstrated that the theoretical model of perfect rationality of the *homo economicus* proves insufficient to explain the empirically observed suboptimal decision-making patterns in the choice of health insurance plans and adherence to preventive behaviors. The empirical analysis reveals that the IDSS, designed to reduce information asymmetries, exhibits deficiencies related to low dissemination, access complexity, and absence of effective consequentiality. Promoprev, focused on preventive care, does not yet fully exploit the potential of nudges and choice architecture to overcome behavioral barriers such as inertia, present bias, and unrealistic optimism. The dissertation's central contribution lies in demonstrating that supplementary health regulation must systematically incorporate behavioral economics foundations as an essential complement to traditional approaches, offering low-cost tools with potential to simultaneously improve individual decision-making quality, sectoral allocative efficiency, and beneficiaries' welfare.

Keywords: supplementary health. behavioral economics. nudges. IDSS. Promoprev.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Prof. Dr. Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros pela brilhante orientação, pelos ensinamentos e pelas críticas que permitiram a conclusão do trabalho com o sentimento de termos passado em revista os pontos mais essenciais do problema enfrentado no trabalho, a partir de uma dúvida genuína de pesquisa.

Igualmente, ao Prof. Dr. Vicente Bagnoli e ao Prof. Dr. Leonardo Albuquerque Marques, pela participação na banca e por todos os conselhos e orientações nas discussões havidas.

Agradeço ainda ao Dr. Maurício Nunes, então Diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS, e à Kátia Audi Curci, Coordenadoria de Indução à Melhoria da Qualidade Setorial da ANS, pelas longas conversas e pela pronta disponibilidade para nos guiar na busca por dados e contextos históricos que moldaram a construção regulatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

À família, esposa e filha, pela compreensão diária e pela força e incentivo que vocês representam na minha vida.

We get by with a little help from our friends

(trecho de Beatles)

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	14
1 O MODELO DE SAÚDE BRASILEIRO	21
1.1 O Sistema Único de Saúde (SUS).....	21
1.2 O papel da iniciativa privada na saúde	24
1.3 A origem e o desenvolvimento da saúde suplementar.....	26
2 OS DESAFIOS DA REGULAÇÃO DA SAÚDE SUPLEMENTAR.....	29
2.1 A regulação infraconstitucional do setor de saúde suplementar	29
2.2 A dinâmica do setor e de seus agentes econômicos	34
2.3 Os falhas de mercado no setor de saúde suplementar.....	40
3 AS CONTRIBUIÇÕES DO <i>LAW AND ECONOMICS</i> SOBRE A REGULAÇÃO DA SAÚDE SUPLEMENTAR	46
3.1 Introdução ao <i>law and economics</i>	46
3.2 Fundamentos teóricos do <i>law and economics</i>	51
3.3 Aplicação do <i>law and economics</i> na regulação da saúde suplementar	56
4 O USO DA ECONOMIA COMPORTAMENTAL COMO FERRAMENTA DA REGULAÇÃO.....	64
4.1 Introdução à economia comportamental.....	64
4.1.1 A heurística da disponibilidade.....	66
4.1.2 A heurística da representatividade.....	67
4.1.3 A heurística do ancoramento	68
4.1.4 A Teoria da Perspectiva (1979)	69
4.2 A incorporação da economia comportamental ao Direito (<i>behavioral law and economics</i>).....	70
4.2.1 Paternalismo Libertário	75
4.2.2 <i>Nudges</i> e arquitetura de escolhas	77
4.3 Efetividade na aplicação de <i>nudges</i> enquanto intervenções estatais	81

5	APLICAÇÕES DO <i>BEHAVIORAL LAW AND ECONOMICS</i> NA SAÚDE SUPLEMENTAR.....	86
5.1	Introdução.....	86
5.2	Como escolher (e manter) o melhor plano de saúde	88
5.2.1	Quando a decisão é complexa e há muito em jogo (<i>when the stakes are too high</i>) 88	
5.2.2	O IDSS: Um propósito louvável, uma execução deficiente.....	93
5.2.3	<i>Nudges</i> para a democratização e a efetivação do IDSS.....	100
5.3	Induza cuidado hoje (priorizamos o hoje e não damos valor ao amanhã)	106
5.3.1	As falhas comportamentais que impedem o cuidado adequado.....	106
5.3.2	O Promoprev e os programas de linha de cuidado: A saúde vista a partir do cuidado.....	111
5.3.3	<i>Nudges</i> para ampliar a adesão ao cuidado na saúde suplementar	122
	CONCLUSÃO.....	129
	REFERÊNCIAS.....	132
	APÊNDICE A – Relação das resoluções normativas da ANS examinadas	142
	APÊNDICE B – Resolução RN 505/2022 – IDSS (Programa de Qualificação de Operadoras).....	145
	APÊNDICE C – Resolução RN 498/2022 – Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	146
	APÊNDICE D – Resolução RN 499/2022 – Bonificação e Premiação aos Beneficiários 147	

Anahn	Associação Nacional de Hospitais Privados
ANS	Agência Nacional de Saúde Suplementar
CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CAMSS	Câmara de Saúde Suplementar
Cebas	Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social
CFM	Conselho Federal de Medicina
CLT	Consolidação das Leis Trabalhistas
CNSaúde	Confederação Nacional de Saúde
CPT	Cobertura Parcial Temporária
DLP	Doenças ou Lesões Preexistentes
EC	Emenda Constitucional
ESF	Estratégia Saúde da Família
FGE	Fator de Ganhos de Eficiência
FNS	Fundo Nacional de Saúde
IAP	Instituto de Aposentadorias e Pensões
IAPB	Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários
IAPC	Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciais
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDSS	Índice de Desempenho da Saúde Suplementar
IEPS	Instituto de Estudos para Políticas de Saúde
INPS	Instituto Nacional de Previdência Social
IRC	Índice de Reclamações Consolidados
LC	Lei Complementar
NASEM	National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine

NIP	Núcleo de Informação ao Prestador
NPS	Net Promoter Score
NTRP	Nota Técnica de Registro de Produto
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OSS	Orcamento da Seguridade Social
PAC	Programa de Aceleração do Crescimento
PIB	Produto Interno Bruto
POO	Programa de Oualificação de Operadoras
Promoprev	Programa de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doencas
PTA	Programa Transmissor de Arquivos
RN	Resolução Normativa
RPC	Registro de Planos Coletivos
SAC	Servico de Atendimento ao Consumidor
SIP	Sistema de Informações de Produtos
SUS	Sistema Único de Saúde
Susen	Superintendência de Seguros Privados

INTRODUÇÃO

A Saúde Suplementar no Brasil representa um pilar fundamental na estrutura do sistema de saúde nacional, complementando a atuação do setor público e garantindo assistência médica a uma parcela significativa da população brasileira. Com mais de 50 milhões de beneficiários (ANS, 2025a), este setor se consolidou como elemento indispensável para a sustentabilidade do próprio sistema nacional de saúde, aliviando a pressão sobre o SUS e proporcionando maior agilidade nos serviços médicos. O setor privado de saúde brasileiro caracteriza-se por sua complexidade e heterogeneidade, sendo composto por diversos atores com interesses muitas vezes divergentes, o que torna sua gestão e regulação particularmente desafiadoras. Este setor não pode ser considerado um ente único ou um organismo uniforme, mas sim um ecossistema complexo formado por operadoras de diferentes modalidades, prestadores de serviços, órgãos reguladores, consumidores e outros agentes que interagem continuamente em um ambiente de constantes transformações tecnológicas, demográficas e econômicas.

Neste estudo, busca-se demonstrar que nos últimos anos, a saúde suplementar brasileira tem enfrentado uma crise de sustentabilidade financeira preocupante, com prejuízo operacional decorrente do resultado de custos assistenciais crescendo em ritmo superior às receitas. Tais dificuldades econômicas impactam diretamente a qualidade e a continuidade dos serviços prestados aos beneficiários. Entre os principais desafios enfrentados pelo setor, destaca-se a transformação do perfil demográfico brasileiro, com o envelhecimento acelerado da população ocorrendo em velocidade superior à observada nos países desenvolvidos (OCDE, 2017). Esta mudança demográfica pressiona os custos assistenciais, uma vez que a população idosa tende a utilizar mais intensamente os serviços de saúde.

Do ponto de vista dos consumidores, as reclamações contra planos de saúde têm aumentado significativamente, com destaque para questões relacionadas a reembolsos, negativas de cobertura para tratamentos, reajustes considerados abusivos especialmente em contratos coletivos, atrasos em autorizações, rescisões unilaterais arbitrárias e desinformação sobre cláusulas contratuais. Estas práticas são frequentemente apontadas como violações ao direito à saúde e à dignidade do consumidor, resultando em crescente judicialização do setor. Para as operadoras,

além dos desafios financeiros já mencionados, a incorporação de novas tecnologias e medicamentos de alto custo, sem a devida análise de custo-efetividade, representa uma pressão adicional sobre a sustentabilidade do sistema. A inflação médica, historicamente superior à inflação geral da economia, também contribui para o desequilíbrio entre receitas e despesas, dificultando o planejamento financeiro de longo prazo das empresas do setor.

Diante deste cenário complexo, este trabalho propõe-se a contextualizar o sistema brasileiro e identificar possíveis caminhos para o aprimoramento da saúde suplementar nacional. É apresentado um retrato detalhado do setor de saúde suplementar brasileiro, identificando e caracterizando todos os atores principais que compõem este complexo ecossistema. Serão analisados os papéis e interesses dos diversos agentes, incluindo órgãos governamentais, com destaque para a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), operadoras em suas diferentes modalidades, prestadores de serviços, consumidores, empresas contratantes, fornecedores de insumos e tecnologias, e entidades representativas como conselhos profissionais e associações setoriais. Serão visitados os desafios estruturais do setor, com análise detalhada dos problemas mais frequentemente citados por todos os envolvidos. Entre estes, destacam-se o alto custo da assistência médica e sua tendência de crescimento acima da inflação, as deficiências na prestação dos serviços, os conflitos relacionados a rescisões contratuais, a metodologia e os percentuais de reajustes, as limitações de coberturas, as negativas de atendimento e os desafios associados à incorporação de novas tecnologias no rol de procedimentos obrigatórios.

Como fundamentação teórica para a análise desses problemas e para a proposição de possíveis soluções, o estudo realizará uma revisão dos conceitos fundamentais do *law and economics*. Esta abordagem, que aplica princípios econômicos à ciência jurídica, busca explicar a conduta humana e avaliar se a legislação estimula ou não comportamentos desejáveis na formação, estrutura e processos das relações sociais. As premissas fundamentais a serem exploradas serão a maximização racional das necessidades humanas, a obediência dos indivíduos a incentivos de preços para balizar seu comportamento racional, e a existência de regras legais que podem ser avaliadas com base na eficiência de suas aplicações. Complementando esta base teórica, o trabalho apresentará os principais conceitos e contribuições da economia comportamental, campo multidisciplinar que une economia

e psicologia para compreender como as pessoas tomam decisões e quais fatores influenciam suas escolhas. Serão explorados princípios como heurísticas - atalhos mentais utilizados para simplificar processos decisórios, vieses cognitivos - erros sistemáticos no processamento de informações e *framing* - como a forma de apresentação de uma informação pode alterar a percepção e a decisão das pessoas. Esta abordagem reconhece que os indivíduos nem sempre agem de forma puramente racional, sendo influenciados por emoções, contexto social e limitações cognitivas.

A Teoria do *Nudge*, uma aplicação prática da economia comportamental que defende o uso de intervenções simples, fáceis e de baixo custo para guiar o processo decisório dos cidadãos, será objeto de especial atenção. Esta abordagem, que visa obter melhores resultados individuais e coletivos por meio de pequenas alterações na arquitetura de escolhas, tem sido crescentemente aplicada em políticas públicas de saúde em diversos países, com resultados promissores. O foco central deste estudo será analisar a aplicação dos conceitos da economia comportamental na regulação da saúde suplementar brasileira, especialmente nas ações da ANS. Será investigado se e como o órgão regulador tem incorporado estas abordagens em suas normativas e programas, com foco particular nos instrumentos desenvolvidos para redução de assimetrias informacionais e para promoção de cuidados preventivos.

A pesquisa buscará responder a duas questões fundamentais: primeiramente, se a regulação da saúde suplementar no Brasil efetivamente aplica conceitos da economia comportamental como ferramenta para implementação de medidas regulatórias com baixo custo, e, em caso afirmativo, quais resultados têm sido colhidos até o momento com estas iniciativas. Para responder a essas questões, o trabalho concentrará análise em dois instrumentos regulatórios desenvolvidos pela ANS que tangenciam a lógica da economia comportamental: o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) e o Programa de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças (Promoprev). O IDSS, concebido como ferramenta para reduzir assimetrias informacionais e auxiliar consumidores na escolha de planos de saúde, será examinado quanto à sua efetividade em cumprir esses objetivos, investigando-se os obstáculos relacionados à divulgação, compreensibilidade e consequencialidade do indicador. O Promoprev, voltado à reorientação do modelo assistencial em direção ao cuidado preventivo, será analisado quanto à sua capacidade de superar barreiras comportamentais que dificultam a adesão dos

beneficiários a programas de promoção da saúde, examinando-se em que medida a regulação atual incorpora *nudges* e arquitetura de escolhas para enfrentar vieses como inércia, presenteísmo e otimismo irrealista.

Estas análises permitirão avaliar a efetividade das abordagens comportamentais no contexto específico da saúde suplementar brasileira e identificar oportunidades de aprimoramento. Será investigada a existência de evidências que sustentem o uso de aplicações inspiradas na economia comportamental para incentivar a redução dos custos assistenciais e aprimorar a qualidade dos serviços prestados aos consumidores. Neste sentido, serão analisadas experiências nacionais e internacionais, buscando identificar práticas bem-sucedidas que possam ser adaptadas ao contexto brasileiro, considerando as particularidades do nosso sistema de saúde e do marco regulatório da saúde suplementar.

A relevância deste estudo justifica-se pela necessidade urgente de encontrar soluções inovadoras e eficientes para os desafios enfrentados pelo setor de saúde suplementar brasileiro, que afetam diretamente a vida de mais de 50 milhões de usuários e, indiretamente, todo o sistema de saúde nacional. Em um contexto de recursos limitados e demandas crescentes, abordagens que permitam alcançar melhores resultados com menor custo regulatório representam um caminho promissor para garantir a sustentabilidade do setor e a qualidade da assistência prestada. Por fim, espera-se que as análises e conclusões deste trabalho possam contribuir para o aprimoramento das políticas regulatórias da saúde suplementar brasileira, fornecendo subsídios para a incorporação mais sistemática e efetiva de instrumentos baseados na economia comportamental. Ao explorar a interface entre regulação, economia e comportamento humano, busca-se abrir novos caminhos para enfrentar os complexos desafios do setor, promovendo um sistema mais eficiente, equitativo e centrado nas necessidades dos beneficiários.

Nesse sentido, a presente investigação alinha-se intrinsecamente à linha de pesquisa 'O Poder Econômico e seus Limites Jurídicos', do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde o ambiente acadêmico proporciona excelência para o debate crítico sobre como o Estado, por meio do arcabouço regulatório, deve atuar para conter as falhas e os excessos do poder econômico privado. Ao investigar os instrumentos da ANS sob a ótica comportamental, o trabalho reflete as ricas

discussões fomentadas no mestrado sobre a necessidade de se impor contornos jurídicos modernos e eficientes que garantam a função social da ordem econômica, protegendo o consumidor e reequilibrando as forças no sensível mercado da saúde

O presente trabalho adota abordagem qualitativa fundamentada em três eixos metodológicos complementares: revisão bibliográfica sistemática interdisciplinar articulando produção acadêmica nas áreas de direito regulatório, análise econômica do direito e economia comportamental; análise documental da regulação setorial vigente, incluindo Lei 9.656/1998, resoluções normativas da ANS e dados estatísticos oficiais sobre desempenho do setor; e análise comparativa com experiências internacionais, especialmente o Medicare Part D nos Estados Unidos. A seleção do IDSS e do Promoprev como estudos de caso principais fundamenta-se em sua representatividade enquanto iniciativas oficiais da ANS com abrangência nacional, relevância temática ao endereçarem dimensões complementares da regulação comportamental (escolha informada e adesão preventiva), e disponibilidade documental que permite análise fundamentada. A delimitação temporal concentra-se no período 2016-2024, abrangendo criação e evolução dos instrumentos analisados, com dados quantitativos referentes primordialmente a 2023-2024.

As escolhas metodológicas que delimitam o escopo e a natureza da desta pesquisa foram limitadas a um desenho de investigação exploratório-analítico, característico de estudos que buscam identificar lacunas regulatórias e formular hipóteses para investigação futura, diferenciando-se de pesquisas confirmatórias que testam empiricamente a efetividade de intervenções. Esta escolha metodológica é deliberada e adequada ao estágio de maturidade do objeto, já que a aplicação sistemática da economia comportamental na regulação da saúde suplementar brasileira constitui ainda um campo emergente, carente de *framework* analítico consolidado que permita avançar diretamente para validação experimental. Assim, a pesquisa fundamenta-se em fontes documentais, bibliográficas e dados secundários oficiais, não incluindo pesquisas empíricas primárias com beneficiários, operadoras ou reguladores. Esta delimitação decorre do objetivo central consistente em demonstrar ou não a existência de lacuna regulatória comportamental e propor um arcabouço teórico para seu enfrentamento — tarefa que precede logicamente a mensuração de efetividade de intervenções ainda não implementadas.

A ausência de dados longitudinais sobre os impactos do IDSS e do Promoprev no comportamento dos agentes constitui um achado substantivo que evidencia deficiência do próprio sistema regulatório, já que a ANS não coleta nem disponibiliza métricas que permitiriam avaliar a efetividade de seus instrumentos de transparência informacional, o que reforça a tese central sobre insuficiência da abordagem comportamental na regulação vigente. No mesmo sentido, as proposições de aprimoramento baseadas em *nudges* apresentam caráter teórico-propositivo, fundamentadas em princípios consolidados pela literatura de economia comportamental e em evidências de efetividade documentadas em contextos internacionais análogos.

Outros aspectos relevantes não foram aprofundados por extrapolarem a delimitação temática estabelecida, incluindo a análise detalhada da judicialização da saúde suplementar, impactos comportamentais da verticalização das operadoras e resistências político-institucionais à implementação de nudges pela ANS. Essas delimitações não comprometem a validade dos achados, mas circunscrevem adequadamente a contribuição da pesquisa, que se apresenta como um trabalho exploratório que identifica uma lacuna regulatória, propõe um *framework* teórico para seu enfrentamento e estabelece uma agenda para investigações empíricas futuras.

A trabalho organiza-se em cinco capítulos articulados de modo a construir progressivamente a argumentação central sobre a necessidade de incorporação sistemática dos fundamentos da economia comportamental na regulação da saúde suplementar brasileira. O quinto capítulo constitui o núcleo empírico da pesquisa, analisando criticamente o IDSS e o Promoprev. A investigação revela achados preocupantes que fundamentam a tese central deste trabalho: embora o IDSS tenha sido concebido como ferramenta comportamental para reduzir assimetrias informacionais na avaliação qualitativa de planos de saúde, sua implementação apresenta deficiências estruturais relacionadas à baixa divulgação, complexidade de acesso e ausência de consequencialidade efetiva, impedindo que cumpra seu propósito de arquitetura de escolhas. De modo similar, a análise do Promoprev demonstra que, apesar de endereçar dimensão crucial da reorientação assistencial em direção ao cuidado preventivo, o programa ainda não explora adequadamente o potencial dos *nudges* para superar barreiras comportamentais documentadas pela literatura internacional, como inércia, viés de presente e otimismo irrealista. Esses

achados convergem para evidenciar lacuna regulatória significativa: a ANS desenvolveu instrumentos que tangenciam a lógica comportamental, mas não incorporou sistematicamente os princípios da economia comportamental em sua arquitetura regulatória, desperdiçando oportunidades de melhorar simultaneamente a qualidade decisória individual dos beneficiários, a eficiência alocativa setorial e o bem-estar agregado.

1 O MODELO DE SAÚDE BRASILEIRO

1.1 O Sistema Único de Saúde (SUS)

A Constituição assegura a saúde como um direito social fundamental, onde cada indivíduo pode reclamar do Estado uma adequada prestação, independentemente de contribuição prévia¹. O tema é tão relevante que a expressão “saúde” é encontrada mais de oitenta vezes no texto constitucional.

Não à toa, a saúde é também um dos setores com maior relevância econômica abarcando aproximadamente 10% do produto interno bruto do país (OCDE, 2025). A atribuição de cuidar da saúde refere-se a uma competência administrativa, e foi distribuída para União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II, da CF/88). De modo geral, o modelo brasileiro busca reconhecer o acesso universal à saúde na forma de uma garantia a todos os indivíduos, considerando que a sociedade brasileira é marcada por forte desigualdade econômica e que os serviços de saúde normalmente apresentam custos elevadíssimos.

Protege-se assim os setores mais vulneráveis da sociedade, em atenção aos valores inseridos no princípio da dignidade da pessoa humana e no imperativo de justiça social. Na visão de Ladeira (2012), o constituinte fez questão de fixar que o dever estatal reside na prestação de políticas que visem assegurar a redução de doenças assim como o dever de prover a recuperação daqueles que, por algum motivo, não estiverem em plenitude do seu bem-estar físico.

¹ Art. 6º. **São direitos sociais** a educação, **a saúde**, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua **promoção, proteção e recuperação** (...) (grifo nosso)

O acesso é garantido por meio de duas formas: a fonte de custeio pública e a estrutura prestacional majoritariamente pública². Na construção do nosso sistema de saúde, certamente o destaque vai para o Sistema Único de Saúde (SUS), inspirado no modelo inglês (PAIM, 2008). Aqui, o SUS é previsto já na Constituição Federal, que tratou de fixar deveres relevantes como a universalização e os limites mínimos quanto às fontes de custeio pelos entes da federação.

O SUS, instituído pela Constituição Federal de 1988 como direito social fundamental, configura-se como um modelo universal, gratuito e descentralizado, baseado nos princípios da universalidade, integralidade e equidade. De acordo com Lima (2016), houve forte embate durante a assembleia constituinte, onde o movimento liberal de assistência à saúde conflitava com o movimento estatal, tendo este conseguido realizar um sonho histórico a partir da estruturação constitucional do SUS, prevendo a integração entre as esferas de governo, de modo hierarquizado e regionalizado. Sua criação marcou a transição de um sistema excludente e segmentado para um regime público unificado, financiado por recursos tripartites (União, estados e municípios) e regulado pela Lei nº 8.080/90, que estabeleceu diretrizes como a descentralização administrativa, a participação social e a hierarquização das redes de atenção.

A Lei nº 8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, estruturou o SUS ao estabelecer diretrizes organizacionais, princípios e mecanismos de gestão. Sua influência pode ser analisada em dimensões diversas. A lei consagrou os princípios da universalidade (acesso sem restrições), integralidade (atenção ampla, incluindo promoção, prevenção e reabilitação) e equidade (priorização de grupos vulneráveis). Esses pilares orientam a organização do SUS, garantindo que as políticas públicas superem modelos excludentes e fragmentados.

A gestão foi descentralizada, com comando único em cada esfera de governo (União, estados e municípios), transferindo responsabilidades para os municípios na execução direta dos serviços. A organização em redes regionalizadas e

² O SUS complementa sua capacidade assistencial contratando serviços da rede privada (hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais) por meio de repasses públicos. Isso ocorre quando a rede pública não consegue suprir toda a demanda ou quando há necessidade de especializações não disponíveis no sistema estatal. O financiamento segue regras definidas pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias estaduais e municipais, utilizando recursos do Orçamento da Seguridade Social (OSS) e fundos específicos, como o Fundo Nacional de Saúde (FNS).

hierarquizadas buscou integrar níveis de atenção (primária, secundária e terciária), embora desafios de coordenação persistam devido à heterogeneidade regional. A lei também institucionalizou a participação popular por meio de Conselhos de Saúde (nacional, estaduais e municipais), com composição tripartite (gestores, profissionais e usuários). Esse mecanismo fortaleceu o controle social, embora críticas apontem para limitações na efetividade prática.

No plano financeiro, a lei consolidou o modelo de financiamento compartilhado entre União, estados e municípios, com repasses vinculados a percentuais mínimos das receitas próprias (EC 29/2000 e LC 141/2012). Conforme a Emenda Constitucional nº 29/2000, o SUS é financiado por recursos vinculados, a partir de percentuais mínimos de aplicação de receitas próprias: 15% para municípios, 12% para estados e valor corrigido pelo PIB para a União, regulamentados posteriormente pela Lei Complementar nº 141/2012. Os gastos totais com saúde no Brasil em 2021 alcançaram R\$ 872,7 bilhões (9,7% do PIB), sendo que os gastos das famílias e instituições sem fins de lucro a serviço das famílias atingiram R\$ 509,3 bilhões (5,7% do PIB), e os do governo foram de apenas R\$ 363,4 bilhões (4,0% do PIB) (IBGE, 2024). Comparando os gastos do governo em saúde com países da OCDE, temos que o Brasil (4,0%) apresenta uma das menores participações do governo no gasto com saúde em relação ao PIB, ficando à frente apenas do México (3,1%) (IBGE, 2024).

Uma justificativa para o subfinanciamento crônico da saúde pública brasileira parece advir das disputas orçamentárias com outras áreas, inclusive da seguridade social, que também persistem como desafios estruturais, agravados por mecanismos de transferência intergovernamental complexos e fragmentados. O resultado disso é que apenas 45% dos financiamentos compulsórios contidos no orçamento são destinados à saúde, enquanto em países da OCDE a média é de 75% (OCDE, 2025). Além de gastar, o Brasil aparentemente gasta mal. Por exemplo, não obstante a Estratégia Saúde da Família (ESF) cubra 65% da população prioritária³, a concentração de serviços de alta complexidade em regiões metropolitanas e a heterogeneidade na capacidade de gestão municipal geram assimetrias no acesso.

³ Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS). Estudo Institucional 08: Estimativa de Recursos Necessários para Ampliação da Estratégia Saúde da Família. Brasil: IEPS, 2022. Disponível em: https://ieps.org.br/wp-content/uploads/2022/12/IEPS_Estudo_Institucional_08.pdf. Acesso em: 16 fev.2025.

Regionalmente, a descentralização para municípios, embora promova autonomia, dificulta a coordenação de redes integradas e a implementação de políticas nacionais, como a regulamentação do Cartão Nacional de Saúde para evitar duplicidade de atendimentos.

Estruturalmente, o SUS organiza-se em redes hierarquizadas, com atenção primária como porta de entrada, embora conviva com a lógica fragmentada do setor privado, onde 63,6% dos usuários iniciam o cuidado em consultórios particulares (AZEVEDO et al., 2016). O SUS é a única forma de acesso à saúde para 70% da população brasileira.

1.2 O papel da iniciativa privada na saúde

A Constituição estabeleceu que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada (art. 199). A participação das instituições privadas ocorre inicialmente de forma complementar ao SUS, quando instituições privadas prestam serviços de saúde por meio de instrumentos contratuais de regime de direito público, observando-se as diretrizes do SUS (art. 199, §1º). Na prática, quando o SUS não for capaz de prover ações e serviços de saúde diretamente, poderá se valer da iniciativa privada para ofertar cobertura assistencial à população de uma determinada área (art. 24 da Lei n. 8.080/90). Nessas hipóteses, a prestação de serviços de saúde se dará sob a forma do regime de direito público e a contratação submeter-se-á às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato (art. 25, §2º, da Lei n. 8.080/90).

As instituições privadas também podem atuar sob o regime privado, por iniciativa própria, por meio de profissionais liberais legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado, os quais estarão submetidos a verdadeiro regramento misto, derivado da aplicação dos princípios da Ordem Econômica (livre iniciativa, livre concorrência, proteção ao consumidor, etc) e também das regras definidas por instâncias públicas de controle, como o conselhos profissionais e os órgãos de vigilância sanitária. É justamente por se possibilitar a participação privada

na assistência à saúde, considerada como atividade de interesse público, que se justifica a especial atenção do Estado na regulação da atividade (LADEIRA, 2016).

O mercado brasileiro de saúde privada é robusto, e de acordo com um estudo da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), em janeiro de 2022, havia 4.466 hospitais privados no Brasil⁴. A iniciativa privada também é responsável pela oferta de serviços de saúde de forma suplementar, a partir da estruturação de um setor responsável pela prestação de serviços e/ou da cobertura financeira de custos assistências em saúde, onde as chamadas operadoras de planos de saúde dispõem de rede própria de prestadores, ou de rede credenciada, contratada ou referenciada, capaz de prestar atenção médica, hospitalar e odontológica, aos usuários beneficiários dos planos. Na prática, o sistema privado suplementar atende 26% da população brasileira, por meio de 669 operadoras de planos de saúde (ANS, 2025a).

Na prática, a relação entre setor público e privado na saúde brasileira revela uma complexidade que transcende a dicotomia simples entre sistemas separados. Amorim, Cherchiglia e Reis (2023) documentam que beneficiários da saúde suplementar utilizam o SUS para realizar procedimentos mesmo quando previstos contratualmente, fenômeno particularmente pronunciado em assistência ambulatorial de alta complexidade. Os autores identificaram 31.941 beneficiários de planos privados que realizaram hemodiálise no SUS entre 2012 e 2019, totalizando 5,81 milhões de sessões a custo de R\$ 1,67 bilhões, sendo que 20,11% utilizaram a rede pública por 25 meses ou mais. Este uso cruzado⁵ aumenta a iniquidade na oferta, acesso e utilização de serviços, pois amplia lucro das operadoras às expensas de

⁴ CNSaúde. Cenário dos Hospitais no Brasil 2021-2022. Disponível em: <http://cnsaude.org.br/wp-content/uploads/2022/07/CNSAUDE-FBH-CENARIOS-2022.pdf>. Acesso em 02 fev. 2025.

⁵ A interação público-privada no sistema de saúde brasileiro manifesta-se por meio de padrões bidirecionais de uso cruzado que evidenciam falhas estruturais em ambos os subsistemas. Andrade et al. (2018), analisando Pesquisa Nacional de Saúde 2013, documentam que aproximadamente 20% da população coberta por planos privados utiliza serviços ofertados pelo SUS, concentrando-se especialmente em serviços de alta complexidade (internação hospitalar, quimioterapia, hemodiálise), características de bens públicos (vacinação) e emergência. Reciprocamente, cerca de 15% dos indivíduos sem plano são atendidos pelo setor privado mediante desembolso direto, principalmente para atenção secundária (23% dos exames laboratoriais ou de imagem), consultas odontológicas (50,3%) e outros profissionais de saúde como fisioterapeutas e nutricionistas (19,5%). Os autores identificam três consequências dessa interação: primeiro, desigualdade no acesso favorecendo beneficiários com cobertura privada que possuem dupla porta de entrada; segundo, fragmentação do cuidado para população coberta que não recebe atenção longitudinal integrada; terceiro, estímulo à demanda por serviços no SUS por provedores privados que direcionam tratamentos menos complexos para setor privado e mais custosos para setor público.

recursos sociais quando estas se responsabilizam por serviços que acabam sendo prestados pelo SUS. Essa dinâmica cria arquitetura perversa, como será visto adiante, onde operadoras podem explorar inércia dos beneficiários e assimetrias informacionais sobre limitações contratuais, externalizando custos para sistema público enquanto mantêm receitas de mensalidades, comportamento que instrumentos regulatórios adequados deveriam coibir.

1.3 A origem e o desenvolvimento da saúde suplementar

A origem dos planos de saúde no país remonta à década de 1930, com a edição da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) durante a Era Vargas e o surgimento dos primeiros institutos de proteção social vinculados ao trabalho formal. Os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), criados por categoria profissional, como o IAPB (bancários) e o IAPC (comerciários), ofereciam assistência médica a seus filiados, financiada por contribuições patronais e dos trabalhadores (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 1985).

Esse modelo, no entanto, excluía a população rural e informal, reforçando desigualdades. A partir dos anos 1960, a unificação dos IAPs no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 1966, centralizou a gestão da saúde previdenciária, mas enfrentou crises de superlotação e insuficiência de serviços. Conforme Fleury (2011), a incapacidade do Estado em atender à demanda por saúde impulsionou a expansão de clínicas e hospitais privados, que passaram a celebrar contratos com o INPS, inaugurando uma relação público-privada.

Martins et al. (2013) descreve que empresários ianques e franceses, que chegaram ao país nos anos de 1950, mostraram-se insatisfeitos com a atenção médica oferecida pelo estado à época. Assim, por iniciativa dos dirigentes das montadoras Ford e General Motors, inspirados na experiência dos Estados Unidos, surgiram os primeiros sistemas de seguros que logo se estenderam as outras empresas. Nesse processo, médicos e prestadores de serviço sentiram a necessidade de facilitar o acesso de maior parcela da população a serviços e tecnologias em saúde cada vez mais onerosa, e certos grupos médicos passaram a organizar formas de pré-

pagamento e divisão dos riscos, embasadas em técnicas atuariais cada vez mais desenvolvidas.

As empresas começaram a oferecer planos de saúde como benefício a funcionários, especialmente em setores urbanizados, dando origem aos planos coletivos empresariais. A partir da década de 1970, consolidou-se o modelo de medicina de grupo, com empresas como a Amil (1978) e a Bradesco Saúde (1986), que ofereciam cobertura médica mediante pagamento mensal. Essas iniciativas foram impulsionadas pela urbanização acelerada e pela demanda de classes médias por serviços mais ágeis que os oferecidos pelo sistema público. Contudo, como ressalta Paim (2013), a mercantilização da saúde aprofundou a segmentação, criando um sistema dual que seria universal na teoria, mas excludente na prática.

De acordo com Lima (2016, p. 113), em paralelo à demanda crescente por serviços de assistência à saúde prestados por empresas de medicina de grupo, intensificou-se a insatisfação histórica da classe médica diante do que denominavam mercantilização da medicina. Os médicos, em sua maioria, discordavam especialmente do valor da remuneração pago pelas empresas de medicina de grupo e da consequente proletarização dos profissionais da área. Em resposta a esse cenário, surgiram as primeiras cooperativas médicas no Brasil e na América Latina, destacando-se a criação da União dos Médicos-Unimed. O movimento teve início na cidade de Santos, litoral paulista, sob a liderança do médico ginecologista Dr. Edmundo Castilho, responsável pela fundação da primeira cooperativa, posteriormente denominada Unimed Santos, em 18 de dezembro de 1967 (LIMA, 2016).

O setor privado atende atualmente principalmente à população economicamente mais favorecida e concentra-se nas regiões mais ricas do país, como o Sudeste, onde a cobertura pode atingir 70% em cidades industrializadas (VECINA, 2024). Essa concentração na cobertura nos grandes centros urbanos, nas regiões Sudeste e Sul, cria dois países diferentes quando falamos de acesso à saúde privada. A desigualdade na distribuição de renda regional funciona então como uma barreira real para que a população mais pobre dessas regiões adquira cuidados de saúde (CAMBOTA; ROCHA, 2015). O resultado? As pessoas ficam ainda mais dependentes do SUS. Curiosamente, foi justamente a necessidade de se evitar o então lento e ineficaz sistema público de saúde que criou condições para a edificação

do sistema complementar. O formato da saúde complementar no Brasil acabou assim se consolidando de forma bastante singular em relação ao contexto internacional. Isso porque, não obstante haja países onde os planos de saúde duplicam a cobertura dos usuários – a exemplo de Reino Unido, Irlanda, Nova Zelândia, Itália e Portugal – a peculiaridade brasileira é que aqui o uso majoritário dos serviços se dá na rede particular, com a utilização do plano, em detrimento da oferta de serviços pelo SUS (OCDE, 2025).

2 OS DESAFIOS DA REGULAÇÃO DA SAÚDE SUPLEMENTAR

2.1 A regulação infraconstitucional do setor de saúde suplementar

A Lei n. 9.656/98 estabeleceu regras para o funcionamento das operadoras e a proteção dos beneficiários. A lei estabeleceu regras inéditas para as operadoras de planos de saúde, impondo novos rigores para a autorização de funcionamento e de operação delas. As operadoras passaram a estar sujeitas à intervenção e até liquidação, sempre que houver riscos à solvência de suas obrigações. A lei também inovou ao instituiu uma série de novas garantias ao consumidor, como a cobertura integral obrigatória, a proibição de cláusulas contratuais de exclusão por idade, a criação de prazos máximos de carência e o controle de reajustes das mensalidades.

Antes da Lei n. 9.656/98, apenas o Decreto-Lei n. 73/66 regia a assistência privada à saúde, por meio do sistema nacional de seguros privados. Para além do seguro-saúde, o normativo já admitia a existência das Medicinas de Grupo (art. 135). Enquanto entidades sem fins lucrativos, organizadas por médicos e estabelecimentos de saúde, podiam prestar serviços por meio de modelo de pré-pagamento. Já o seguro-saúde seria um típico contrato de seguro, para a cobertura de riscos na assistência à saúde em rede escolhida pelo usuário, a medicina de grupo seria prestada de acordo com a rede de cobertura prevista no contrato, e com uma contraprestação pelos serviços paga em dinheiro, de forma periódica.

De acordo com Gregori (2019), a nova lei regulamentou os planos de saúde segundo três aspectos principais: a) o institucional, com previsão de regras sobre entrada, permanência e saúde das operadoras de saúde no setor; b) econômico-financeiro, estabelecendo regras sobre a liquidez; e c) assistencial, definindo as relações dos seguros privados com o usuário, como cobertura, rede credenciadas, carências, reajustes, doenças e outras regras sobre o cumprimento das cláusulas contratuais.

O processo de regulamentação se completou com a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Lei nº 9.961/00⁶, que marcou um divisor de águas na regulação do setor privado de saúde no Brasil⁷. A sua origem está ligada à transferência de competências regulatórias antes dispersas em órgãos como o Ministério da Saúde e a Secretaria de Direito Econômico (MONTONE, 2004). Surgida em um contexto de reformas neoliberais dos anos 1990⁸, que priorizavam a redução do Estado e o fortalecimento de modelos regulatórios, a ANS surgiu como parte de uma estratégia política mais ampla de modernização administrativa, inspirada no modelo das agências reguladoras norte-americanas⁹. O contexto político foi marcado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, com foco na reestruturação da Administração Pública e na regulação de setores econômicos¹⁰, trabalho este pautado por reformas neoliberais para promover competição e eficiência.

Nohara (2012) indica que o estabelecimento de um sistema de agências reguladoras atendeu aos objetivos da chamada Reforma Administrativa, que buscou melhorar o desempenho das atividades administrativas com foco nos resultados na prestação de serviços públicos, a exemplo das avaliações de desempenho por meio

⁶ A agência reguladora foi criada pela Medida Provisória nº 1.928/99, reeditada pela Medida Provisória nº 2.012-2/99 e depois convertida na Lei nº 9.961/00.

⁷ Antes da ANS, o setor era regulado de forma fragmentada, com supervisão limitada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), o que gerava ineficiências.

⁸ No Brasil, as reformas neoliberais dos anos 1990 materializaram-se por meio de uma série de medidas estruturais que visavam à modernização da economia e à inserção competitiva do país no mercado globalizado, sendo implementadas de forma sistemática durante os governos Collor, Itamar Franco e especialmente Fernando Henrique Cardoso (PEREIRA, 2022).

⁹ Cardoso (2016) desenvolve estudo comparado sobre tratamento dado às agências reguladoras no Estado reformado, analisando direito inglês, norte-americano, francês e da União Europeia, demonstrando que modelo brasileiro, embora inspirado em experiências estrangeiras, apresenta particularidades decorrentes de nosso sistema constitucional de separação de poderes. O autor esclarece que poder normativo atribuído às agências se caracteriza como competência para editar regulamentos que traduzam conceitos técnicos, mas sempre adstrito aos parâmetros (*standards*) estabelecidos em lei formal. Crucialmente, Cardoso sustenta que a amplitude desse poder dependerá do vínculo de sujeição entre agência e pessoa submetida à normatização: agências reguladoras de prestação de serviços públicos, em função da supremacia especial, possuem poder normativo mais amplo para restringir direitos e garantias fundamentais dos administrados; em contrapartida, competência normativa de agências reguladoras de atividade econômica liga-se por vínculo de supremacia geral que não justifica maior ingerência no campo dos direitos fundamentais. No caso da ANS, essa distinção revela-se complexa pois a mesma regula simultaneamente prestação de serviços de interesse público por operadoras privadas (dimensão de serviço público) e aspectos concorrenciais de mercado (dimensão de atividade econômica), exigindo cuidadosa ponderação sobre limites de seu poder normativo para garantir respeito ao princípio da legalidade, núcleo essencial dos direitos fundamentais e proporcionalidade.

¹⁰ O estudo da regulação econômica não é o foco desta pesquisa, contudo, entender os fundamentos da regulação setorial é fundamental e ancora o estudioso em bases sólidas para a compreensão do contexto de mercado e seus reflexos sobre os demais agentes econômicos. Sobre o tema, recomenda-se a leitura de Calixto Salomão filho, Alexandre Santos de Aragão, Floriano de Azevedo Marques neto.

de contratos de gestão, a criação de escolas de governo, e a intensa privatização observada no período. Particularmente, o contexto de criação da ANS ao escopo relacionado à busca de melhor eficiência e modernização do aparelho de Estado, a exemplo da criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), onde se buscava um padrão de agência capaz de fiscalizar padrões de oferta e qualidade de serviços e monitoramento de preços, operando em mercados mais abertos e competitivos (LAZZARINI, 2006).

A Lei 9.961/00 estabeleceu a ANS como autarquia especial, com autonomia administrativa, financeira e técnica, vinculada ao Ministério da Saúde. Dessa forma, a agência passou a realizar com liberdade a gestão de seus recursos humanos e financeiros, além de gozar de autonomia nas decisões técnicas e possuir mandatos fixos para seus dirigentes. Essas características refletem o modelo de agência reguladora independente, inspirado em experiências internacionais, como as agências reguladoras americanas e da Europa, adaptadas ao contexto brasileiro.

A lei de criação estabeleceu um modelo híbrido, combinando autonomia técnica com vinculação ao Ministério da Saúde, estrutura que buscava equilibrar independência operacional e alinhamento às políticas públicas. A ANS começou suas atividades com uma diretoria inicial composta por Januário Montone, diretor-presidente; João Luís Barroca de Andrea, diretor de Normas e Habilitação de Produtos; Solange Beatriz Palheiro Mendes, diretora de Normas e Habilitação de Operadoras; Maria Stella Gregori, diretora de fiscalização; e Luís Arnaldo Pereira da Cunha, diretor de Gestão (LIMA, 2016).

Na esfera política, a ANS enfrentou desde seu início pressões de grupos empresariais e médicos, evidenciadas na composição de sua Câmara de Saúde Suplementar (Camss), órgão de caráter permanente e consultivo previsto no parágrafo único do art. 5º da Lei n. 9.661/00, com a previsão de assentos para operadoras, prestadores e usuários, conforme relação mínima de representantes previstas no art. 13 da lei. Atualmente, contudo, a Camss mostra assimetria participativa já que operadoras mantêm representação organizada, enquanto os consumidores participam de forma esparsa, a levantar questionamentos sobre o equilíbrio de forças. O Ministério Público Federal, por exemplo, só foi integrado à Camss posteriormente, por ato infralegal da agência (RN ANS n. 402, de 04/03/2016).

A missão regulatória da ANS é complexa. No dizer do art. 3º da Lei n. 9.961/00, a agência deve promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Deve atuar assim de forma estrutural no setor, com preocupação econômica e assistencial, o que se vê refletido na disparidade de temas previstos em suas Resoluções Normativas, que vão desde instrumentos como o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e o Índice de Reclamações Consolidados (IRC), até ferramentas que buscam conciliar os direitos dos usuários à sustentabilidade financeira das operadoras.

Com efeito, a ANS cumpre papel estratégico na mediação entre interesses públicos e privados no complexo sistema de saúde brasileiro. Sua missão regulatória, portanto, mantém-se atual e precisa estar no eixo das atividades da agência. Esse desenho institucional necessariamente reflete uma tensão entre os interesses econômicos poderosos do setor de saúde privado e a pressão social por maior controle estatal, de modo que a agência restou incumbida de ordenar um mercado antes marcado por práticas abusivas e falta de padrões mínimos de qualidade. A estruturação da agência permite assim uma atuação multifacetada, desde a análise de reajustes de mensalidades até a fiscalização de rede credenciada, com equipes técnicas dedicadas a áreas específicas como tecnologia da informação, comunicação e análise de dados.

De modo geral, as leis dos planos de saúde e de criação da ANS serviram como marco regulatório para o setor, trazendo inovações como a cobertura obrigatória para procedimentos de alta complexidade e a proibição de rescindir contratos por uso frequente do plano, medidas estas sem paradigma nacional ou internacional (MONTONE, 2004). Além disso, houve a introdução de conceitos como o plano-referência, coberturas mínimas e direitos dos beneficiários.

Um aspecto ainda pouco difundido da trajetória da ANS é o seu rápido papel transformador no segmento. Por exemplo, no ano de 2004, a agência já era conhecida pelo público e operava fortemente no segmento de fiscalização e monitoramento das operadoras, tendo realizado 14.623 fiscalizações, sendo que 14.162 se referiam a fiscalizações reativas realizadas a partir de 16.619 denúncias, recebidas na sua maioria, por meio do Disque ANS – Central 0800 (ANS, 2005). No mesmo ano, o

programa “Olho Vivo”, um modelo inovador de ação fiscalizadora, foi responsável pela realização de 207 fiscalizações proativas, que consistem em ações sistemáticas e planejadas junto às operadoras para verificar o cumprimento das disposições legais para o setor, e que atingiram 83% da meta estabelecida, acima inclusive do índice de certificação de cumprimento da meta do Contrato de Gestão firmado à época com o Ministério da Saúde (ANS, 2005). Outra mudança orientada a partir da criação da ANS se deu com a migração da população dos planos antigos para os novos. Enquanto em 2001, apenas 30% dos beneficiários estavam vinculados aos novos planos, em 2003 esse percentual já chegava a 36% (MONTONE, 2004).

Por volta do ano 2008, parece surgir um novo momento em que a ANS passa a impulsionar o aumento da concorrência, da transparência e do nível de informação ao beneficiário, buscando promover a redução na assimetria de informação¹¹ no setor. Com isso, os projetos de mobilidade com portabilidade de carências, a questão da acreditação, da qualificação das operadoras e prestadores, e do fundo garantidor, constituem projetos que estão inseridos no contexto da Política de Qualificação da Saúde Suplementar e do Programa Mais Saúde (PAC Saúde) e definem as principais linhas de atuação do órgão regulador da saúde suplementar (ANS, 2009).

Mais recentemente, a ANS instituiu um processo de franco fortalecimento da participação social. Essa consolidação regulatória encontrou um marco de maturidade institucional com a promulgação da Lei nº 13.848/2019 (Lei Geral das Agências Reguladoras), que não apenas ampliou a tecnicidade da Análise de Impacto Regulatório, mas também institucionalizou o dever de democratização do processo decisório, elevando a participação social a um patamar de requisito de legitimidade da norma. Por meio dos mecanismos de consultas públicas, audiências públicas e tomadas de subsídios, previstos nos artigos 6º a 11 da referida lei, a ANS passou a ampliar seus canais de interlocução com a sociedade civil e os agentes de mercado.

¹¹ A assimetria de informação é uma falha de mercado que ocorre quando uma das partes em uma transação possui mais ou melhores informações do que a outra, levando a decisões ineficientes e a alocações de recursos que não são eficientes. Essa desigualdade informacional pode distorcer o funcionamento dos mercados competitivos, que dependem de informação perfeita para que preços reflitam corretamente custos e benefícios. Os efeitos da assimetria informacional na saúde suplementar serão mais bem compreendidos a seguir.

Em 2024, por exemplo, a agência concluiu 23 Consultas Públicas¹², 9 Audiências Públicas e 4 Tomadas Públicas de Subsídios (ANS, 2025a). Nesse escopo, entraram temas como a revisão da lista de coberturas dos planos de saúde, o programa de acreditação de operadoras, melhorias no relacionamento no âmbito dos SACs/Centrais de atendimento, política de preços e reajustes e linhas de cuidado prioritárias na saúde suplementar (ANS, 2025a).

2.2 A dinâmica do setor e de seus agentes econômicos

Atualmente, o setor suplementar atende mais de 52 milhões de usuários de planos de assistência médica, por meio de aproximadamente 680 operadoras médico-hospitalares. Somente no ano de 2024, o setor registrou 229 bilhões de reais de receitas e foi responsável pela execução de 193 bilhões de reais de despesas assistenciais (ANS, 2025a). Nos últimos anos, o número de agentes econômicos que ofertam planos de saúde vem reduzindo, com registro de forte concentração de mercado, sendo que as 10 maiores operadoras concentram¹³ próximo de 70% do total de beneficiários (CADE, 2021).

¹² Salinas (2021), em análise empírica de 89 mecanismos de participação realizados pela ANS entre 2001 e 2019, documenta que operadoras de planos de saúde são o grupo que mais participa das consultas e audiências públicas, representando 54,2% de todas as contribuições identificadas, fenômeno consistente com teorias da captura regulatória que preveem protagonismo do setor regulado nos processos participativos. Entretanto, a autora identifica que esse protagonismo quantitativo não se traduz necessariamente em favoritismo qualitativo: o percentual de aceitação das contribuições das operadoras (47,4%) é apenas marginalmente superior ao de rejeição (47,6%) e inferior ao de outras categorias como atores governamentais (63,2% de aceitação) e agentes econômicos não regulados (51,9% de aceitação). Do ponto de vista comportamental, essa dinâmica participativa gera arquitetura regulatória onde grupos com maior capacidade de mobilização e recursos técnicos exercem influência desproporcional sobre desenho de normas, potencialmente subrepresentando interesses de beneficiários individuais que enfrentam custos de participação mais elevados e menor coordenação coletiva.

¹³ A estrutura concorrencial do setor de planos de saúde brasileiro revela uma concentração significativa que varia conforme a modalidade de contratação. Andrade et al. (2015), em estudo pioneiro encomendado pela ANS utilizando metodologia baseada em modelos gravitacionais para definição de mercados relevantes geográficos, documentam que 82,42% dos mercados de planos individuais apresentam Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) superior a 2500, patamar classificado pelos guias antitruste norte-americanos como mercado altamente concentrado. Em contraste, mercados de planos coletivos exibem estrutura mais competitiva: apenas 34,38% apresentam HHI acima de 2500, enquanto 22,92% situam-se abaixo de 1500 (desconcentrados) e 42,71% entre 1500-2500 (moderadamente concentrados). Quando as Unimed são tratadas como um grupo econômico único, a concentração em planos coletivos eleva-se dramaticamente para 80,21% dos mercados com HHI superior a 2500.

A verticalização das operações é movimento de importante repercussão nesse mercado, motivado pela busca de eficiência operacional e redução dos efeitos da assimetria informacional por meio da incorporação de redes próprias de prestação de serviços. Takahashi (2022) demonstra empiricamente que operadoras verticalizadas com controle sobre protocolos médicos e utilização de serviços apresentam capacidade superior de endereçar problemas de incentivos perversos na cadeia de saúde suplementar, resultando em sinistralidade mais controlada quando comparadas a modelos tradicionais de rede credenciada. O autor identifica que o setor é composto por complexas relações contratuais que resultam em incentivos perversos nas relações entre os agentes, implicando geralmente na sobreutilização dos serviços e consequentemente nos custos para as operadoras, problemas que a verticalização busca mitigar por meio do alinhamento entre tomador de decisão e responsável pelo pagamento.

Segundo Bagnoli (2023), outra causa a justificar a atual tendência de integração vertical entre as operadoras e prestadores reside no forte incentivo proveniente das normas setoriais expedidas pela ANS, especialmente diante das diretrizes econômico-financeiras para constituição de operadoras. Nesse sentido, a complexidade regulatória estaria a conduzir os agentes em busca de maior eficiência econômica, a a partir da redução dos custos de transação e obtenção de maiores margens para lidar com o plexo de exigências típico do setor.

As operadoras são pessoas jurídicas constituídas sob a forma de sociedade civil ou comercial, cooperativa ou entidade de autogestão, que tem como atividade principal a operação, comercialização ou disponibilização de planos de assistência à saúde. Elas são classificadas em modalidades específicas, nos termos da Resolução Normativa ANS n. 531, que dispõe sobre a definição, a segmentação e a classificação das operadoras de planos de assistência à saúde. A norma define e padroniza a segmentação das operadoras de planos de saúde, categorizando-as segundo sua natureza jurídica e modalidade operacional. A resolução normativa também estabelece critérios claros para a classificação das operadoras, considerando aspectos como porte, área de atuação e modelo de prestação de serviços. Essa classificação é essencial para a aplicação de regras específicas de solvência financeira e provisionamento técnico, adaptadas às características de cada

operadora, o que visa assegurar a sustentabilidade econômica do setor e a proteção dos beneficiários.

As chamadas autogestões, que são criadas por empresas, sindicatos ou associações, não têm na saúde uma atividade-fim (SILVIA, 1998), para atender exclusivamente seus funcionários, dependentes ou associados. Elas não têm fins lucrativos e focam na gestão direta dos recursos, muitas vezes mantendo uma rede própria de atendimento ou contratando serviços terceirizados. A vantagem parece advir do alinhamento com as necessidades específicas do grupo atendido, mas a dependência financeira da entidade mantenedora pode ser um risco em cenários de crise econômica.

As cooperativas médicas são formadas por médicos associados, cujo objetivo principal é oferecer serviços de saúde diretamente pelos próprios cooperados. Regidas pela Lei nº 5.764/1971 (que define o cooperativismo no Brasil), elas priorizam a autogestão e a participação democrática dos membros. Esse modelo costuma ser vantajoso por reduzir custos administrativos, mas pode limitar a cobertura a especialidades disponíveis entre os cooperados.

As entidades de filantropia são instituições sem fins lucrativos, geralmente ligadas a organizações religiosas ou beneficentes, que oferecem planos de saúde como parte de sua missão social. Essas operadoras frequentemente operam hospitais e clínicas próprios, como os mantidos pela Santa Casa de Misericórdia, e destinam parte de seus recursos para atender populações vulneráveis, além de seus beneficiários. A certificação como entidade beneficente (Cebas) permite isenções fiscais, o que ajuda na sustentabilidade financeira, mas a gestão pode ser desafiadora devido à necessidade de equilibrar objetivos sociais e econômicos.

A medicina de grupo é composta por empresas ou entidades que operam serviços de assistência à saúde. Elas se distinguem por sua estrutura empresarial, com gestão profissionalizada e foco em escala. Diferentemente das cooperativas, os médicos dessas operadoras são contratados ou credenciados, e não sócios, o que permite maior controle sobre os processos assistenciais. As empresas de medicina de grupo celebram contratos de pré-pagamento, onde seus prestadores estão vinculados geralmente por contratos coletivos firmados entre empresas contratantes ou por contratos individuais e familiares (SILVA, 1998). Em 2025, 241 empresas operam sob

a modalidade de medicina de grupo, alcançando uma população de mais de vinte milhões de pessoas¹⁴.

Por fim, as seguradoras especializadas em saúde também integram o setor de saúde suplementar, operando mediante a contratação de uma rede credenciada e o reembolso de despesas. De acordo com a Lei n. 10.185/01, as sociedades seguradoras poderão operar o seguro enquadrado no art. 1º, inciso I e § 1º, da Lei n. 9.656/98, desde que estejam constituídas como seguradoras especializadas nesse seguro, devendo seu estatuto social vedar a atuação em quaisquer outros ramos ou modalidades. No seguro-saúde, busca-se apenas o ressarcimento das despesas ocorridas com o tratamento médico, como honorários, despesas hospitalares e exames, de acordo com o ajustado no contrato (SCAFF, 2010, p.45).

As operadoras de planos privados de assistência à saúde são obrigadas a oferecer todos os procedimentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente, para atendimento da cobertura prevista nos artigos 10, 10-A, 10-B, 10-C e 12, da Lei nº 9.656/1998, de acordo com a segmentação assistencial, área geográfica de abrangência e área de atuação do produto dentro dos prazos máximos de atendimento previstos na Resolução Normativa - RN nº 566/2022, observado o cumprimento dos prazos de carência e/ou cobertura parcial temporária.

As modalidades de planos de saúde são regulamentadas pela ANS e podem ser divididas em três tipos principais, além de diversas outras variações, relacionadas à cobertura e forma de pagamento. Os planos individuais ou familiares são aqueles contratados diretamente por uma pessoa física, seja para si mesma (individual) ou para sua família (familiar). Eles oferecem cobertura para consultas, exames, internações e outros serviços médicos, dependendo do contrato. São menos comuns atualmente, pois muitas operadoras deixaram de oferecê-los devido a custos e regulamentações mais rígidas. Qualquer pessoa física interessada pode contratar, sem necessidade de vínculo com empresas ou associações.

Os planos coletivos empresariais são aqueles oferecidos por empresas aos seus funcionários e, em alguns casos, aos dependentes destes. Eles geralmente têm

¹⁴ ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sala de Situação (BI). Disponível em: https://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Perfil_setor/sala-de-situacao.html. Acesso em: 15 jun. 2025.

custos mais acessíveis e coberturas amplas, já que o risco é diluído entre um maior número de beneficiários. São uma das modalidades mais comuns no setor. Já os planos coletivos por adesão são disponibilizados por entidades de classe, como sindicatos, associações profissionais ou conselhos regionais, para seus membros. Eles permitem que pessoas com interesses ou profissões em comum se unam para contratar um plano com condições mais vantajosas do que os individuais. Assim, membros afiliados a essas entidades podem contratar, como profissionais de uma categoria específica (ex.: médicos, advogados).

Existem, contudo, diversas variações importantes para quem busca escolher um plano de saúde no setor. Os planos de saúde podem variar em aspectos como a cobertura, havendo planos ambulatoriais, que inclui consultas e exames, hospitalar (com ou sem obstetrícia), que inclui internações, e odontológica, com focada em tratamentos dentários, podendo ser contratada separadamente ou junto com um plano médico. Ainda com relação à cobertura, os planos apresentam diferentes dimensões de redes assistenciais, que podem ser nacional, estadual, grupo de estados, municipal ou grupo de municípios. A relação dos prestadores também varia bastante de produto para produto, sendo comum que o atendimento em hospitais com ótima referência ou de alto padrão sejam restritos aos planos de saúde mais caros.

Uma opção que costuma encarecer ainda mais o plano é a possibilidade de livre escolha com opção de reembolso, onde o beneficiário não fica adstrito à lista de prestadores fornecidos pela operadora. No que tange à contraprestação paga, esta costuma ser desembolsada pelo contratante pessoa jurídica no caso dos planos coletivos e exclusivamente pelos beneficiários em casos de planos individuais e familiares. Não obstante as operadoras estejam obrigadas a custear quaisquer eventos de saúde, sem limite financeiro, uma variação importante nas ofertas de planos diz respeito à possibilidade de a operadora disponibilizar produtos com mecanismos financeiros de regulação, tais como a franquia e a coparticipação. A franquia, muito aplicada no mundo dos seguros, estabelece um valor referência mínimo a ser custeado pelo beneficiário, antes da operadora arcar com o valor restante. Na coparticipação, o beneficiário paga uma mensalidade fixa mais baixa, mas contribui com uma parte do custo (coparticipação) cada vez que utiliza um serviço, como consultas ou exames

Os prestadores de serviços são outro elo fundamental na cadeia da saúde suplementar, responsáveis diretos pela execução das atividades-fim relacionadas ao atendimento dos beneficiários dos planos de saúde. São eles que realizam consultas médicas, exames diagnósticos, internações hospitalares e procedimentos terapêuticos diversos. Nessa categoria incluem-se hospitais, clínicas, laboratórios de análises clínicas e medicina diagnóstica, além dos profissionais de saúde como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos (AZEVEDO et al., 2016).

Os hospitais desempenham papel central no atendimento à saúde suplementar, absorvendo parcela significativa das despesas assistenciais das operadoras. Aproximadamente 41% dos gastos assistenciais das operadoras são destinados às internações hospitalares (AZEVEDO et al., 2016). Os hospitais podem ser próprios das operadoras ou credenciados por elas, sendo comum a existência de redes mistas. A distribuição geográfica desses estabelecimentos apresenta desigualdade regional, com maior concentração nas regiões Sul e Sudeste do país.

Outro grupo relevante são os laboratórios e estabelecimentos de medicina diagnóstica, responsáveis por exames laboratoriais e por métodos diagnósticos por imagem. Esses serviços representam cerca de 21% das despesas assistenciais das operadoras (AZEVEDO et al., 2016). A evolução tecnológica nesse segmento tem sido acelerada e frequentemente associada ao aumento dos custos assistenciais, devido à incorporação constante de novos equipamentos e técnicas mais sofisticadas (CAMPANA; OPLUSTIL; FARO, 2023).

A cadeia da saúde suplementar envolve ainda uma complexa rede de agentes interrelacionados, cujas funções e interações determinam a dinâmica do setor. Além da ANS, das operadoras, prestadores e consumidores, o setor tem verificado o destaque de diversos outros atores, cujas relações econômicas e sociais são intrinsecamente com os agentes mais populares. A indústria farmacêutica e os fabricantes de equipamentos médicos fornecem amplamente medicamentos, dispositivos e tecnologias essenciais para a prestação dos serviços de saúde. Os conselhos profissionais como o Conselho Federal de Medicina (CFM) atuam no setor a partir da fiscalização da atuação dos especialistas e da edição de normas técnicas sobre o exercício profissional, e as sociedades médicas especializadas (Sociedade Brasileira de Cardiologia) emitem diretrizes clínicas que influenciam protocolos assistenciais.

Essa multiplicidade de agentes cria relações assimétricas de poder e de informação, exigindo mecanismos regulatórios que equilibrem interesses econômicos, sustentabilidade do sistema e proteção aos direitos fundamentais à saúde¹⁵.

2.3 Os falhas de mercado no setor de saúde suplementar

A construção histórica das relações entre os agentes da saúde suplementar nunca foi fácil, notadamente diante da complexidade dos arranjos, dos desafios regulatórios e do extenso número de agentes movidos por interesses próprios.

Sob a perspectiva do consumidor, os serviços prestados costumeiramente não observam a vulnerabilidade do usuário, que se depara com negativas de coberturas nos momentos de maior fragilidade. Além disso, o usuário é constantemente submetido a cláusulas contratuais desfavoráveis, em contratos de adesão, com possibilidade de rescisão unilateral por parte da operadora e de reajustes nas mensalidades em patamares superiores à inflação geral dos preços. De outro lado, as operadoras de planos de saúde se queixam do aumento geral dos custos, associados ao envelhecimento da população, das altas taxas de judicialização do setor¹⁶¹⁷ e da

¹⁵ É exatamente na tensão entre a livre iniciativa das grandes corporações do setor e a extrema vulnerabilidade cognitiva e informacional dos beneficiários que se insere o debate central da linha de pesquisa 'O Poder Econômico e seus Limites Jurídicos'. Conforme amplamente problematizado e debatido no curso de mestrado no Mackenzie, o Direito Político e Econômico contemporâneo não visa à supressão do mercado, mas à arquitetura de limites jurídicos que corrijam o abuso do poder econômico corporativo. Neste contexto, as ferramentas da economia comportamental e a regulação por nudges despontam não apenas como teorias estrangeiras, mas como verdadeiros limites jurídicos de baixo custo e alta eficácia para mitigar essas assimetrias de poder estruturais do setor.

¹⁶ A judicialização da saúde suplementar apresenta dimensão frequentemente negligenciada. Yeung (2020) alerta que decisões judiciais que concedem coberturas além do rol da ANS ou que ignoram consequências econômicas sistêmicas sobre sustentabilidade do setor podem gerar efeitos bumerangue, onde beneficiários aparentemente favorecidos por sentenças individuais sofrem posteriormente com aumento generalizado de preços, restrições contratuais ou até saída de operadoras do mercado. A autora inclusive destaca que juízes, assim como consumidores, estão sujeitos a vieses comportamentais: heurística da disponibilidade leva magistrados a sobrevalorizar casos dramáticos publicizados, viés de confirmação reforça narrativas pré-existentes sobre operadoras "vilãs", e ausência de feedback sobre consequências de longo prazo impede aprendizado institucional. A regulação deve, portanto, considerar não apenas comportamento de consumidores e operadoras, mas também de agentes judiciais cujas decisões atomizadas geram externalidades agregadas significativas sobre arquitetura do setor.

¹⁷ Gleicher (2023), em pesquisa empírica dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça entre 2020 e 2022, documenta que 90% das demandas judiciais em saúde envolvem planos privados, contra apenas 10% relacionadas ao SUS, apesar de a saúde suplementar atender somente 25% da população

velocidade de incorporação de novas tecnologias ao rol de coberturas obrigatórias. Um exemplo comparativo demonstra que a saúde suplementar gasta aproximadamente 193 bilhões para o atendimento de 25% da população (ANS, 2025a), enquanto o orçamento anual federal para o SUS é de 231 bilhões¹⁸, com vistas a atender 75% da população.

O setor da saúde suplementar pode ser estudado a partir das contribuições de renomados estudos econômicos sobre o segmento do seguro-saúde. O primeiro grande estudo e considerado o marco fundador da disciplina conhecida como a economia da saúde é o artigo “Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care”, escrito por Kenneth J. Arrow (1963). Arrow, ganhador do prêmio Nobel de economia, utilizou-se da teoria econômica clássica, especialmente sobre a teoria do equilíbrio competitivo, para demonstrar que o mercado de saúde americano não poderia ser tratado como um mercado comum.

Para compreender essa excepcionalidade, faz-se necessário definir o conceito estrutural de “falhas de mercado”. Sob a ótica da teoria neoclássica, mercados verdadeiramente competitivos operam sob pressupostos ideais — como a multiplicidade de agentes (compradores e vendedores), livre entrada e saída, ausência de externalidades e, sobretudo, informação perfeita —, alcançando, por si sós, a alocação eficiente de recursos (POLINSKY, 1989). Contudo, quando um ou mais desses pressupostos não se sustentam na realidade fática, configuram-se as falhas de mercado. Tais falhas representam situações em que o livre mecanismo de preços não consegue promover a eficiência alocativa, resultando em perdas de bem-estar social. No âmbito do *Law and Economics*, a presença dessas falhas desponta como a principal justificativa teórica e jurídica para a intervenção estatal e para a instituição de regulações.

brasileira. Esta desproporção revela maior acesso à justiça dos beneficiários de planos de saúde em comparação aos usuários do sistema público em situações idênticas, evidenciando que a judicialização funciona como mecanismo de distribuição desigual de recursos conforme capacidade de acionar o Poder Judiciário. A autora identifica que 62% dos recursos foram favoráveis aos beneficiários contra 37% favoráveis às operadoras, padrão similar ao observado nas demandas do SUS (60% favoráveis aos usuários).

¹⁸ Presidente sanciona Lei Orçamentária Anual de 2024, que prevê equilíbrio fiscal e responsabilidade social. Disponível em: <https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/noticias/2024/fevereiro/presidente-sanciona-lei-orcamentaria-anual-de-2024-que-preve-equilibrio-fiscal-e-responsabilidade-social>. Acesso em: 07 out. 2025.

É exatamente nesse ponto que reside a ideia central de Arrow (1963): as incertezas inerentes ao setor de saúde causam falhas de mercado agudas e específicas, a exemplo da incerteza da doença e da incerteza do tratamento. De acordo com o autor, a condição de mercado perfeitamente competitivo inexistente na saúde, visto que mesmo a atuação concorrente dos agentes é incapaz de gerar resultados eficientes e equitativos ao mercado. Dentre as falhas de mercado, Arrow considera a assimetria de informação a mais grave, onde, por exemplo, o médico (ou prestador) costuma saber muito mais sobre a doença, o diagnóstico e o tratamento do que o paciente (o consumidor), violando a premissa de que o consumidor é soberano e perfeitamente informado.

A assimetria informacional nos contratos de planos de saúde manifesta-se estruturalmente por meio da incompletude contratual intrínseca. Forgioni (2018) demonstra que contratos empresariais são inevitavelmente incompletos porque partes não conseguem prever todas as contingências futuras relevantes, e custos de transação para discutir todos os cenários possíveis frequentemente excedem benefícios de maior especificação. Na saúde suplementar, essa incompletude agrava-se drasticamente: beneficiários carecem de conhecimento técnico para avaliar adequadamente coberturas, procedimentos evoluem tecnologicamente tornando cláusulas contratuais rapidamente obsoletas, e patologias futuras que determinarão necessidades assistenciais são intrinsecamente imprevisíveis no momento da contratação. A autora ressalta que assimetria informacional pode decorrer de "sonegação de informações pelas partes que desejam obter vantagens na negociação, impossibilidade de compreensão por uma das partes da informação transmitida pela outra, ou economia nos custos de transação", todas dinâmicas observáveis nos contratos de planos de saúde.

Na saúde suplementar, a demanda é sempre tida como irregular e imprevisível, sendo impossível planejar ou orçar a necessidade de um serviço, o que justifica a existência de um mecanismo de mutualização de risco: o seguro (ARROW, 1963). Ele justificou assim o desenvolvimento de instituições não-mercado (como o seguro de saúde, a regulamentação governamental, e o papel de confiança e ética na relação médico-paciente) para mitigar os efeitos dessas incertezas.

O autor explora ainda a ideia do risco moral (*moral hazard*), pontuando que mesmo a presença do seguro (solução para a incerteza) nos leva a novos problemas,

visto que, uma vez segurados, os pacientes e até os médicos tendem a consumir mais serviços do que consumiriam se tivessem que pagar o custo total, levando ao uso excessivo de recursos. Outro problema derivado seria a produção de um desalinhamento de incentivo, na medida em que, sem uma adequada intervenção, o mercado privado forneceria menos prevenção do que o socialmente desejável. Com efeito, o exemplo clássico de risco moral ainda ocorre no mercado de seguros, quando o segurado, protegido pela apólice, age de forma mais arriscada (ex.: dirigir imprudentemente). A solução para o risco moral frequentemente não é fácil na prática porque o segurador não pode monitorar o comportamento do segurado de forma simples, com baixo custo (POLINSKY, 1989).

Posteriormente, outro notável economista, George A. Akerlof¹⁹ (1970), apresentou o artigo “The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, onde o conceito de assimetria de informação é desenvolvido para ilustrar como desequilíbrios informacionais entre compradores e vendedores podem levar a falhas de mercado, incluindo a seleção adversa (*adverse selection*). No aludido artigo, Akerlof analisa o mercado de carros usados nos Estados Unidos, onde vendedores detêm mais informações sobre a qualidade dos veículos do que os compradores, resultando em uma predominância de produtos de baixa qualidade (“limões”) e na consequente retração do mercado, com redução de preços, quantidade e interesse dos compradores (AKERLOF, 1970). As conclusões de Akerlof estendem-se diretamente ao setor de seguros de saúde, incluindo a saúde suplementar, ao explicar como informações ocultas geram ineficiências econômicas e sociais, exigindo-se assim intervenções regulatórias para mitigar impactos negativos.

Em síntese, enquanto o risco moral estaria associado ao comportamento pós-contratual, a seleção adversa ocorreria *ex ante*, quando consumidores de alto risco ocultariam informações sobre sua saúde, dificultando que operadoras precifiquem prêmios de forma precisa, o que leva a uma espiral de aumento de custos e exclusão de indivíduos de baixo risco, similar ao mercado de carros onde apenas “limões” permanecem viáveis. Por exemplo, em um mercado competitivo com consumidores de alto e baixo risco, as operadoras ajustariam planos e preços para atrair perfis lucrativos, potencialmente excluindo grupos vulneráveis e gerando perdas de bem-

¹⁹ Akerlof também foi posteriormente laureado com o prêmio nobel de economia.

estar social. Neste cenário de desafios intrínsecos ao próprio setor, podemos observar que o atual estágio de consolidação do segmento da saúde suplementar no Brasil ainda se notabiliza pela existência de muitas fontes de ineficiência, que impedem que o sistema de livre mercado produza resultados desejáveis, gerando problemas que se manifestam a partir da insatisfação dos diversos agentes envolvidos.

Um problema central é o desalinhamento na cadeia de incentivos, que não se encontra estruturada de modo a repelir comportamentos inoportunos ou até prejudiciais. Por certo, as características intrínsecas ao mercado de seguro de saúde, como a incerteza da demanda, a presença de externalidades e, sobretudo, a acentuada assimetria de informação, contribuem para os desafios vistos no setor da saúde suplementar. A primeira demonstração de que os agentes não caminham na direção de uma alocação eficiente de recursos exsurge dos incentivos criados em um ambiente onde haja assimetria informacional. O usuário, por exemplo, ao contratar um plano de saúde, pode ser incentivado a mudar de comportamento, alterando hábitos referentes à sua saúde e com isso aumentando a probabilidade de evento de saúde a ser custeado pela operadora. A distorção costuma ser explicada devido ao fato de o usuário coberto pelo plano sempre pagar apenas uma fração dos custos da assistência médica (prêmio e co-participações), criando assim um risco de sobreutilização.

Em lógica similar, a proteção oferecida por um plano de saúde tende a ser mais atraente perante aqueles que já possuem maior risco de acesso, aproximando idosos e vulneráveis com alta propensão de utilização de serviços médicos enquanto os mais jovens não percebem o valor desta proteção com o mesmo apelo. A operadora de planos de saúde, via de regra, está impedida de operar qualquer gerenciamento em relação a estes riscos, restando vedada qualquer prática discriminatória em atenção ao estado de saúde ou a dados genéticos disponíveis (TIROLE, 2020).

Diante deste cenário complexo de falhas de mercado estruturais, desalinhamento de incentivos e comportamentos oportunistas que caracterizam a saúde suplementar brasileira, emerge com clareza a necessidade de fundamentação teórica robusta que permita compreender não apenas as causas dessas ineficiências, mas também os mecanismos por meio dos quais a regulação estatal pode intervir para corrigi-las ou mitigá-las. Precisamente neste ponto situa-se o valor instrumental do *law and economics*, abordagem analítica que fornece ferramentas conceituais e

metodológicas para examinar como as regras jurídicas podem ser desenhadas e implementadas de forma a promover maior eficiência alocativa, reduzindo custos de transação e realinhando incentivos dos diversos agentes no sentido de resultados mais socialmente desejáveis.

3 AS CONTRIBUIÇÕES DO *LAW AND ECONOMICS* SOBRE A REGULAÇÃO DA SAÚDE SUPLEMENTAR

3.1 Introdução ao *law and economics*

Antes de adentrarmos as minúcias que permeiam a arquitetura de escolha dos beneficiários e a atuação das operadoras de planos de saúde, é imperioso estabelecer a lente teórica sob a qual a regulação da saúde suplementar brasileira será analisada: o *Law and Economics*. O setor de saúde privada, caracterizado por falhas de mercado agudas, externalidades e profunda assimetria informacional, não pode ser avaliado em sua completude apenas pela exegese jurídica tradicional. Nesse contexto, o *Law and Economics* fornece o instrumental analítico basilar para compreender como as normas e os instrumentos regulatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) funcionam não apenas como comandos sancionatórios, mas como um complexo sistema de incentivos desenhado para induzir a eficiência alocativa e moldar o comportamento dos agentes em um mercado de extrema sensibilidade social.

Até a década de 1960, a disciplina do *law and economics* era praticamente sinônima ao direito antitruste²⁰. Com o avanço dos estudos de casos, uma rica fonte de informações sobre práticas empresariais proporcionou a expansão da disciplina sobre outros ramos do direito e da economia (POSNER, 2011; COOTER; ULEN, 2000). No início, os economistas estavam preocupados com a questão do monopólio e começaram a identificar e documentar acerca da racionalidade econômica e das consequências de tais práticas. Os achados serviram então para estimular fortes implicações no âmbito regulatório, especialmente diante da investigação do comportamento dos participantes em mercados econômicos. Além das evidências apontadas pelo antitruste, de acordo com Posner (2011), é possível reconhecer ainda esforços antecedentes em trabalhos econômicos sobre direito tributário (Henry

²⁰ O movimento do *law and economics* surgiu em discussões relacionadas ao antitruste. O desenvolvimento dessa abordagem jurídica foi profundamente influenciado por questões econômicas que envolviam práticas anticompetitivas e monopólios, especialmente nos Estados Unidos, onde o antitruste começou a ser formalmente regulamentado com a aprovação do Sherman Act em 1890. Apenas a partir da década de 60 que se notabilizaram os estudos combinados com as disciplinas de responsabilidade civil, contratos e propriedade.

Simons), direito societário (Henry Manne), direito de patentes (Arnold Plant), direito contratual (Robert Hale) e regulação de serviços públicos e transportadoras comuns (Ronald Coase e outros).

O novo *law and economics* (POSNER, 2011), contudo, iniciou-se com os artigos de Ronald Coase sobre custo social²¹ e de Guido Calabresi sobre danos²².

Ronald Coase é uma figura seminal no *law and economics* e seu artigo "The Problem of Social Cost" (1960), publicado no *Journal of Law and Economics*, é um dos mais citados na história da economia e do direito, introduzindo ideias fundamentais sobre incentivos e custos de transação, notabilizando o que restou mundialmente conhecido como a Escola de Chicago²³. O autor foi premiado com o Nobel de Economia em 1991 pelo seu trabalho sobre os custos de transação, tratado no artigo "The Nature of the Firm" (1937) e os direitos de propriedade, abordado no artigo "The Problem of Social Cost" (1960).

Um dos pilares destes artigos fundamentais é o Teorema de Coase, que argumenta que, na ausência de custos de transação, as partes envolvidas em uma

²¹ COASE, Ronald H. The Problem of Social Cost. 3 J. Law & Econ.1(1960).

²² CALABRESI, Guido. Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, 70 Yale L. J. 499 (1961).

²³ No âmbito acadêmico, o marco do law and economics ocorreu nos anos 1950, quando Aaron Director, um economista que lecionou na Faculdade de Direito de Chicago, fundou o Journal of Law & Economics (1958) e colaborou com juristas para analisar questões antitruste sob uma perspectiva econômica. Director havia chegado na Universidade de Chicago com o objetivo de criar um novo centro para estudiosos de direito e economia. As aulas de Director desafiavam a interpretação tradicional do direito, mostrando como conceitos como custos de transação e eficiência de mercado poderiam reformular a jurisprudência.

A Universidade de Chicago, então liderada por Robert Maynard Hutchins, um colaborador próximo de Luhnow na criação da Escola de Chicago, contava com uma forte base de acadêmicos libertários, incluindo Frank Knight, George Stigler, Henry Simons, Ronald Coase e Jacob Viner. Logo a universidade também contaria com Hayek, Milton Friedman (cunhado de Director e amigo de Stigler), Robert Fogel, Robert Lucas, Eugene Fama, Richard Posner e Gary Becker. A concentração desses intelectuais com uma visão de mundo favorável ao livre mercado e à intervenção governamental limitada proporcionou um ambiente intelectual único para o florescimento da Análise Econômica do Direito. A Escola de Chicago passou a influenciar fortemente o pensamento econômico, com destaque à defesa do livre mercado, da eficiência econômica e da análise econômica do direito. Seus princípios fundamentais incluem a crença na capacidade dos mercados de se autorregular, na relevância dos incentivos individuais e na aplicação de ferramentas econômicas para compreender fenômenos sociais, como o comportamento jurídico. Para os autores da Escola, os indivíduos são seres racionais que se comportam, tanto no mercado como fora dele, no sentido de maximizar suas preferências (VORONOFF, 2018). Conhecida por seu rigor analítico, a Escola desafia visões intervencionistas do Estado, argumentando que a intervenção governamental frequentemente resulta em ineficiências. Economistas notáveis como Milton Friedman, George Stigler e Gary Becker foram figuras centrais, contribuindo para sua reputação e impacto em políticas públicas e no pensamento econômico global. De modo geral, a Escola de Chicago desempenhou um papel importante nesse movimento ao argumentar que a eficiência econômica deveria ser o principal objetivo das políticas antitruste, abandonando valores populistas que buscavam limitar a concentração econômica.

externalidade podem negociar entre si para alcançar uma solução eficiente, independentemente de quem detenha os direitos de propriedade. No entanto, na presença de custos de transação significativos — como dificuldades de coordenação ou informação assimétrica —, o sistema jurídico parece tornar-se essencial para definir direitos e responsabilidades que minimizem as ineficiências. O Teorema de Coase mostra assim como a alocação de direitos de propriedade pode resolver externalidades via negociação, desde que os custos de transação sejam baixos. Sua análise destaca o papel dos incentivos na coordenação econômica.

A contribuição maior de Ronald Coase residiu na importância destacada à economia no estudo do direito, com as considerações e formulações da Nova Economia Institucional, deixando no centro do estudo instituições sociais como a empresa o mercado e a norma, de modo a facilitar a compreensão da atividade econômica (SZTJAN, 2005). Coase ressaltou a importância de os operadores do direito dominarem conceitos econômicos e o quanto isso é valioso na análise econômica dos efeitos das normas jurídicas, refinando o próprio estudo do direito.

Guido Calabresi, professor de direito em Yale, é outra figura central no surgimento e desenvolvimento do movimento *law and economics*, sendo a principal figura ligada à chamada Escola de Yale²⁴. Em seu artigo seminal “Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts” (1961), Calabresi introduziu a ideia de que regras de responsabilidade civil podem ser analisadas através de lentes econômicas

²⁴ Em contraponto a Chicago, a Escola de Yale corresponde a uma influente corrente de pensamento jurídico que se destaca por sua abordagem interdisciplinar, crítica e voltada para questões sociais e políticas. Robert Bork, Guido Calabresi e Bruce Ackerman são reconhecidos por suas teorias sobre “justiça como equidade” e o papel do direito em promover a participação cidadã. Outros membros notáveis do corpo docente de Yale com expertise em Direito e Economia incluem Ian Ayres, Robert C. Ellickson, Henry Hansmann, Christine Jolls e Alvin Klevorick.

Não obstante reconheça notável valor à priorização da eficiência econômica e do livre mercado, Yale enfatiza a justiça social, a equidade e o papel do direito como instrumento de mudança social. Essa perspectiva busca integrar ao estudo do direito insights de disciplinas como sociologia, filosofia e ciência política, analisando-o não apenas como um conjunto de normas, mas como uma ferramenta para moldar comportamentos e instituições. Os estudos em Yale defendem uma abordagem normativa e busca a justiça distributiva a partir do reconhecimento da existência de falhas de mercado e a importância de considerar as preocupações distributivas. A filosofia geral da Escola de Yale é por vezes criticada pela Escola de Chicago por ser excessivamente inclinada à intervenção política e influenciada por valores subjetivos.

Ocorre que a Escola de Yale considera as falhas de mercado mais difundidas do que os estudiosos de Chicago estão dispostos a admitir. Daí que a principal diferença entre as duas escolas reside no grau de confiança na eficiência do mercado e no papel da intervenção governamental para alcançar os resultados sociais desejados. Enquanto a Escola de Chicago prioriza a eficiência e a intervenção mínima, a Escola de Yale adota uma abordagem mais pragmática, reconhecendo a necessidade de intervenção em certas circunstâncias.

para distribuir riscos de forma eficiente. Calabresi sempre criticou uma abordagem reducionista da disciplina, e em trabalhos como “The Costs of Accidents” (1970) e “The Future of Law and Economics” (2016), ele argumenta que o direito não deve ser subordinado à teoria econômica, mas sim enriquecê-la, incorporando dimensões como justiça distributiva, bens meritórios (*merit goods*) e altruísmo (CALABRESI, 2016). Calabresi diferencia-se por sua visão “ampliada” do *law and economics*, que rejeita o utilitarismo estreito de Bentham em favor de uma perspectiva inspirada em John Stuart Mill, capaz de integrar valores não-econômicos, como equidade e cultura (GORDON; MARCIANO; RAMELLO, 2019).

Outra referência de destaque do *law and economics* foi Gary Becker. O seu artigo “Crime and Punishment: An Economic Approach” (1968), publicado no *Journal of Political Economy*, é um marco na aplicação da teoria dos incentivos ao crime, argumentando que indivíduos respondem a incentivos como multas e probabilidades de punição. Becker expandiu a teoria econômica para áreas como crime, discriminação e comportamento humano, analisando como incentivos (recompensas e punições) influenciam decisões individuais.

Becker (1968) argumenta que indivíduos e empresas, quando confrontados com regras legais, avaliam os benefícios e custos marginais de suas ações, ajustando seu comportamento de forma a maximizar sua utilidade ou lucro. Dessa forma, o direito, ao estabelecer sanções, prêmios, direitos de propriedade e estruturas de responsabilidade, essencialmente modifica os preços relativos das condutas. Sua abordagem é frequentemente associada à análise econômica do comportamento racional. Em diversos trabalhos, Becker (1968, 1997) buscou demonstrar que as normas, desde a matéria criminal até o antitruste, podem ser desenhadas para minimizar custos sociais. Gary Becker foi laureado com o Nobel de Economia em 1992, pelo trabalho reconhecido na aplicação da lógica dos incentivos a fenômenos sociais.

Já Richard Posner é certamente outra figura de destaque do movimento *law and economics* na atualidade. Sua obra seminal, “Economic Analysis of Law” (1973), estabeleceu as bases metodológicas da disciplina, aplicando princípios da microeconomia neoclássica ao estudo do direito, com ênfase na eficiência alocativa e na maximização da riqueza social (POSNER, 2011). Sua abordagem é marcada pelo pragmatismo jurídico e pelo utilitarismo benthamiano, defendendo que decisões

judiciais devem ser guiadas por uma análise custo-benefício, em vez de princípios morais abstratos. Apesar de seu alinhamento inicial com o liberalismo econômico, Posner revisou algumas de suas posições após a crise financeira de 2008, admitindo falhas nos pressupostos da economia neoclássica e incorporando elementos keynesianos em sua análise²⁵.

No contexto brasileiro, a recepção das correntes do *law and economics* ocorreu de forma gradual e heterogênea, com esforços relevantes de sistematização teórica e aplicação empírica em diferentes ramos do Direito. Entre as contribuições pioneiras, destaca-se a obra de Luciano Timm, que introduz de maneira didática a análise econômica do Direito no país, enfatizando a centralidade dos conceitos de eficiência, custos de transação e incentivos no desenho das instituições jurídicas (TIMM, 2021). No campo do direito econômico e da regulação, Floriano de Azevedo Marques Neto enfatiza a importância de compreender o arranjo institucional e os mecanismos de intervenção estatal à luz da racionalidade econômica, ainda que mantendo atenção às especificidades do interesse público e da função social das atividades reguladas (MARQUES NETO, 2002). Embora a literatura nacional ainda seja menos volumosa do que a produzida nos Estados Unidos e na Europa, esses autores contribuem para consolidar, no Brasil, uma leitura crítica das correntes do *law and economics* — ora valorizando o potencial explicativo da abordagem para compreender falhas de mercado e orientar o desenho normativo, ora evidenciando suas limitações em contextos marcados por desigualdades estruturais, assimetrias de poder e restrições institucionais típicas de economias periféricas.

Ao longo das últimas décadas, a partir de uma análise econômica mais rigorosa, o direito parece se transformar para promover uma abordagem atenta

²⁵ Tor, Teichman e Zamir (2023) documentam essa transformação notável na trajetória intelectual de Posner: Visto que na primeira edição de *Economic Analysis of Law* (1973), Posner afirmava que a "economia é ciência da escolha humana" baseada na premissa de que "homem é maximizador racional", o autor teria respondido *ferozmente* em 1998 ao trabalho de Jolls, Sunstein e Thaler, caracterizando o *behavioral economics* como "antiteórico" e "puramente empírico". Já na nona edição do tratado (2014), Posner passa a reconhecer abertamente que as evidências sobre desvios sistemáticos da racionalidade são "convincentes e requerem ajustes na análise econômica convencional do direito". Posner passou assim a incorporar *insights* comportamentais em áreas como mercados financeiros (reconhecendo o *behavioral finance*), no direito do trabalho (aplicando efeito dotação a benefícios trabalhistas), e no processo decisório judicial (justificando mandado de busca mediante *hindsight bias*).

também à eficiência econômica, sem descuidar do bem-estar do consumidor como objetivos centrais da política econômica levada pelo Estado.

A abordagem do *law and economics* oferece assim uma perspectiva analítica que busca compreender como as regras jurídicas podem influenciar o comportamento econômico e corrigir ou mitigar essas ineficiências. A disciplina tem se estabelecido como uma vertente do pensamento jurídico e trabalhos mais modernos e sofisticados têm buscado incorporar a ciência política e a psicologia para dentro do campo do *law and economics*, formando uma espécie de fertilização cruzada com proveito em todos os campos estudados.

3.2 Fundamentos teóricos do *law and economics*

O *law and economics* propõe a aplicação da teoria microeconômica²⁶ para analisar normas jurídicas. As regras legais devem assim ser formuladas e interpretadas de modo a maximizar o bem-estar social. Isso significa examinar como indivíduos e empresas tomam decisões baseadas em incentivos e em ambientes de escassez, para então desenvolver um sistema jurídico capaz de permitir uma alocação ótima dos recursos e assim se alcançar um estágio de eficiência econômica.

Também é possível utilizar os conceitos estritamente econômicos para explicar os efeitos das leis já existentes, avaliando assim quais normas jurídicas são economicamente eficientes. No cerne dessa abordagem está a premissa de que indivíduos respondem a incentivos e tomam decisões racionais para maximizar sua utilidade ou bem-estar, mesmo em contextos não estritamente mercantis. A teoria dos incentivos é central para o *law and economics*, visto que o direito é visto precipuamente como uma ferramenta social para moldar comportamentos econômicos por meio de regras, sanções e incentivos (FRIEDMAN, 2000). Em verdade, o sucesso do *law and economics* entre os aplicadores do direito parece

²⁶ Microeconomia é o ramo da economia que estuda o comportamento individual dos agentes econômicos: consumidores, empresas e trabalhadores (GICO JR, 2021). Inclui onde analisamos como pessoas tomam decisões sobre o que comprar, quanto produzir ou como alocar recursos escassos. Microeconomia nos fornece as ferramentas básicas - como análise de custos, teoria dos incentivos e comportamento do consumidor - que são essenciais para entender tudo que vem depois.

decorrer da percepção, bem explorada pelos juristas e economistas, do nicho intelectual aberto a partir da definição clássica de que a lei é uma obrigação apoiada por uma sanção estatal (COOTER; ULEN, 2000). De acordo com Cooter e Ulen (2000), as sanções se assemelham a preços, e presumivelmente, as pessoas respondem às sanções como respondem aos preços. O comportamento verificado (ou esperado) serve assim para a construção de um modelo teórico que busca prever como as pessoas respondem às alterações legais.

O instrumental produzido pela técnica econômica serve assim ao legislador, que produzirá normas em nível capaz de se alcançar determinados objetivos visados pela política pública. E a melhor forma de moderar esses estímulos é a partir da construção de incentivos mais eficientes.

A teoria dos incentivos parte da ideia de que os agentes econômicos (pessoas, empresas, etc.) respondem racionalmente a estímulos que afetam seus custos e benefícios. Ela busca responder a perguntas como motivar alguém a agir de maneira desejada, como evitar comportamentos oportunistas ou indesejados, ou como estruturar regras ou contratos para maximizar a eficiência (FRIEDMAN, 2000). Essa teoria é amplamente utilizada em áreas como teoria dos contratos, economia comportamental e regulação, sendo um pilar para o *law and economics* ao projetar leis e políticas públicas.

A teoria dos incentivos também considera os custos de implementação. Se os custos de criar ou monitorar incentivos forem muito altos (ex.: fiscalizar todas as empresas poluidoras), a solução pode ser ineficiente (SUNSTEIN, 2018). O *law and economics* busca assim encontrar as melhores alternativas, como normas mais claras e mecanismos de autorregulação. Uma das grandes realizações da microeconomia moderna é a especificação das condições sob as quais as decisões independentes de agentes que maximizam sua utilidade levam ao inevitável estabelecimento espontâneo de equilíbrio no mercado (COOTER; ULEN, 2000). Esse equilíbrio, como sabemos, é improvável de ser alcançada no mundo real, e a razão maior é esse cenário depende de um mercado perfeitamente competitivo (COOTER; ULEN, 2000).

Já a Economia do Bem-Estar (*Welfare Economics*)²⁷ constitui um ramo fundamental da teoria econômica dedicado a avaliar como diferentes arranjos econômicos afetam o bem-estar social e individual. A teoria tradicional do bem-estar tem suas raízes no utilitarismo clássico de Jeremy Bentham, que influenciou significativamente o desenvolvimento da economia do bem-estar predominante. Segundo essa visão, o bem-estar é concebido como função de utilidade, e o indivíduo é entendido como possuidor de uma razão calculadora inata que busca maximizar sua satisfação pessoal. Esta abordagem *benthamita* fundamentou grande parte da teoria econômica convencional, estabelecendo que o objetivo das políticas econômicas deveria ser maximizar a soma das utilidades individuais.

Na visão defendida por Sztjan (2005) é a racionalidade dos agentes, um dos postulados econômicos neoclássicos, que leva à procura da maximização de utilidades e a eficiência alocativa vai ao encontro da ideia de solidariedade e geração do bem-estar coletivo. Segundo Posner (1973), na economia do bem-estar, a eficiência seria mensurada a partir do crescimento (ou decréscimo) de riqueza. Assim, a eficiência é alcançada quando há maximização de riqueza.

Já Polinsky (1989) questiona se a eficiência (econômica) deveria ser um critério único para avaliar a norma ou se a equidade deveria ser levada em consideração. Para identificar um tratamento eficiente a um problema o autor faz as seguintes questões sobre incentivos: A norma legal cria incentivos para os indivíduos relevantes atuarem eficientemente? A norma legal aloca o risco de modo eficiente entre os indivíduos e empresas relevantes? A norma legal cria incentivos para os indivíduos e empresas relevantes se comportarem de modo eficiente? Para o autor, comportamento eficiente significa o comportamento que maximiza os benefícios agregados deduzidos os custos agregados.

²⁷ Arthur Cecil Pigou é amplamente reconhecido como uma figura central no desenvolvimento da economia do bem-estar. Pigou, um economista britânico do início do século XX, foi pioneiro ao sistematizar conceitos relacionados ao bem-estar social, especialmente por meio de sua obra seminal *The Economics of Welfare* (1920), onde introduziu ideias que moldaram o campo. A economia do bem-estar, conforme desenvolvida por Pigou, concentra-se na análise de como os recursos econômicos podem ser alocados para maximizar o bem-estar social. Ele propôs que o bem-estar de uma sociedade depende da soma das utilidades individuais, assumindo que estas podem ser comparadas intersubjetivamente (PIGOU, 1920). Um dos conceitos mais influentes de Pigou é o de externalidades, que ele definiu como os efeitos de uma ação econômica sobre terceiros que não são compensados pelo mercado. Por exemplo, ele argumentou que poluição gerada por uma fábrica impõe custos à sociedade que não são refletidos nos preços de mercado, justificando intervenções governamentais, como impostos, para corrigir essas falhas (PIGOU, 1920).

O critério de mensuração da eficiência, contudo, não é unanimidade. Nesse sentido, ainda na atualidade se busca estabelecer critérios para julgar a desejabilidade de políticas econômicas e determinar a alocação ótima de recursos na sociedade, sendo particularmente relevante estudos interdisciplinares como o *law and economics*, onde a análise da eficiência e equidade de arranjos institucionais é central.

Um dos pilares do *welfare economics* é o critério de eficiência de Pareto. A eficiência de Pareto descreve uma situação em que os recursos estão alocados de forma que não é possível melhorar a condição de um indivíduo sem piorar a de outro. Esse conceito foi desenvolvido pelo economista italiano Vilfredo Pareto e é amplamente utilizado para analisar a eficiência econômica e a justiça distributiva. Em termos simples, uma mudança é considerada Pareto Eficiente se pelo menos uma pessoa for beneficiada pela mudança e nenhuma outra pessoa for prejudicada, segundo sua própria estimativa (COOTER; ULEN, 2000).

O conceito serve para analisar como diferentes regras e instituições jurídicas promovem ou impedem essa alocação eficiente de recursos na sociedade. Como ele exige que todos os ganhos sejam mútuos (trocas que beneficiam pelo menos uma parte sem prejudicar outra), tem-se que o Pareto Eficiente não avalia a equidade da distribuição, mas apenas a maximização da utilização dos recursos disponíveis.

Trazido o conceito para o estudo da norma jurídica à luz da teoria econômica neoclássica, tem-se que a norma passa a ser examinada a partir dos seus efeitos sobre a alocação de recursos. Assim, normas indutoras de formas de comportamento que levam ao ótimo de Pareto são vistas como benéficas, enquanto as que dificultam a sua obtenção são tidas como nocivas. Para a teoria neoclássica, escolhas valorativas são realizadas no interior do conjunto de alocação de recursos que atendem justamente ao critério de Pareto (ARIDA, 2005). Um aspecto importante é que a eficiência de Pareto é um critério limitado, pois não aborda questões de justiça social ou bem-estar coletivo.

Uma sociedade pode estar em um estado Pareto eficiente, mas com desigualdades extremas ou pobreza generalizada. Por isso, o conceito é frequentemente complementado por outros critérios, como o de justiça distributiva ou utilidade social, que consideram a equidade e o bem-estar geral. Além disso, alcançar

a eficiência de Pareto não significa que o sistema é ideal, mas apenas que não há desperdício de recursos em termos de alocação.

A eficiência econômica também é frequentemente avaliada em termos de alocação de recursos sob o critério de Kaldor-Hicks. Desenvolvido com base nas ideias de Nicholas Kaldor e John Hicks, o critério parte do modelo de utilidade preconizado por Bentham, e sugere que a norma deve ser desenhada de maneira a gerar o máximo de bem-estar para o maior número de pessoas (SZTAJN, 2005). Para COOTER e ULEN (2000), o critério de eficiência Kaldor-Hicks permite mudanças nas quais há tanto ganhadores quanto perdedores, mas exige que os ganhadores obtenham mais do que os perdedores percam. Em princípio, os ganhadores podem compensar os perdedores e ainda assim ter um benefício líquido. A compensação não precisa ser feita de fato, mas deve ser possível em princípio.

Diferentemente da eficiência de Pareto, que exige que ninguém seja prejudicado para que uma mudança seja considerada eficiente, o critério de Kaldor-Hicks permite que alguns indivíduos sofram perdas, desde que o ganho total supere essas perdas em termos de bem-estar ou riqueza. Em essência, Kaldor-Hicks baseia-se na ideia de maximização da eficiência econômica global e é muito utilizado para avaliar alocações de recursos e políticas públicas.

Por exemplo, imagine uma política pública, como a construção de uma rodovia, que beneficia a maioria da população ao reduzir custos de transporte, mas prejudica alguns moradores que perdem suas casas. Se os benefícios totais (medidos em termos monetários ou de utilidade) superarem os custos impostos aos perdedores, a política é considerada eficiente sob o critério de Kaldor-Hicks, desde que seja teoricamente possível compensar os afetados negativamente, como por meio de indenizações. Essa possibilidade de compensação é o que distingue Kaldor-Hicks de uma simples análise de custo-benefício, embora a compensação real raramente ocorra. Na prática, contudo, o critério de Kaldor-Hicks é amplamente utilizado como critério geral em análises de custo-benefício para avaliar projetos e políticas públicas, como investimentos em infraestrutura, regulamentações ambientais ou reformas econômicas que visam ganhos de bem-estar.

Apesar de sua utilidade, o critério de Kaldor-Hicks tem limitações significativas. Primeiro, ele assume que é possível comparar ganhos e perdas entre indivíduos, o

que envolve dificuldades práticas e éticas, especialmente quando se considera a subjetividade do bem-estar. Além disso, a ausência de compensação real pode perpetuar desigualdades, já que os perdedores (frequentemente grupos vulneráveis) não recebem (na prática) reparação. Críticos apontam que o foco na eficiência agregada pode negligenciar questões de justiça distributiva, levando a decisões que favorecem os mais ricos ou poderosos em detrimento dos mais pobres.

O pensamento econômico tradicional, contudo, pode enfrentar lacuna fundamental ao negligenciar a relevância da historicidade das normas, problema identificado por Arida (2005). O autor demonstra que a economia consegue compreender normas enquanto interferências em equilíbrios de mercado, enquanto correções de falhas de mercado, e mesmo enquanto fundamentos para estruturação de contratos e mercados, mas revela incapacidade intrínseca para compreender a evolução das normas quando esta decorre de dinâmicas internas ao próprio sistema jurídico. Arida argumenta que enquanto a economia pode querer "endogeneizar" a norma quando sua mudança decorre de adaptação às vicissitudes econômicas ou da pressão de grupos de interesse, permanece desarmada para explicar evoluções normativas motivadas por dinâmicas puramente jurídicas ou por imperativos morais e valorativos que transcendem racionalidade econômica estrita. Esta lacuna tem consequências significativas, a exemplo de normas editadas em resposta a eventos econômicos traumáticos que frequentemente permanecem em vigor muito tempo após desaparecer as circunstâncias que as motivaram, cristalizando-se como parte do arcabouço legal duradouro. Na saúde suplementar brasileira, compreender essa historicidade é essencial, visto que regulações como a Lei n. 14.454/2022, que alterou natureza do rol de procedimentos, ou decisões judiciais que ampliaram coberturas, refletem dinâmicas normativas que economistas isoladamente não conseguem antecipar ou explicar, evidenciando necessidade de perspectiva interdisciplinar.

3.3 Aplicação do *law and economics* na regulação da saúde suplementar

Quando aplicado à regulação de mercados, o *law and economics* serve como referencial teórico e oferece uma lente analítica poderosa para compreender quando

e como o Estado deve intervir na economia. O *law and economics* funcionaria para o estreitamento das relações entre o direito e a economia, na medida em que esta apresentaria àquele algumas premissas de microeconomia como um possível critério de justiça, dentre outros adotados pelo direito (LEONETTI; FERIATO, 2019). Isso porque a microeconomia fornece uma estrutura teórica fundamental para entender o funcionamento dos mercados, examinando-se o conjunto complexo de transações, seus custos, contratos incompletos e a assimetria de informação entre os agentes.

Com efeito, o modelo econômico clássico pressupõe condições ideais sob as quais o equilíbrio de mercado é alcançado a partir de forças naturais e se alcança a eficiência alocativa. Neste cenário, o mercado é visto como um mecanismo autorregulável e eficiente. Não obstante, mesmo mercados livres (geralmente eficientes segundo o modelo), podem apresentar falhas estruturais - como monopólios naturais, externalidades negativas e assimetrias informacionais - que justificam a intervenção regulatória estatal.

Nesse cenário, o comprometimento do *law and economics* com a solução de problemas (*problem-solving*) e a ideia de que devemos ter a participação de diversos atores no processo de decisão, com a produção de análises empíricas do fenômeno jurídico, nos auxiliam para chegar no melhor desfecho. A partir da identificação das falhas de mercado, com base na diagnose microeconômica, é possível aferir a violação às premissas ideais inicialmente lançadas sobre o livre mercado, autorregulável e eficiente.

O setor da saúde suplementar, objeto da nossa análise, é um exemplo de mercado caracterizado por “falhas de mercado”, ou seja, a relação entre demanda e oferta não se reflete fielmente na formação de preços (CADE, 2021). Em verdade, as falhas de mercado impedem que a demanda e a oferta de bens e serviços se ajustem por meio do mecanismo de preços, levando a alocações ineficientes de recursos, que não maximizam o bem-estar social conforme previsto pelos critérios de eficiência estudados, implicando em problemas de incentivos e comportamentos oportunistas.

A análise do Cade sobre o setor da saúde suplementar é precisa:

As empresas não conseguem diferenciar perfeitamente seus clientes, conforme sua classificação de risco, portanto os planos oferecidos devem atender a um conjunto heterogêneo de

beneficiários, de forma que aqueles com menor risco acabam por subsidiar os de maior risco. Os consumidores por sua vez, tendem a sobreutilizar os serviços, dado que os mesmos já estão cobertos pelo prêmio pago às operadoras, da mesma forma, os prestadores de serviços também têm incentivos para a máxima utilização dos serviços disponíveis, o que contraria o interesse das operadoras de prestar serviços com o menor custo possível.

(CADE, 2021, p.30-31)

Segundo Azevedo *et al.* (2016), em situação de concorrência, os agentes econômicos conseguem ter no preço um sinalizador do quanto um bem é valorado pela sociedade, seja pelos custos envolvidos em sua produção, seja pelo benefício adicional de seu consumo. Tem-se assim que o mercado e o sistema de preços conseguiriam alocar os recursos disponíveis de maneira eficiente. Esta, contudo, não é a realidade no setor de saúde.

No setor da saúde suplementar, o mecanismo de preço típico do modelo de teoria econômica tradicional não costuma funcionar, e as causas residem nas forças estranhas ao mecanismos da concorrência perfeita, conhecidas como falhas de mercado. Segundo os estudos que focam no setor, isso se dá primeiro pela diversidade de informações que os tomadores de decisão possuem (AZEVEDO *et al.*, 2016), proporcionando a um tomador de decisão mais informações que outras partes também afetadas pela decisão, problema conhecido como assimetria de informação. Outra razão apontada é quando um agente pode interferir nos preços praticados no mercado sem sofrer as consequências da concorrência, conhecido como poder de mercado (AZEVEDO *et al.*, 2016).

Com isso, surge o papel da regulação econômica, pautada como um instrumento de política pública para corrigir ou mitigar essas ineficiências e promover objetivos sociais mais amplos (como equidade, estabilidade ou proteção ao consumidor). Vale referir que a Constituição brasileira não estabelece uma separação dicotômica entre Estado e mercado, mas prevê uma atuação conjunta e complementar entre ambos para alcançar os objetivos constitucionais. Isso significa que a regulação deve considerar não apenas critérios de eficiência econômica, mas também princípios

como justiça social, proteção ambiental e redução de desigualdades. O setor da saúde suplementar, como visto, passou a ser objeto de efetiva regulação estatal apenas no final da década de 1990.

Nesse cenário, o *law and economics* contribui para a formulação de várias formas de corrigir as falhas de mercado, criando (modulando) regras que tornam o mercado mais justo e eficiente. Na prática, a utilização dos princípios microeconômicos tem servido como ferramental para regulações modernas, desenhadas de modo a combinar os *insights* econômicos com os demais objetivos sociais, políticos e éticos de uma sociedade. A regulação econômica, portanto, não é um antagonista do mercado, mas uma intervenção fundamentada na teoria microeconômica para tentar aproximar os resultados do mercado de um ótimo social quando as condições para sua operação eficiente e espontânea falham.

O *law and economics* propõe uma análise do sistema jurídico por meio das lentes da teoria econômica, a partir do pressuposto fundamental de que as normas legais podem ser concebidas e avaliadas com base em sua capacidade de promover a eficiência alocativa, minimizando os custos sociais e maximizando a riqueza da sociedade. Neste contexto, a regulação por incentivos emerge como um instrumento privilegiado, alinhando-se diretamente com a lógica econômica ao buscar modificar o comportamento dos agentes não por meio de comandos impositivos e inflexíveis, mas por meio de estímulos que orientam as decisões privadas para resultados socialmente desejáveis. Afinal, o núcleo da análise econômica do direito reside na compreensão de que os agentes respondem a incentivos.

Com efeito, a regulação por incentivos²⁸, em vez de impor comandos diretos, como proibições ou padrões rígidos (*command and control*), cria estruturas que incentivam agentes econômicos a internalizar os custos ou benefícios de suas ações, promovendo eficiência de forma mais flexível e, muitas vezes, mais eficaz. Essa

²⁸ Um exemplo clássico de regulação por incentivos é a correção de externalidades negativas, como a poluição. Quando uma empresa polui, ela impõe custos à sociedade (ex.: danos à saúde ou ao meio ambiente) que não são refletidos em seus custos de produção, resultando em sobreprodução do bem poluente. Um imposto sobre emissões de carbono, conhecido como imposto pigouviano, corrige essa falha ao fazer a empresa internalizar o custo social da poluição. Alternativamente, sistemas de cap-and-trade (limite e comércio) estabelecem um teto para emissões e permitem que empresas negociem permissões, incentivando aquelas com menores custos de redução a agir primeiro. Esses mecanismos, analisados sob a ótica do *law and economics*, são preferíveis a regulamentações tradicionais porque oferecem flexibilidade, reduzem custos de conformidade e estimulam inovação tecnológica, alinhando interesses privados com o objetivo público de reduzir externalidades.

abordagem é fundamentada na ideia de que agentes respondem a incentivos econômicos e que estes são capazes de ajustar seus comportamentos para minimizar custos ou maximizar benefícios.

A própria evolução do *law and economics* contempla diferentes escolas que representam abordagens complementares sobre relação entre instituições jurídicas e comportamento econômico. Yeung e Camelo (2024) identificam três principais correntes: uma seria a escola de Chicago (centrada em eficiência e racionalidade plena), outra seria a Nova Economia Institucional (focada no papel das instituições formais e informais sobre custos de transação), e por fim, a Economia Comportamental aplicada ao Direito (*Behavioral Law and Economics*), que incorpora as descobertas da psicologia cognitiva sobre vieses e heurísticas. Os autores explicam que essas escolas não são mutuamente excludentes, mas sim representam diferentes níveis de sofisticação analítica: enquanto Chicago oferece arcabouço básico sobre resposta a incentivos, a NEI adiciona dimensão institucional, e o *behavioral law and economics* refina compreensão sobre como incentivos são processados por agentes com racionalidade limitada. Na regulação da saúde suplementar brasileira, essa integração é particularmente relevante: instituições regulatórias da ANS (NEI) estabelecem incentivos econômicos (Chicago) que são mediados por vieses cognitivos de consumidores e operadoras (*behavioral*), exigindo abordagem regulatória que articule essas três dimensões.

Outra aplicação da regulação por incentivos é na mitigação da assimetria de informação, como no mercado de seguros ou produtos de consumo. A falta de informação completa sobre a qualidade de produtos ou riscos pode levar a seleção adversa ou ao risco moral, resultando em mercados ineficientes. A regulação pode incentivar a transparência por meio de certificações, garantias ou penalidades por informações enganosas, reduzindo a incerteza dos consumidores. Por exemplo, no setor financeiro, exigências de divulgação de riscos em contratos de investimento incentivam empresas a fornecer informações claras, diminuindo a assimetria e aumentando a confiança no mercado. Do ponto de vista do *law and economics*, essas medidas são eficazes porque alteram os incentivos das empresas, alinhando suas ações com o interesse dos consumidores sem a necessidade de regulações excessivamente restritivas.

A regulação por incentivos é uma abordagem que utiliza mecanismos econômicos, como preços, impostos, subsídios ou permissões negociáveis, para alinhar os interesses privados com o bem-estar social, especialmente na correção de falhas de mercado.

Registre-se que, na visão de Posner (2011) a regulação por incentivos não chega a ser um substituto perfeito para o mercado. Para o autor, o risco maior é reduzir a qualidade geral com interferência nos custos e nos preços, criando um problema geral para os agentes quanto à mensuração de performance. Segundo o autor, um incentivo desenhado pelo Estado e não pelo mercado parece do risco inerente de não observar fatores idiossincráticos de cada mercado, tendo por desfecho um resultado pior que o estado original. Não obstante a crítica do notável professor, parece indene de dúvida que a superação das falhas de mercado pode ocorrer não pela supressão do mercado, mas pela sua correção inteligente, preservando suas dinâmicas de concorrência e inovação.

No caso do poder de mercado, a regulação por incentivos pode promover concorrência ou limitar abusos sem eliminar os benefícios de economias de escala. Por exemplo, em monopólios naturais, como serviços públicos, tarifas reguladas ou incentivos à entrada de concorrentes podem evitar preços abusivos e estimular eficiência. O *law and economics* enfatiza que tais incentivos devem ser cuidadosamente calibrados para evitar distorções, como subsídios excessivos que desencorajam inovação. A análise econômica ajuda assim a projetar regras que maximizem o bem-estar social, equilibrando os interesses das empresas e dos consumidores.

Em resumo, a regulação por incentivos, no contexto do *law and economics*, é uma ferramenta poderosa para corrigir falhas de mercado, alinhando interesses privados com o bem-estar social. Seja por meio de impostos, permissões negociáveis, certificações ou políticas de concorrência, essa abordagem oferece soluções flexíveis e economicamente eficientes para externalidades, assimetria de informação e monopólios. Contudo, o sucesso depende de um desenho cuidadoso, baseado em análises empíricas e teóricas, para evitar consequências não intencionais, como custos excessivos ou incentivos desalinhados. Assim, a regulação por incentivos continua sendo uma pedra angular na formulação de políticas públicas que buscam eficiência e equidade na alocação de recursos.

A ANS tem, progressivamente, incorporado instrumentos de regulação por incentivos alinhados à lógica do *law and economics*. Um bom exemplo é o programa de qualificação da saúde suplementar (Qualiss). Regulamentado pela RN ANS n. 510, o programa estabelece metas de qualidade e desfechos assistenciais para as operadoras, onde aquelas que atingem melhores indicadores são beneficiadas com uma tramitação mais ágil de processos junto à ANS e com maior visibilidade perante o mercado. Cria-se, assim, um incentivo positivo (uma "recompensa regulatória") para que as operadoras invistam em qualidade, superando a assimetria informacional que poderia levar o mercado a um equilíbrio de baixa qualidade.

A agência também tem investido em medidas de divulgação de informações comparativas, de modo a reduzir a assimetria informacional do setor. O Painel Econômico-Financeiro da Saúde Suplementar²⁹ resume as principais informações econômico-financeiras das operadoras, a exemplo dos balanços patrimoniais, demonstrações dos resultados operacional e financeiro, receitas e despesas totais, provisões, ativos garantidores, com segmentação por setores, modalidades e portes das operadoras. O Mapa Assistencial da Saúde Suplementar³⁰, por sua vez, apresenta todos os dados de produção dos serviços de saúde prestados pelas operadoras, com apresentação de focos temáticos, a exemplo do monitoramento das despesas com medicamentos utilizados em atendimentos de terapia oncológica.

Mesmo na regulação do reajuste contratual nos planos individuais e familiares a agência tem buscado provocar os agentes econômicos a partir de regulação indutiva. Assim, na RN ANS n. 441, que estabelece critérios para cálculo do reajuste máximo das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde médico-hospitalares, individuais ou familiares, a agência fixou no cálculo uma variável chamada de fator de ganhos de eficiência (FGE).

De acordo com o Anexo III da aludida norma, a implementação do FGE objetiva promover maior eficiência na gestão das despesas dos planos individuais. Na ausência desse componente, o cálculo do reajuste ficaria restrito ao índice de recomposição da variação de despesas. O objetivo da regulação aqui é claro:

²⁹ O painel é dinâmico e pode ser encontrado no sítio: <https://www.gov.br/ans/pt-br/aceso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor>.

³⁰ Também disponível no sítio: <https://www.gov.br/ans/pt-br/aceso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor>.

aumentar a eficiência e garantir que seus ganhos sejam sentidos também pelos usuários e contratantes de planos de saúde.

A interação entre o *law and economics* e a regulação por incentivos constitui um paradigma robusto para o enfrentamento das falhas de mercado no setor da saúde suplementar. Ao reconhecer que os agentes econômicos que atuam na saúde também reagem racionalmente aos estímulos, esta abordagem tem permitido desenhar intervenções regulatórias mais flexíveis, eficientes e menos custosas do que os modelos de comando e controle tradicionais.

Contudo, apesar das contribuições significativas do *law and economics* para a compreensão das falhas de mercado e para o desenho de instrumentos regulatórios baseados em incentivos, emergem questões fundamentais que a abordagem tradicional deixa em aberto. A premissa de racionalidade dos agentes, mesmo quando mediada por incentivos bem estruturados, não consegue sempre explicar os padrões de escolha observados empiricamente no mercado de saúde suplementar, onde consumidores frequentemente fazem seleções que não se alinham com maximização de utilidade esperada, e operadoras implementam práticas que parecem contradizer objetivos de eficiência econômica. Também permanece sem resposta adequada a questão de como os instrumentos regulatórios baseados exclusivamente em *law and economics* conseguem efetivamente modificar comportamentos quando os agentes carecem de capacidade cognitiva para processar adequadamente as informações disponibilizadas ou quando apresentam padrões de preferência não lineares e dependentes do contexto de apresentação das opções. Essas lacunas sugerem que a regulação da saúde suplementar necessita de complementação que reconheça as limitações cognitivas dos agentes e os desvios sistemáticos em relação ao modelo de racionalidade plena, integrando ao arsenal regulatório as contribuições da chamada economia comportamental.

4 O USO DA ECONOMIA COMPORTAMENTAL COMO FERRAMENTA DA REGULAÇÃO

4.1 Introdução à economia comportamental

Se o paradigma tradicional do *law and economics* proveu um instrumental valioso para a regulação ao demonstrar como os agentes racionais respondem a incentivos, permitindo a correção de falhas de mercado como externalidades e assimetria informacional via alteração de preços relativos, sua premissa fundamental de racionalidade *homo economicus* revela-se uma lente incompleta para o desenho regulatório. Esta abordagem, embora eficaz em diversos contextos, negligencia uma categoria distinta de falhas: as falhas de mercado comportamentais, que emergem não de restrições externas, mas de desvios cognitivos e limitações processuais sistemáticas dos agentes.

A crítica endereçada ao *law and economics* deriva da constatação empírica de que a suposição inicial de que indivíduos agem racionalmente, respondendo a incentivos de forma lógica e que as decisões individuais maximizam a eficiência econômica, nem sempre se sustenta. As limitações apontadas pelo conjunto de estudos críticos ao *law and economics* sugerem que o desenho e a avaliação das normas devem se integrar com outras perspectivas além da puramente econômica, como apontado pelo campo da economia comportamental.

Um dos pioneiros a desafiar os paradigmas da teoria econômica clássica foi Herbert Simon³¹, conhecido por introduzir o conceito de racionalidade limitada (*bounded rationality*). Com efeito, Simon (1955; 1957) apresentou uma análise aprofundada sobre a racionalidade limitada, onde se argumenta que na prática, as pessoas operam sob restrições cognitivas, informacionais e temporais, o que impede a racionalidade perfeita. Em vez de otimizar, os tomadores de decisão recorrem ao

³¹ Simon também recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 1978 por suas contribuições ao estudo da tomada de decisão em contextos organizacionais e econômicos.

que Simon chama de "satisfação" (*satisficing*)³², ou seja, escolhem alternativas que são suficientemente boas, dadas as limitações. Esse conceito é fundamental para entender o comportamento humano, pois reconhece que as decisões complexas são moldadas por fatores humanos e contextuais, e não apenas por cálculos lógicos. Ainda segundo o autor, a racionalidade limitada implica na dificuldade para processar grandes quantidades de informações e prever todas as consequências de nossas escolhas. Simon (1955; 1957) descreve que as decisões são frequentemente baseadas em informações incompletas e em heurísticas, ou regras práticas, que simplificam o processo decisório.

A economia comportamental³³ nasce assim a partir da crítica à visão clássica econômica que ignora falhas sistemáticas nas decisões humana e superestima a eficácia de incentivos financeiros ou jurídicos quando, em geral, os indivíduos não os percebem ou interpretam corretamente, ou ainda, não se considera que as leis podem ser ineficazes se não levarem em conta os vieses comportamentais.

O estudo sobre o processo de tomada de decisão humana (e suas limitações) sofreu uma revolução na década de 1970, a partir das contribuições de Daniel Kahneman e Amos Tversky. Os dois pesquisadores estudaram a fundo como indivíduos e grupos fazem escolhas, especialmente em contextos de incerteza e risco. Neste campo, as novas contribuições desafiaram os paradigmas tradicionais da economia e abriram caminho para a economia comportamental. Conforme as novas pesquisas eram publicadas, com ênfase nas heurísticas de julgamento, na teoria da perspectiva e em suas implicações para a economia, um novo entendimento foi se consolidando, no sentido de que as decisões humanas frequentemente desviam-se da racionalidade plena, influenciadas por fatores psicológicos (TVERSKY; KAHNEMAN, 1973).

³² Yeung e Camelo (2024) explicam que Simon demonstrou que os agentes não maximizam utilidade de forma ótima, mas sim buscam soluções satisfatórias (*satisficing*) dentro de suas restrições cognitivas e informacionais. Os autores enfatizam que "decisores não computam todas as alternativas possíveis, nem esgotam as informações disponíveis, mas sim procuram por uma solução que atenda a um nível mínimo de satisfação".

³³ Embora Simon não tenha usado explicitamente o termo *behavioral economics* em seus primeiros trabalhos, sua pesquisa na interseção de economia, psicologia e ciência organizacional é considerada fundacional para a disciplina. De outro lado, o primeiro acadêmico a utilizar o termo *behavioral economics* não é claramente definido por uma única fonte consensual.

As pesquisas de Tversky e Kahneman surgiram em um contexto dominado pela teoria da utilidade esperada³⁴, que presume que os agentes econômicos tomam decisões racionais baseadas na maximização da utilidade esperada. Contudo, os dois trouxeram evidências empíricas mostrando que as escolhas humanas nem sempre seguiam esse padrão, especialmente sob risco ou incerteza. Esse cenário motivou os dois psicólogos a investigar os processos cognitivos por trás das decisões, buscando explicar os desvios da racionalidade que a teoria tradicional não conseguia justificar. Uma das contribuições iniciais mais marcantes de Tversky e Kahneman foi a identificação das heurísticas de julgamento, atalhos mentais usados para simplificar decisões complexas. Conforme veremos a seguir, embora úteis, essas heurísticas frequentemente resultam em vieses sistemáticos, afetando a qualidade das decisões.

4.1.1 A heurística da disponibilidade

Amos Tversky e Daniel Kahneman descreveram a tendência das pessoas de julgarem a probabilidade de um evento com base na facilidade com que exemplos desse evento vêm à mente (TVERSKY; KAHNEMAN, 1973). Essa heurística é vista pelos autores como uma estratégia cognitiva que simplifica o processo de tomada de decisão, mas que pode levar a vieses sistemáticos, especialmente quando a disponibilidade de informações é influenciada por fatores como exposição midiática, vivências pessoais ou emoções. Por exemplo, uma pessoa pode superestimar a probabilidade de acidentes aéreos após assistir a notícias sobre um desastre, mesmo que estatisticamente tais eventos sejam raros.

Em um estudo clássico (TVERSKY; KAHNEMAN, 1973), participantes superestimaram a prevalência de palavras começando com a letra "K" em comparação com palavras que têm "K" como terceira letra, devido à maior facilidade de lembrar palavras pela primeira letra. A probabilidade de um evento parece ser julgada pela facilidade ou recorrência de um exemplo ou pequeno conjunto de

³⁴ A Teoria da Utilidade Esperada, formulada por Von Neumann e Morgenstern, pode ser bem compreendida a partir da obra seminal intitulada *Theory of Games and Economic Behavior*, publicada em 1944 (NEUMANN;MORGENSTERN, 1944).

exemplos, o que revela como a acessibilidade de informações distorce a percepção de risco, priorizando memorabilidade sobre dados estatísticos.

O funcionamento da heurística da disponibilidade está intimamente ligado à memória e à atenção seletiva. Assim, eventos mais recentes, vívidos ou emocionalmente impactantes tendem a ser mais acessíveis na memória, influenciando julgamentos probabilísticos (KAHNEMAN, 2012).

4.1.2 A heurística da representatividade

A heurística da representatividade é um conceito fundamental da economia comportamental que explica como indivíduos avaliam a probabilidade de um evento ou o pertencimento de um objeto a uma categoria com base em sua semelhança com um protótipo ou estereótipo (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). Essa heurística leva as pessoas a ignorarem informações estatísticas relevantes, como taxas de base, e a confiarem em características superficiais que parecem representativas.

Por exemplo, ao julgar se uma pessoa é engenheira com base em sua descrição como alguém metódico e interessado em tecnologia, indivíduos podem desconsiderar a baixa prevalência de engenheiros na população geral. Esse atalho cognitivo, embora eficiente, frequentemente resulta em vieses sistemáticos que distorcem a tomada de decisão.

Um experimento clássico de Tversky e Kahneman (1974) ilustra o viés da representatividade por meio do "problema de Linda". Nesse estudo, participantes receberam a descrição de Linda, uma mulher jovem, articulada e engajada em causas sociais, e foram questionados sobre a probabilidade de ela ser "uma caixa de banco" ou "uma caixa de banco e feminista". Surpreendentemente, muitos escolheram a segunda opção como mais provável, violando a lógica probabilística, pois a probabilidade de dois eventos conjuntos nunca pode exceder a de um evento isolado. Esse erro, conhecido como falácia da conjunção (*The Conjunction Fallacy*), demonstra como a representatividade (a semelhança de Linda com o estereótipo de feminista)

supera considerações estatísticas, influenciando julgamentos de maneira não racional (KAHNEMAN, 2012).

Diante dos achados em experimentos clássicos, é possível observar que as pessoas costumam julgar negligenciando a taxa base real de determinado evento. Isso evidenciou uma tendência humana a substituir análise estatística por intuições superficiais.

4.1.3 A heurística do ancoramento

A heurística do ancoramento é um mecanismo cognitivo pelo qual indivíduos baseiam suas estimativas e julgamentos em um valor inicial, ou "âncora", mesmo que esse valor seja arbitrário ou irrelevante (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). No ancoramento, um valor inicial influencia julgamentos posteriores. Essa heurística reflete a tendência humana de depender excessivamente de informações iniciais ao fazer avaliações numéricas ou probabilísticas, ajustando insuficientemente a partir da âncora.

O ancoramento ocorre porque o cérebro humano tende a economizar esforço mental, usando a âncora como ponto de referência inicial e realizando ajustes insuficientes a partir dela (ARIELY, 2008). Fatores como a saliência da âncora, o nível de incerteza do indivíduo e a falta de conhecimento especializado amplificam o viés. Por exemplo, em situações de alta ambiguidade, como estimar o preço de um produto desconhecido, consumidores são mais suscetíveis a âncoras fornecidas por vendedores ou propagandas. Em um experimento clássico, participantes estimaram o percentual de países africanos na ONU após serem apresentados a um número aleatório gerado por uma roleta; aqueles expostos a números mais altos deram estimativas significativamente maiores, demonstrando o impacto do ancoramento (KAHNEMAN, 2012).

Esse viés é particularmente relevante pois ilustra como decisões podem ser distorcidas por fatores contextuais.

4.1.4 A Teoria da Perspectiva (1979)

A síntese das primeiras descobertas de Tversky e Kahneman culminou com a Teoria da Perspectiva (*Prospect theory*), publicada em 1979, considerada um marco na história da economia comportamental. A teoria contrastou com a Teoria da Utilidade Esperada, prevalente no estudo econômico clássico, e que avalia que escolhas são tomadas unicamente com base na riqueza total vislumbrada em cada desfecho possível (decisões com base em cálculos probabilísticos).

A Teoria da Perspectiva argumenta por sua vez que as pessoas avaliam resultados com base em ganhos e perdas relativos a um ponto de referência, e não em termos de estados finais de riqueza (TVERSKY; KAHNEMAN, 1979). A abordagem humana incorpora ainda fatores psicológicos, como a aversão à perda, onde perdas têm um impacto emocional maior que ganhos equivalentes. Por exemplo, a dor de perder R\$100 é percebida como mais intensa que o prazer de ganhar R\$100, o que leva à aversão à perda. Essa característica explica comportamentos como a relutância em vender investimentos com prejuízo ou a preferência por manter o *status quo* em decisões financeiras (THALER, 2015).

Em síntese, a teoria explica por que indivíduos frequentemente se desviam da racionalidade econômica clássica, tomando decisões influenciadas por vieses cognitivos e emoções. Diferentemente dos modelos tradicionais, a teoria incorpora assimetrias na percepção de ganhos e perdas.

A teoria também destaca o papel do enquadramento (*framing*) nas decisões. Tversky e Kahneman (1979) mostraram que a forma como uma escolha é apresentada — como ganho ou perda — influencia significativamente as preferências. Em um experimento clássico, participantes preferiram uma opção com "80% de chance de salvar 200 vidas" em vez de "20% de chance de perder 400 vidas", embora as opções fossem matematicamente equivalentes. Esse efeito de enquadramento é amplamente explorado em negociações, propaganda e comunicação política, onde a escolha de palavras pode manipular percepções e decisões (TVERSKY; KAHNEMAN, 1981). Essa abordagem acaba explicando melhor comportamentos observados em experimentos e na vida real.

A Teoria da Perspectiva, embora inovadora, enfrentou críticas. Alguns argumentam que ela é mais descritiva do que normativa, limitando sua capacidade de oferecer soluções universais (GIGERENZER, 2018). Fala-se em possível supergeneralização de vieses e a subestimação de diferenças individuais. Além disso, avanços posteriores, como a teoria da escolha sob incerteza e a neuroeconomia, refinaram suas ideias. Apesar disso, o trabalho inicial de Tversky e Kahneman permanece uma referência fundamental, moldando a pesquisa contemporânea em economia comportamental.

4.2 A incorporação da economia comportamental ao Direito (*behavioral law and economics*)

A economia comportamental, ao integrar *insights* da psicologia no estudo das decisões econômicas, oferece uma perspectiva inovadora sobre o comportamento humano, desafiando a premissa tradicional da racionalidade perfeita que frequentemente fundamenta a elaboração de normas jurídicas (KAHNEMAN, 2012; THALER, 2015; THALER; SUNSTEIN, 2023). Mesmo a literatura jurídica brasileira já tem reconhecido convergência entre o conceito jurídico de vulnerabilidade e a noção econômica de racionalidade limitada (YEUNG; CAMELO, 2024), onde consumidores enfrentam decisões que envolvem avaliação probabilística de eventos futuros incertos, comparação entre dezenas de variáveis contratuais técnicas, e projeções de longo prazo sobre necessidades evolutivas, tudo sob restrições de tempo, informação e capacidade computacional.

Em contraste com o modelo do *homo economicus*, que assume que os indivíduos tomam decisões unicamente com base no interesse próprio e na maximização da utilidade, a economia comportamental reconhece que as escolhas são significativamente influenciadas por limitações cognitivas e diversos vieses (ARIELY, 2008). O sistema legal, historicamente moldado por concepções de agentes racionais, pode se beneficiar substancialmente da incorporação da economia comportamental para a criação de normas mais eficazes, que considerem as

previsíveis divergências da racionalidade (JOLLS; SUNSTEIN; THALER, 1998; THALER; SUNSTEIN, 2023).

As heurísticas, como visto acima, são definidas como atalhos mentais utilizados para simplificar a tomada de decisão, e frequentemente conduzem a vieses sistemáticos no julgamento e nas escolhas, impactando a maneira como os indivíduos respondem às normas legais (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). A identificação e a compreensão dessas heurísticas permitem aos estudiosos do direito e aos formuladores de políticas entender por que os cidadãos nem sempre cumprem as leis ou fazem escolhas que são consideradas ótimas para si ou para a sociedade. A análise do comportamento humano sob a lente da economia comportamental sugere uma mudança de paradigma no pensamento jurídico, afastando-se de modelos puramente racionais em direção a uma compreensão mais realista das motivações e dos processos decisórios humanos, com o potencial de gerar sistemas legais mais justos e eficientes.

A abordagem tradicional do direito frequentemente se baseia na intuição e em suposições de senso comum sobre o comportamento humano, as quais nem sempre se alinham com as evidências empíricas, como mostraram sobretudo as pesquisas desenvolvidas por Tversky e Kahneman. O *law and economics*, não obstante sua forte influência sobre o direito, tradicionalmente assume a ação racional como ponto de partida, oferecendo um modelo preditivo, mas que pode simplificar excessivamente as complexidades da conduta humana (POSNER, 1998). Críticas ao modelo do *homo economicus* ressaltam suas limitações na explicação e previsão do comportamento no mundo real, uma vez que as pessoas são influenciadas por emoções, vieses cognitivos e fatores sociais que escapam à lógica da racionalidade estrita (THALER, 2015; KAHNEMAN, 2012; ARIELY, 2008; THALER; SUNSTEIN, 2023). A racionalidade limitada dos agentes passa a ser entendida não apenas como um modelo evocado, mas um dado empiricamente verificável, sendo tal ideia a pedra fundante da economia comportamental, sob o novo paradigma do *homem real* (QUIRINO, 2018).

Conforme aponta Quirino (2018), as descobertas das ciências cognitivas possibilitam a melhor análise da forma como as pessoas realmente fazem suas escolhas, possibilitando uma melhor formulação de regulamentações associadas às políticas públicas e ao interesse público. A economia comportamental oferece assim

uma compreensão mais matizada do comportamento humano ao reconhecer essas influências. O foco tradicional na punição e na proibição como principais mecanismos para garantir a conformidade legal pode se mostrar insuficiente ou mesmo ineficiente, pois não leva plenamente em conta os fatores psicológicos que moldam o processo de tomada de decisão dos indivíduos.

Insights comportamentais sugerem que elementos além da análise racional de custo-benefício, como normas sociais e a percepção de legitimidade, desempenham um papel significativo na adesão às leis (TYLER, 2006). A crescente percepção dentro do direito da inadequação do modelo puramente racional para compreender e influenciar o comportamento humano por meio do direito sinaliza a necessidade de uma abordagem mais realista, informada pela economia comportamental, para a criação de normas mais eficazes.

As heurísticas, como atalhos cognitivos que simplificam a tomada de decisão, são ferramentas mentais úteis, mas propensas a gerar erros previsíveis ou vieses (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). Embora esses atalhos sejam frequentemente eficientes em situações cotidianas, podem levar a decisões subótimas ou enviesadas em contextos complexos e importantes, como aqueles regulamentados pelo direito. Diversas heurísticas e vieses cognitivos são particularmente relevantes para o campo jurídico, incluindo a heurística da disponibilidade, o viés da ancoragem, o efeito de enquadramento (*framing effect*), o viés da confirmação e a aversão à perda (KAHNEMAN, 2012; TVERSKY; KAHNEMAN, 1974; THALER, 2015; ARIELY, 2008; THALER; SUNSTEIN, 2023). A heurística da disponibilidade, por exemplo, leva magistrados a julgarem a probabilidade de eventos com base na facilidade com que exemplos vêm à mente. O viés da ancoragem por ser visto quando o regulador depende excessivamente das primeiras informações recebidas como problema regulatório ao editar regulamentos. O viés da confirmação inclina legisladores a favorecer normas que confirmam suas crenças preexistentes. Esses e outros vieses podem afetar diversos atores no sistema jurídico, desde juízes, procuradores, legisladores, reguladores, advogados e os próprios cidadãos.

Dessa forma, os *insights* da economia comportamental podem ser diretamente aplicados ao desenho de normas jurídicas para considerar e mitigar a influência das heurísticas e dos vieses (JOLLS; SUNSTEIN; THALER, 1998; THALER; SUNSTEIN, 2023). Ao compreender como as pessoas efetivamente se comportam, os

formuladores de políticas podem criar leis com maior probabilidade de alcançar seus objetivos. Isso implica ir além da suposição de atores racionais e considerar os fatores cognitivos e motivacionais que impulsionam o comportamento, incluindo-se as técnicas de regulação cognitiva na caixa de ferramentas da regulação (SUNSTEIN, 2018).

As normas legais podem assim ser estruturadas para aproveitar esses fatores, incentivando a conformidade e os resultados desejados. Kahneman (2012) observa que, embora os humanos não sejam irracionais, estes necessitam de ajuda para fazer julgamentos mais precisos e tomar decisões melhores, e que para isso, o Estado pode fornecer alguma ajuda, por meio de políticas públicas e das instituições. Exemplos de aplicação da economia comportamental na criação de normas incluem o desenho de opções padrão, o enquadramento eficaz da informação e o uso de normas sociais para influenciar o comportamento (THALER; SUNSTEIN, 2023). As opções padrão, por exemplo, podem aumentar significativamente a adoção de um comportamento desejado devido ao poder da inércia e ao viés do *status quo*.

No sentido econômico, as medidas jurídicas adotadas servem para impor determinados custos cognitivos, e nessa medida também servem para alterar a cadeia de incentivos, diferenciando-se das intervenções tradicionais apenas por preservar amplamente a liberdade de escolha e por significar um baixo custo ao tomador de decisão. O enquadramento da informação, por exemplo, ao destacar perdas ou ganhos potenciais, pode influenciar a tomada de decisão devido à aversão à perda e à teoria do prospecto (KAHNEMAN, 2012; TVERSKY; KAHNEMAN, 1979). O direito e a economia do comportamento oferecem assim uma estrutura para aprimorar a análise jurídica, considerando o comportamento humano real em contextos positivos, prescritivos e normativos (JOLLS; SUNSTEIN; THALER, 1998).

A integração da economia comportamental ao direito oferece um potencial significativo para a criação de normas mais eficazes, que considerem as realidades do comportamento humano. Ao superar as limitações do modelo do ator racional, o direito pode alcançar melhor seus objetivos de promover o comportamento pró-social, garantir a conformidade e melhorar o bem-estar social. A compreensão e a mitigação da influência das heurísticas e dos vieses cognitivos são cruciais para o desenho de normas e processos legais justos e eficazes. Na melhor visão, o *behavioral law and economics* incorpora uma abordagem interdisciplinar que combina *insights* da

economia comportamental com o *law and economics* tradicional, buscando entender como as leis e políticas públicas podem ser desenhadas considerando que os indivíduos nem sempre agem de forma plenamente racional, como assume a teoria econômica clássica³⁵.

A incorporação do *behavioral law and economics* no âmbito de discussão e decisão sobre políticas públicas está a se tornar algo tão rotineiro a ponto de merecer ser incorporada às formas tradicionais de regulação, a exemplo da análise custo-benefício (SUNSTEIN, 2018). Por certo, os formuladores de políticas públicas precisam estar pelo menos um passo adiante no que diz respeito ao que os humanos podem fazer e farão.

De outro lado, a adoção bem-sucedida do *law and economics* pelos operadores do direito depende ainda de maior estímulo entre os profissionais. Um dado relevante é trazido por Gelter e Grechenig (2014), que estudando a aplicação do *law and economics* na jurisprudência norte-americana identificaram uma estratégia institucional deliberada de formação de magistrados. Segundo os autores, Henry Manne estabeleceu cursos intensivos de microeconomia para juízes e professores de direito, alcançando resultado extraordinário: aproximadamente 40% dos juízes federais americanos haviam participado de tais cursos até 1990, facilitando aceitação da análise econômica nos tribunais. Esse dado empírico parece ter implicação direta para a aplicação da economia comportamental na regulação, visto que instrumentos regulatórios baseados em descobertas comportamentais certamente enfrentarão maior resistência judicial se os magistrados carecerem de formação básica sobre vieses cognitivos, heurísticas e limitações da racionalidade humana. No Brasil, um movimento similar poderia ser catalisado por meio de programas de formação continuada para magistrados e demais operadores do direito, garantindo que o arcabouço jurisprudencial evolua para acomodar a sofisticação analítica necessária à regulação comportamental efetiva do século XXI.

³⁵ Posner (2011, p.4) defende que o fato das pessoas nem sempre tomarem decisões racionais não invalida a teoria racional. Segundo o autor, a 'racionalidade' não é o mesmo que onisciência. A informação tem um custo, e muitas vezes os custos são proibitivos, especialmente quando a informação que se gostaria de ter diz respeito ao futuro. E a teoria da escolha racional aceita que a capacidade das pessoas de processar informações é limitada; em outras palavras, existem custos não apenas para obter informações, mas também para absorvê-las e usá-las. Além disso, o 'interesse próprio' não deve ser confundido com egoísmo; a felicidade (ou, por outro lado, o sofrimento) de outras pessoas pode fazer parte das satisfações de alguém. Para evitar essa confusão, os economistas geralmente preferem falar de 'utilidade' em vez de interesse próprio."

4.2.1 Paternalismo Libertário

O desenvolvimento da economia comportamental se deu diante da constatação de que certos mercados não regulados não conseguem alocar recursos de modo eficiente, e que a regulação tradicional, fundada na correção de falhas de mercado, não observava que os seres humanos têm dificuldades para tomar decisões em prol do seu próprio bem-estar. Assim, com o desenvolvimento de estudos que apontaram novos fatores que influenciam o comportamento humano, as premissas da posição liberal e antipaternalista foram questionadas (TEIXEIRA, 2024).

De modo geral, essas contestações ao modelo econômico tradicional se deram com propostas fundadas na intervenção do Estado, contudo, com aspectos suavizados, onde a ação do Estado deveria ser limitada, tanto quanto possível, a ações paternalistas mais suaves (*soft paternalism*), em oposição às tradicionais medidas de comando e controle (TEIXEIRA, 2024). O novo movimento, também identificado como *behavioral law and economics*, parece buscar resolver o problema de maximização do bem-estar sujeitando-se ao respeito à liberdade de escolha das pessoas (WRIGHT; GINSBURG, 2012).

A expressão paternalismo libertário³⁶, cunhada por Thaler e Sunstein (2003a), diz respeito à ideia de combinar a preocupação com o bem-estar das pessoas (paternalismo) com o respeito à sua liberdade de escolha (libertarianismo). O termo foi utilizado pela primeira vez pelos acadêmicos Richard Thaler e Cass Sunstein em um artigo publicado em 2003 na *American Economic Review*. Os autores introduziram o conceito para descrever uma abordagem que busca influenciar o comportamento das pessoas para melhorar seu bem-estar, conforme julgado por elas próprias, sem

³⁶ A expressão pode ser entendida como um oxímoro, unindo termos que parecem se opor, de forma intencional e provocativa. Yeung (2024) destaca que economistas notáveis como Gary Becker e Richard Posner reagiram ao trabalho de Sunstein e Thaler afirmando categoricamente que "paternalismo libertário" constitui efetivamente um oxímoro, ressaltando inconvenientes tanto no plano das ideias quanto em seu uso para políticas públicas. Segundo Becker, citado pela autora, "o libertarianismo não assume que as pessoas adultas nunca cometem erros em suas decisões. Ao invés disso, assume que pessoas adultas muito tipicamente conhecem seus interesses melhor do que oficiais do governo, professores universitários, ou qualquer outra pessoa". Yeung questiona ainda a quase impossibilidade de distinguir objetivamente uma política baseada em "paternalismo libertário" de outra fundamentada em "paternalismo puro", perguntando até onde os argumentos estatais de "estar fazendo o que é melhor para o bem social porque as pessoas não conseguem fazê-lo por si sós" são genuinamente justificados. Sunstein e Thaler, contudo, discordam e escreveram, em 2003, *Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron* (*University of Chicago Law Review*).

restringir sua liberdade de escolha. A ideia foi posteriormente elaborada em um artigo mais detalhado na *University of Chicago Law Review* (THALER; SUNSTEIN, 2003) no mesmo ano e popularizada no livro *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness* (2008, primeira edição).

É evidente que a utilização de *insights* comportamentais para moldar normas jurídicas suscita preocupações éticas relevantes, incluindo o potencial para paternalismo e manipulação (THALER; SUNSTEIN, 2023). Críticos argumentam que intervenções comportamentais podem infringir a autonomia individual e o direito de fazer escolhas, mesmo que essas escolhas nem sempre sejam ótimas. O conceito de paternalismo libertário busca exatamente mitigar essas preocupações, defendendo intervenções que orientem o comportamento, preservando a liberdade de escolha (THALER; SUNSTEIN, 2003). O objetivo declarado pelos autores é tão somente ajudar as pessoas a fazerem as escolhas que elas fariam se estivessem prestando atenção e tivessem todas as informações relevantes disponíveis. No entanto, a distinção entre orientação útil e manipulação indesejada pode ser tênue e controversa. Alguns estudiosos questionam a base empírica e a confiabilidade de certas descobertas comportamentais, levantando preocupações sobre a validade de sua aplicação em contextos legais (WRIGHT; GINSBURG, 2012)³⁷.

A garantia da robustez da ciência comportamental subjacente às intervenções legais é crucial para evitar consequências não intencionais. O potencial para intervenções que servem aos interesses dos formuladores de políticas em vez do bem público também é uma preocupação. Dessa forma, são necessárias salvaguardas

³⁷ A distinção entre erros racionais e irracionais revela-se crítica para avaliar necessidade de intervenções regulatórias, mas que pode ser facilmente negligenciada por defensores do paternalismo libertário. Wright e Ginsburg (2012) documentam caso ilustrativo onde aproximadamente 60% dos consumidores selecionaram um cartão de crédito "ótimo" quando oferecidos dois cartões (um com taxa de juros maior sem anuidade, outro com taxa menor e anuidade). Dos 40% que não selecionaram cartão ótimo inicialmente, muitos corrigiram o erro com a experiência, e apenas pequena minoria persistiu mantendo contratos substancialmente subótimos sem trocar. Crucialmente, magnitude desses erros mostrou-se limitada pelo valor da anuidade (tipicamente cerca de 25 dólares). Além disso, a probabilidade de selecionar cartão ótimo aumentou tanto com o custo do erro quanto com decisões repetidas, evidenciando aprendizado. Esses padrões são consistentes com a teoria dos preços e do comportamento racional, e não irracional. É dizer, o nível eficiente de erro não é zero quando custos de informação e transação para corrigir erro excedem benefícios da correção. Na saúde suplementar brasileira, lógica similar e aplicaria, onde a taxa inicial de "erro" de beneficiários na escolha de planos ou adesão ao Promoprev não indica automaticamente uma irracionalidade que justifique intervenção, mas pode refletir custos racionais de processamento de informação e ajuste que são inferiores aos ganhos potenciais de otimização, especialmente quando as diferenças entre alternativas são pequenas e as oportunidades de correção mediante troca de plano ou ajuste de comportamento preventivo permanecem disponíveis.

para garantir que os *insights* comportamentais sejam usados de forma ética e transparente. A principal salvaguarda contra um má arquitetura parece ser a preservação da liberdade de escolha (THALER; SUNSTEIN, 2023).

Vale pontuar, por fim, que não se chega a defender o chamado paternalismo assimétrico, defendido por Camerer *et al.* (2003), que busca reconhecidamente ajudar as pessoas a superarem a sua racionalidade limitada e evitarem um erro custoso, seguindo um caminho que chega a reconhecidamente prejudicar as pessoas mais racionais³⁸.

4.2.2 *Nudges* e arquitetura de escolhas

Os nudges são as intervenções que buscam direcionar os indivíduos para escolhas desejadas sem restringir sua liberdade ou alterar significativamente os incentivos econômicos (THALER; SUNSTEIN, 2023). Eles atuam influenciando a "arquitetura da escolha", que é a maneira como as opções são apresentadas, e visam para tornar certas escolhas mais atraentes ou fáceis. Já o arquiteto de escolhas tem a responsabilidade de organizar o contexto no qual as pessoas tomam decisões (THALER; SUNSTEIN, 2023).

Como cediço, os seres humanos possuem uma capacidade cognitiva notável, mas enfrentam limitações inerentes ao processar informações e tomar decisões em contextos complexos. Essas restrições decorrem de fatores como atenção finita, memória limitada e capacidade de raciocínio restrita, o que frequentemente resulta em escolhas subótimas. Diante de situações com múltiplas opções, as pessoas tendem a simplificar o processo decisório, recorrendo a estratégias como atalhos mentais que agilizam a tomada de decisão, mas que podem levar a erros sistemáticos,

³⁸ Diferentemente do paternalismo tradicional, que pode restringir a autonomia individual de maneira ampla e potencialmente ineficiente, o modelo assimétrico prioriza intervenções que beneficiam desproporcionalmente os "decisores limitados" — aqueles suscetíveis a falhas como procrastinação, hiperbolia descontada ou excesso de confiança —, enquanto preservam a liberdade de escolha para os agentes plenamente racionais. Essa assimetria é calculada como o ganho líquido para os decisores limitados menos o custo para os racionais, garantindo que a política regulatória atenda a critérios de eficiência e respeito à autonomia.

como a heurística da disponibilidade, que distorce a percepção de probabilidade com base em exemplos facilmente lembrados.

Além disso, a suposição de que um maior número de opções conduz a melhores resultados é equivocada. Estudos demonstram que o excesso de escolhas pode gerar o chamado "paradoxo da escolha", levando à paralisia decisória, insatisfação com a decisão tomada ou até mesmo à procrastinação, evidenciando que mais opções nem sempre significam um estado melhor (IYENGAR; LEPPER, 2000, SCHWARTZ, 2004). Dada essa realidade, torna-se essencial o uso de intervenções que auxiliem os indivíduos a navegarem em ambientes de decisão complexos, e é nesse contexto que os *nudges*, ou "empurrõezinhos", ganham relevância.

Essas estratégias consistem em ajustes sutis no ambiente de escolha, projetados para orientar as pessoas em direção a decisões mais benéficas, sem eliminar sua liberdade de escolha. Os *nudges* reconhecem assim as limitações cognitivas humanas e buscam facilitar o processo decisório de forma não coercitiva (não há mudanças significativas nos incentivos econômicos), tornando as alternativas desejáveis mais atraentes ou intuitivas. Ao invés de depender exclusivamente da capacidade individual de avaliar todas as possibilidades, essas intervenções oferecem suporte para que as decisões sejam mais alinhadas aos interesses de longo prazo do indivíduo, promovendo resultados mais favoráveis de maneira eficaz e respeitosa. Em vez de mudar as opções ou os incentivos econômicos das pessoas, podemos melhorar as decisões das pessoas mudando a forma como as opções são apresentadas a elas (ENGELEN; SCHMIDT, 2020).

A dimensão de custo regulatório constitui elemento distintivo central das intervenções comportamentais quando comparadas a instrumentos tradicionais de comando e controle. Sunstein (2018) documenta que nudges tipicamente envolvem custos de implementação substancialmente inferiores a regulações convencionais, visto que não requerem aparato fiscalizatório extensivo, processos sancionatórios complexos ou investimentos em infraestrutura material significativa. A OCDE (2017) quantifica essa vantagem comparativa ao relatar que o *Behavioural Insights Team* britânico opera com orçamento médio de £15.000 por projeto piloto, frequentemente gerando economias fiscais que excedem em dezenas de vezes o investimento inicial, como no caso de lembretes para pagamento de multas que elevaram arrecadação em £9 milhões com custo de implementação inferior a £100.000. Halpern e Sanders

(2016) complementam essa análise demonstrando que intervenções comportamentais apresentam relação custo-benefício particularmente favorável em contextos de restrição orçamentária, precisamente porque preservam liberdade de escolha sem depender de incentivos pecuniários diretos que onerariam os cofres públicos. No contexto regulatório brasileiro, essa característica reveste-se de relevância adicional considerando limitações fiscais crônicas que constroem capacidade estatal de implementar políticas redistributivas ou sistemas de monitoramento intensivo, tornando nudges alternativa pragmática que concilia efetividade comportamental com parcimônia de recursos.

Um *nudge* não pode ser um imposto, uma multa, um subsídio, uma proibição ou uma ordem (THALER; SUNSTEIN, 2023). Os *nudges* podem ser uma ferramenta valiosa no domínio jurídico para promover a conformidade, incentivar comportamentos pró-sociais e melhorar a tomada de decisão em diversas áreas (THALER; SUNSTEIN, 2023). Exemplos incluem a inscrição automática em planos de poupança para aposentadoria, a simplificação de formulários fiscais e o fornecimento de informações claras e salientes sobre obrigações legais. Até mesmo posicionar alimentos saudáveis em locais mais acessíveis em um refeitório pode incentivar escolhas alimentares melhores, mantendo as opções menos saudáveis disponíveis.

A aplicação de *nudges* no direito tem sido explorada em áreas como proteção ambiental, conformidade tributária, defesa do consumidor e melhoria da eficiência dentro do sistema de justiça (SUNSTEIN, 2018). A teoria dos *nudges*, desenvolvida por Richard Thaler e Cass Sunstein, enfatiza a influência nas escolhas de maneira a beneficiar os próprios indivíduos, conforme seu próprio julgamento (THALER; SUNSTEIN, 2023). Isso destaca a importância de garantir que os *nudges* sejam usados de forma ética e com os melhores interesses do indivíduo em mente. A compreensão de vieses cognitivos específicos, como a inércia (THALER; SUNSTEIN, 2023) e a aversão à perda (KAHNEMAN, 2012; TVERSKY; KAHNEMAN, 1979), informa diretamente o desenho de *nudges* eficazes.

Houve um enorme progresso na nossa capacidade de aplicar as ferramentas de ciência comportamental no combate a alguns dos maiores problemas do mundo. Exemplos de *Nudge Units* podem ser encontrados em países como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Índia, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Holanda, Japão, França e Alemanha, entre outros (OCDE, 2017). As Nações

Unidas, a Organização Mundial da Saúde e a comissão europeia vêm trabalhando sem parar nessa questão, quer o tema seja a pandemia de COVID-19, as mudanças climáticas, o terrorismo, o tabagismo, o crescimento econômico, a igualdade entre os sexos ou a segurança no trabalho, a ciência comportamental vem sendo usada com regularidade e até com naturalidade (THALER; SUNSTEIN, 2023). O sucesso de inúmeros projetos parece incentivar outros entes, agências governamentais e órgãos legais a adotarem intervenções comportamentais semelhantes para melhorar a conformidade e a eficiência.

Engelen e Schmidt (2020), buscando respaldo em evidências empíricas acerca da aceitação pública dos nudges, revisaram estudos e demonstraram que, comparados com intervenções tradicionais como tributação e multas, cidadãos tendem a aceitar mais prontamente nudges, particularmente quando promovem objetivos que endossam e são implementados por entidades com as quais podem se identificar. Pesquisas citadas pelos autores revelam que pessoas tipicamente acolhem bem nudges sob essas condições específicas, sugerindo que instrumentos comportamentais podem contornar alguns dos impasses partidários e ideológicos que frequentemente paralisam políticas públicas.

Conforme os problemas se apresentam, e sempre que o regulador se deparar com déficits informacionais significantes, é importante explorar ferramentas que tirem vantagens do que o setor privado conhece, por meio de ferramentas amigáveis ao mercado, como os *nudges* e os incentivos econômicos (SUNSTEIN, 2018). A aplicação de nudges oferece uma avenida promissora para orientar o comportamento em direções desejadas, respeitando a autonomia individual, mas requer cuidadosa consideração ética (THALER; SUNSTEIN, 2023). Deve-se cuidar, contudo, para que sua avaliação empírica seja contínua de modo a se verificar sua eficácia, identificar consequências não intencionais e refinar constantemente o seu desenho. Daí se fazer imprescindível a construção de um arcabouço legal que garanta ao uso do *behavioral law and economics* o potencial de ser uma ferramenta jurídica eficaz e eficiente e, em última análise, mais alinhado com as necessidades e realidades dos indivíduos e conduzindo a uma sociedade mais justa e equitativa.

O futuro da criação de normas legais reside na adoção de uma compreensão mais matizada e empiricamente informada do comportamento humano, com a

economia comportamental fornecendo ferramentas ao direito a partir de *insights* valiosos orientados a essa empreitada.

4.3 Efetividade na aplicação de nudges enquanto intervenções estatais

Com a popularização do *nudge*, decorrente sobretudo da sua inserção nos manuais de agências e órgãos regulatórios em diversos países, surgiram inúmeros estudos que buscaram estimar com maior precisão os verdadeiros efeitos dos *nudges* (TEIXEIRA, 2024). A OCDE identificou 196 equipes dentro de governos em todo o mundo, projetadas com o propósito de utilizar *insights* comportamentais para aprimorar as administrações nacionais (KHADZHYRADIEVA; HRECHKO; SAVKOV, 2019). Cidadãos de diversas sociedades apoiam os *nudges* e o *nudging*, não obstante os determinantes do nível de aprovação dos *nudges* ainda não estejam devidamente definidos até o momento. Por exemplo, não se sabe por que alguns tipos de *nudges* aplicados pelo setor público são aprovados por cidadãos de diferentes países em maior extensão, enquanto outros são ativamente desaprovados.

Com a sua forte popularização, as críticas ao uso de nudges como forma de intervenção estatal por meio da regulação também têm se multiplicado nas últimas décadas, questionando tanto a eficácia prática dessas ferramentas quanto seus fundamentos éticos e democráticos. A questão que se coloca é a necessária avaliação dos dados disponíveis para se aferir se os *nudges* são efetivos e possuem boa relação custo-benefício. As razões para duvidar da validade e eficiência da aplicação dos nudges envolvem preocupações substanciais quanto à autonomia dos indivíduos que são alvo dessas intervenções. A crítica central sustenta que os nudges violam a autonomia enquanto agência porque operam sobre processos cognitivos superficiais, rápidos e automáticos, explorando heurísticas e vieses sem engajar as capacidades reflexivas dos cidadãos (GIGERENZER, 2018). Essa manipulação de arquiteturas de escolha pode minar a capacidade das pessoas de constituírem suas próprias identidades ao longo do tempo, uma vez que suas decisões passam a ser influenciadas por fatores externos dos quais não têm consciência. A opacidade de muitos nudges agrava esse problema, pois frequentemente eles funcionam melhor

quando permanecem invisíveis aos indivíduos, o que os torna difíceis de monitorar e criticar publicamente (GIGERENZER, 2018). Além disso, mesmo quando os nudges são transparentes, permanece a questão de quem define os objetivos a serem perseguidos e com base em quais critérios, levantando preocupações epistemológicas sobre como os formuladores de políticas podem conhecer as verdadeiras preferências e o bem-estar dos cidadãos (SCHMIDT; ENGELEN, 2020).

Gerd Gigerenzer (2018) ainda critica o que denomina de "viés do viés" na economia comportamental, argumentando que os proponentes dos *nudges* superestimam sistematicamente as falhas cognitivas humanas e, com isso, justificam intervenções paternalistas desnecessárias que subestimam as capacidades intuitivas das pessoas³⁹. A eficácia empírica dos *nudges* também tem sido questionada de forma crescente na literatura científica. Uma meta-análise desenvolvida por Maximilian Maier e outros colaboradores buscou demonstrar que, após correção para viés de publicação, não há evidências consistentes de que os *nudges* sejam efetivos, sugerindo que os estudos publicados podem ter selecionado sistematicamente resultados positivos (MAIER et al., 2022). Mesmo meta-análises que identificam efeitos positivos, como a de Mertens e colaboradores, encontram tamanhos de efeito pequenos a médios e reconhecem a presença de viés de publicação moderado, além de significativa variação contextual na efetividade das intervenções (MERTENS et al., 2022). Cass Sunstein (2016), um dos principais defensores dos nudges, reconhece que muitos deles falham ou são menos efetivos do que se esperava, seja porque as pessoas possuem preferências antecedentes fortes que resistem à arquitetura de escolhas, seja porque contra-nudges de outros atores neutralizam os efeitos pretendidos, ou ainda porque os nudges produzem comportamentos compensatórios que anulam seus benefícios. A variação da eficácia entre diferentes contextos culturais e grupos sociais, bem como a possibilidade de efeitos de curto prazo que não se

³⁹ Gigerenzer (2018) insiste que os vieses cognitivos persistentes podem ser corrigíveis simplesmente a partir de uma educação dirigida. Nesse sentido, o autor documenta que quando estudantes universitários receberam curso de duas horas sobre frequências naturais, o número de inferências bayesianas corretas aumentou de 10% para 90%, taxa mantida três meses após o treinamento. Resultados similares foram observados entre médicos: apenas 21% de ginecologistas inferiam corretamente probabilidade posterior de câncer de mama após mamografia positiva quando informação era apresentada em probabilidades condicionais, mas a taxa aumentaria para 87% após treinamento em frequências naturais. Meta-análises confirmariam assim o efeito de "desenviesamento" (*de-biasing*), e frequências naturais tornaram-se o termo técnico em medicina baseada em evidências. Ainda segundo o autor, essas descobertas contradizem diretamente o argumento central dos defensores de *nudges*: que vieses são teimosos (*stubborn*) como ilusões visuais e resistentes à educação.

sustentam no tempo, reforçam as dúvidas sobre a aplicabilidade universal dessas ferramentas como instrumentos de política pública (MERTENS et al., 2022).

A simplificação radical de informações, uma consequência aparentemente desejável, também pode gerar resultados sistêmicos contraditórios quando se opera em mercados caracterizados por seleção adversa, como a saúde suplementar. Handel (2013) demonstra empiricamente esse aparente paradoxo ao quantificar o impacto de políticas que reduzem a inércia em 75% em contexto de seguros de saúde patrocinados por empresas no Estados Unidos, onde se verificou que o mecanismo causal induziu consumidores saudáveis que inicialmente escolheram planos abrangentes por inércia, e ao serem *nudgeados* para reotimização ativa, migram para planos menos abrangentes, elevando sinistralidade e prêmios dos planos compreensivos, tornando-os inacessíveis mesmo para consumidores avessos a risco que genuinamente os valorizam. As evidências colhidas apontam que a democratização de acesso e a simplificação informacional devem ser acompanhadas por mecanismos de *risk adjustment* efetivos entre operadoras, caso contrário ferramentas comportamentais desenhadas para melhorar escolhas individuais podem exacerbar seleção adversa sistêmica, resultado oposto ao pretendido pela regulação por *nudges* (HANDEL, 2013).

Por outro lado, a efetividade dos *nudges* aplicados à regulação pode ser verificada por meio das ações desenvolvidas por órgãos e agências da Administração superior em diversos países. Exemplos notáveis advêm do *Behavioural Insights Team* do Reino Unido, criado em 2010, e o *Social and Behavioral Sciences Team* dos Estados Unidos, estabelecido em 2014 (THALER; SUNSTEIN, 2023). No Reino Unido, David Halpern, psicólogo e diretor executivo do *Behavioural Insights Team*, documenta como essa unidade cresceu de uma pequena equipe para uma organização com aproximadamente 150 funcionários e escritórios em diversos países, tendo conduzido mais de 800 projetos e 400 ensaios clínicos randomizados, demonstrando a escala e o alcance dessa abordagem (HALPERN; SANDERS, 2016).

Saurabh Bhargava e George Loewenstein defendem que os *nudges* representam apenas o início de uma integração mais ampla da economia comportamental nas políticas públicas, argumentando que intervenções mais ambiciosas podem simplificar produtos complexos, proteger consumidores de

exploração comportamental e aprimorar o desenho de instrumentos tradicionais de política (BHARGAVA; LOEWENSTEIN, 2015).

A OCDE documentou extensivamente a aplicação de *insights* comportamentais em políticas públicas globalmente (OCDE, 2017). A análise da organização revela que, enquanto diversas experiências foram conduzidas em áreas como saúde pública, produtos financeiros e serviços governamentais, as aplicações diretas no campo dos seguros de saúde também aparecem principalmente vinculadas a contextos de renovação de seguros gerais e escolhas de produtos financeiros complexos. De acordo com a OCDE (2017), entre fevereiro de 2015 e janeiro de 2020, a Agência de Saúde Pública do Canadá desenvolveu o aplicativo móvel *Carrot Rewards*, que usaria o incentivo de recompensas de pontos de fidelidade para motivar indivíduos a aprender sobre e implementar comportamentos saudáveis. O projeto foi projetado para fornecer aos canadenses registrados em programas de fidelidade populares a oportunidade de ser recompensados com sua escolha de pontos de fidelidade por aprender sobre e implementar comportamentos saudáveis, incluindo fazer um questionário sobre saúde cardíaca, aprender sobre escolhas alimentares saudáveis, participar de atividade física ou visitar uma YMCA local. O conceito baseou-se em economia comportamental e teorias de *nudge*, a ideia sendo usar incentivos na forma de pontos de recompensas de fidelidade populares e tecnologia de aplicativo móvel acessível para empurrar indivíduos em direção a escolhas de estilo de vida mais saudáveis e responsáveis.

Outro bom exemplo de intervenção com o uso de *nudges* é documentado pela Agência de Saúde de New South Wales (Austrália). Esta agência implementa desde o ano de 2010 o programa *Between the Flags* (BTF) baseado em princípios comportamentais para melhorar o reconhecimento de deterioração clínica de pacientes (OCDE, 2017). O programa utiliza gráficos de observação padronizados com codificação por cores, incorporando zonas de análise clínica e resposta rápida claramente identificadas em cores amarela e vermelha. Esta intervenção endereça vieses comportamentais como cegueira involuntária e sobrecarga cognitiva, facilitando a atenção dos profissionais de saúde aos pacientes em deterioração. Uma avaliação interina de 2013 encontrou redução de 25% em paradas cardíacas inesperadas, com 70% do pessoal concordando que a Zona Amarela assistiu na

detecção mais precoce de pacientes em risco e 87% concordando que a zona assistiu em gestão anterior do risco de deterioração (OCDE, 2017).

Diante de todo o arcabouço teórico e empírico apresentado ao longo deste capítulo, é possível concluir que a economia comportamental proporciona fundamentação robusta e metodologicamente refinada para a regulação de setores complexos como a saúde suplementar. A partir de seus conceitos-chave — heurísticas, vieses cognitivos, paternalismo libertário e *nudges* — demonstrou-se que os agentes econômicos não aderem sistematicamente ao modelo do *homo economicus* proposto pela microeconomia neoclássica. Em seu lugar, evidências empíricas documentadas em contextos internacionais diversos revelam que intervenções simples e de baixo custo, baseadas no entendimento adequado dos processos decisórios humanos, podem produzir resultados significativos na melhoria de desfechos econômicos e sociais. A efetividade de tais intervenções não decorre de coerção ou restrição de liberdade individual, mas justamente da aplicação cuidadosa de princípios do paternalismo libertário que mantêm a autonomia decisória enquanto reorientam a arquitetura de escolhas disponíveis.

Neste sentido, a regulação adequada da saúde suplementar brasileira reclama, necessariamente, incorporação sistemática destes fundamentos comportamentais no desenho de seus instrumentos regulatórios, como a seguir exploraremos. É sobre as falhas de desenho na arquitetura de escolha e sobre as potenciais intervenções regulatórias de baixo custo (*nudges*) que o próximo capítulo se debruçará, buscando concretizar os objetivos de eficiência e equidade na saúde suplementar.

5 APLICAÇÕES DO *BEHAVIORAL LAW AND ECONOMICS* NA SAÚDE SUPLEMENTAR

5.1 Introdução

Até aqui, buscamos compreender melhor o setor da saúde suplementar e suas especificidades. Na sequência, abordamos em nível introdutório os temas *law and economics* e *behavioral law and economics* em compasso com a ideia de que o direito pode ser entendido como um instrumento modulador de comportamentos, o que nos habilita a realizar alguns testes de aplicação da teoria à prática. Como visto, o *law and economics* tem sido utilizado para explicar o sistema legal como ele se apresenta e para se recomendar mudanças que possam promover eficiência.

A seguir, o presente estudo se orienta sob uma perspectiva normativa, examinando, à luz dos problemas identificados, quais políticas legais e regulatórias podem ser úteis para alcançar determinados objetivos, tendo como foco a eficiência em seu nível ótimo, segundo o critério de Kaldor-Hicks. Considerando a extensa lista de falhas de mercado e de problemas regulatórios já identificados no setor da saúde suplementar, a pesquisa adotou um desenho metodológico exploratório-analítico. Foram examinadas 40 resoluções normativas vigentes da ANS⁴⁰, sendo estas categorizadas segundo suas dimensões temáticas e relevância ao problema de pesquisa, cuja relação completa encontra-se detalhada no Apêndice A deste trabalho. Após aplicação dos critérios de corte analítico estabelecidos no trabalho, identificou-se que duas Resoluções Normativas apresentam forte articulação com os objetivos centrais da investigação: a Resolução que instituiu o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) e aquela que disciplina o Programa de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças (Promoprev). A análise pormenorizada dos dispositivos dessas normas específicas, correlacionando o comando legal com a

⁴⁰ As Resoluções Normativas examinadas foram as atualmente vigentes e que exploram temas específicos do setor, com numeração concentrada entre 482 e 623, mas não somente. Para fins de compreensão histórica, também foram objeto de exame algumas Resoluções Normativas já revogadas, como as de número 264 e 265, que trataram originalmente do programa Promoprev. A lista integral dos normativos pesquisados consta no Apêndice I.

intervenção comportamental correspondente (existente ou sugerida), foi sistematizada nos quadros analíticos apresentados nos Apêndices B, C e D, os quais fundamentam as críticas e proposições desenvolvidas nas seções subsequentes.

A opção pela pesquisa exploratória deu-se pela emergência do campo de aplicação da economia comportamental na regulação da saúde suplementar brasileira, demandando assim uma abordagem investigativa que privilegiasse a identificação de lacunas regulatórias, a formulação de proposições teóricas e o estabelecimento de agenda para investigações empíricas futuras. O objetivo reside em aferir primeiro se os *insights* do *behavioral law and economics* têm sido levados em consideração no processo regulatório⁴¹ enquanto modeladores de incentivos⁴², e segundo na tentativa de se avaliar alguns possíveis resultados positivos decorrentes dessa aplicação, à luz do custo-efetividade, considerando a necessidade de medidas regulatórias de baixo custo pelos agentes do setor, por meio de estratégias inspiradas em abordagens comportamentais e que não impliquem em custos gravosos aos seus executores. A característica do baixo custo regulatório dos *nudges* fundamenta-se em três dimensões: (i) não alteram significativamente incentivos econômicos, dispensando subsídios ou transferências fiscais diretas; (ii) preservam liberdade de escolha, eliminando custos de fiscalização e *enforcement* típicos de proibições; e (iii) aproveitam infraestrutura comunicacional preexistente, reduzindo investimentos em novos aparatos burocráticos (THALER; SUNSTEIN, 2023). Em acordo com o que argumenta Sunstein (2018), intervenções comportamentais devem representar alternativa particularmente atrativa em contextos de restrição orçamentária, pois alteram comportamentos mediante ajustes na arquitetura de escolhas sem onerar cofres públicos.

As limitações encontradas durante a pesquisa são em parte justificadas pelos déficits de transparência nos mecanismos participativos da ANS, na medida em que a agência não disponibiliza todas as contribuições e documentos técnicos que embasaram a sua produção normativa. Conforme Salinas (2021) documenta, a agência publicou relatório completo de análise de contribuições em apenas 29,2% dos 89 mecanismos realizados entre 2001 e 2019, prejudicando análise sobre quem

⁴¹ A regulação é comumente pensada como a atividade que restringe comportamentos e previne a ocorrência de certas atividades indesejadas (BALDWIN; CAVE; LODGE, 2012).

⁴² Quando os incentivos não estão bem alinhados, é papel do governo tentar realinhá-los e corrigir o problema (THALER, 2023, p.265).

efetivamente participa e influencia nos processos regulatórios. Em 72,2% das contribuições analisadas pela autora, não foi possível identificar sequer se a ANS aceitou ou rejeitou as manifestações devido à ausência ou incompletude de relatórios oficiais.

Esta opacidade dificulta tanto pesquisa acadêmica quanto uma *accountability* democrática, impedindo que beneficiários compreendam quais interesses prevalecem na formulação de normas que afetam diretamente seus direitos. A Lei Geral das Agências Reguladoras (Lei n. 13.848/2019) buscou mitigar esse problema ao tornar obrigatória a publicação de relatórios detalhados, mas a implementação efetiva ainda permanece um desafio. Para esta dissertação, a limitação da transparência nos registros oficiais impacta na avaliação conclusiva sobre se e como instrumentos como o IDSS e o Promoprev incorporam efetivamente contribuições comportamentais.

5.2 Como escolher (e manter) o melhor plano de saúde

5.2.1 Quando a decisão é complexa e há muito em jogo (*when the stakes are too high*)

Segundo a teoria econômica clássica, a escolha de um plano de saúde deveria ser uma decisão puramente racional, baseada na maximização de benefícios e na minimização de custos (SINAIKO; HIRTH, 2009).

No Brasil, as operadoras que ofertam planos de saúde privados apresentam uma ampla diversidade de opções disponíveis aos consumidores, refletindo a tentativa de atender a variados perfis e necessidades (ANDRADE et al., 2012). Contudo, essa multiplicidade gera um problema significativo: a complexidade de escolha⁴³. Os usuários enfrentam dificuldades para selecionar o plano mais adequado devido ao elevado número de variáveis a considerar, incluindo modalidades (individuais, familiares, coletivos empresariais ou por adesão), tipos de coberturas (ambulatório,

⁴³ Thaler (2013) comenta exemplo similar de complexidade na escolha na previdência suéca.

hospitalar, obstetrícia, odontológica), redes de assistência (hospitais, clínicas e profissionais credenciados), abrangência geográfica (local, regional, nacional ou internacional) e mecanismos de regulação financeira (franquias, coparticipações e reembolsos) (SINAIKO; HIRTH, 2009). Ademais, a nomenclatura dos produtos, frequentemente composta por termos como "basic", "plus", "gold", "diamond", "superior" e "ultimate", contribui para a confusão, pois tais denominações nem sempre indicam claramente as diferenças entre os planos. Esse cenário resulta no "paradoxo da escolha", fenômeno em que o excesso de alternativas dificulta a tomada de decisão, levando a escolhas inadequadas e insatisfação (SCHWARTZ, 2004).

As repercussões negativas dessa complexidade são múltiplas e impactam tanto os consumidores quanto as operadoras e o sistema de saúde suplementar como um todo. Primeiramente, a dificuldade em compreender e comparar os planos leva a decisões subótimas, nas quais os consumidores podem optar por coberturas excessivas, arcando com custos desnecessários, ou por planos insuficientes, enfrentando despesas imprevistas. Isso aumenta a insatisfação e o *churn* (troca frequente de operadoras), elevando os custos administrativos das empresas (SINAIKO; HIRTH, 2009). Além disso, a complexidade afeta a eficiência no uso de recursos, pois planos mal escolhidos podem desincentivar cuidados preventivos ou levar ao uso excessivo de serviços, sobrecarregando o sistema. O aumento de custos é outra consequência, uma vez que a manutenção de uma vasta gama de produtos e a gestão de planos variados elevam os custos operacionais das operadoras. A complexidade pode ampliar desigualdades, pois consumidores com menor literacia em saúde tendem a fazer escolhas menos vantajosas, comprometendo o acesso a cuidados de maior qualidade (SINAIKO; HIRTH, 2009, MORAES; ARAÚJO, 2009).

Essa multiplicidade de fatores cria uma "sobrecarga cognitiva", onde a quantidade de informações excede nossa capacidade de processá-las adequadamente. Conforme as evidências trabalhadas no campo da economia comportamental, em situações de alta pressão e complexidade, os indivíduos tendem a recorrer a heurísticas, onde os chamados atalhos mentais buscarão simplificar o processo decisório, mas que podem levar a erros sistemáticos (THALER; SUNSTEIN, 2023). Diferentemente do "agente racional" da teoria econômica neoclássica, os seres humanos operam com essas restrições cognitivas fundamentais e muitas vezes se tornam alvos fáceis de agentes que exploram oportunisticamente contextos de alta

complexidade. A racionalidade limitada impedirá o processamento de muitas informações e a nossa memória mostra-se restrita para armazenar e recuperar dados relevantes, tudo isso geralmente em tempo insuficiente para avaliar todas as alternativas possíveis. Essas limitações tornam-se críticas quando enfrentamos decisões de alta complexidade ou, como dizem os americanos, *when the stakes are too high* (THALER; SUNSTEIN, 2023).

No setor brasileiro de saúde suplementar, esse desenho de oferta frequentemente resulta em decisões baseadas em critérios superficiais, decorrentes de heurísticas de valor duvidoso como o reconhecimento de marcas ou de preços aparentemente mais baixo, sem consideração adequada dos aspectos técnicos fundamentais. Ocorre que a decisão sobre planos de saúde é intrinsecamente complexa porque envolve múltiplas etapas e dimensões de análise que devem ser adequadas ao perfil e às necessidades específicas de cada usuário.

Conforme visto acima, primeiramente há uma dimensão temporal, visto que as necessidades de saúde dos usuários evoluem ao longo da vida, e o que pode ser adequado hoje pode tornar-se insuficiente no futuro. Um jovem saudável pode priorizar preço baixo e cobertura básica, enquanto uma família com crianças pequenas ou idosos necessita de cobertura mais abrangente e rede credenciada robusta.

A dimensão geográfica da escolha do plano também adiciona uma camada de complexidade. Com efeito, um mesmo consumidor pode avaliar como excelente um determinado plano de saúde tendo em conta a rede credenciada no município onde reside, e ao mesmo tempo considerar o produto inadequado caso seja um viajante frequente, diante de eventual restrição ou limitação de rede em outras localidades. A dimensão médica exige do usuário tomador de decisão um conhecimento especializado sobre diferentes tipos de procedimentos, especialidades, e tecnologias médicas que podem ser necessárias. A dimensão financeira vai certamente além do preço mensal, incluindo-se os demais instrumentos financeiros de regulação como coparticipações e franquias, além dos reajustes históricos e da perspectiva futura de aumento nas mensalidades.

Ainda mais desafiador é o fato de que essas dimensões não são independentes — elas interagem de formas complexas e às vezes contraditórias. Um plano com

mensalidade baixa pode ter coparticipação alta, rede credenciada restrita, ou histórico de reajustes acima da média. Essa interdependência torna praticamente impossível para o consumidor médio realizar uma análise verdadeiramente otimizada sem ferramentas adequadas de apoio à decisão.

A complexidade da decisão é drasticamente agravada pela profunda assimetria de informação que caracteriza o mercado de saúde suplementar (AZEVEDO et. al., 2016). Esta assimetria opera em múltiplas direções e níveis, criando um ambiente onde as operadoras detêm informações críticas que não são transparentes ou facilmente acessíveis aos consumidores. No nível mais básico, as operadoras possuem dados detalhados sobre seu próprio desempenho: índices de negativa de cobertura, tempo médio de autorização de procedimentos, histórico completo de reajustes, dados atuariais sobre sinistralidade, e projeções financeiras futuras. Essas informações, fundamentais para uma escolha informada, muitas estão disponibilizadas à ANS por exigência regulatória⁴⁴, raramente chegam ao consumidor de forma compreensível e comparável.

A assimetria também se manifesta na linguagem técnica utilizada nos contratos e materiais informativos. Termos como "cobertura parcial temporária" (fica pior quando tratado nas propostas e apólices apenas pela sigla "CPT"), "período de carência", "rol de procedimentos da ANS", ou "mecanismos financeiros de regulação" são familiares para profissionais do setor, mas constituem verdadeiros enigmas para consumidores

⁴⁴ A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) instituiu um conjunto integrado de sistemas de informação, que funcionam como infraestrutura crítica para o exercício de suas competências fiscalizadoras, normativas e de promoção da transparência do mercado. Dentre estes, destacam-se alguns sistemas, cada um com uma finalidade específica no arcabouço de governança de dados. O Sistema de Informação de Beneficiários (SIB) constitui o cadastro nacional unificado de todos os usuários de planos de saúde e permite à ANS manter um registro preciso e atualizado da população coberta, sendo a principal fonte para estatísticas de cobertura e para a validação de direitos. O Sistema de Informações de Produtos (SIP) atua como o repositório oficial de todas as características dos planos de saúde comercializados. Nele, são registrados os dados contratuais, de cobertura assistencial, valores de carência e mensalidades. O SIP é instrumental para a transparência do mercado, pois alimenta os canais de consulta pública, permitindo que consumidores comparem produtos, e fornece à ANS a base legal para auditar a conformidade dos contratos com a legislação. Para monitorar a utilização efetiva dos serviços, o Sistema de Eventos em Saúde (SES) recebe dados detalhados de toda a atividade assistencial prestada aos beneficiários, incluindo consultas, exames e procedimentos. Este sistema é vital para a produção de indicadores de qualidade, o monitoramento do perfil de utilização, a identificação de possíveis irregularidades como superfaturamento e para subsidiar a tomada de decisão baseada em evidências pela agência. Com foco mais específico, o Sistema de Comunicação de Internação Hospitalar (CIH) exige a notificação obrigatória de toda internação em até um dia útil após sua ocorrência. Este mecanismo possibilita um monitoramento em tempo quase real de eventos graves, facilita a gestão de autorizações de procedimentos de alta complexidade e agiliza a resposta da ANS a situações críticas, como a investigação de surtos em unidades hospitalares.

leigos (MORAES; ARAUJO, 2009). Esta barreira linguística não parece ser acidental — ela serve como mecanismo de proteção para as operadoras, dificultando comparações diretas e questionamentos específicos⁴⁵.

Outro desafio importante reside na assimetria temporal de informações. Enquanto as operadoras têm acesso a séries históricas completas sobre reclamações, judicializações, e desempenho operacional, os consumidores frequentemente baseiam suas decisões em informações pontuais, *marketizadas*, ou em experiências anedóticas de terceiros. Um plano pode ter excelente reputação baseada em desempenho passado, mas estar enfrentando problemas operacionais recentes que ainda não se tornaram públicos.

A assimetria informacional regulatória adiciona mais uma camada de complexidade. As operadoras têm departamentos jurídicos especializados que acompanham mudanças na legislação, decisões da ANS, e precedentes judiciais. Conseguem antecipar e se adaptar rapidamente a mudanças regulatórias, às vezes alterando produtos ou estratégias antes mesmo que os consumidores compreendam as implicações dessas mudanças para seus direitos e coberturas (MORAES; ARAUJO, 2009). Esta situação cria um ambiente onde o consumidor opera, essencialmente, às cegas. Com efeito, o consumidor não consegue saber, ou avaliar de modo adequado, quais operadoras têm histórico problemático de negativas de

⁴⁵ Atualmente, parece existir uma babel dos nomes derivados de marketing enganoso e que provocam uma paralisia na escolha do consumidor. Com efeito, o mercado de saúde suplementar brasileiro sofre de uma proliferação descontrolada de produtos com nomenclaturas grandiosas que, na prática, dificultam qualquer comparação racional entre planos. As operadoras empregam uma linguagem de marketing hiperbólica, criando categorias como "Metais Preciosos" (Gold, Platinum, Diamond), "Grandiosidade Espacial" (Mega, Ultra, Supreme), "Exclusividade Social" (Executive, Premium, VIP, Privilege), "Proteção Máxima" (Total, Completo, 360), entre outras denominações que prometem diferenciação sem substância real. Esta estratégia deliberada resulta no fenômeno conhecido como "choice overload" ou sobrecarga de opções, onde consumidores enfrentam centenas de produtos aparentemente distintos, mas funcionalmente similares, criando um ambiente de confusão informacional que torna impossível identificar qual plano oferece melhor custo-benefício para suas necessidades específicas.

A combinação de excesso de opções mal diferenciadas e linguagem técnica incompreensível (termos como "cobertura parcial temporária", "mecanismos financeiros de regulação", "rede credenciada referenciada") produz paralisia decisória, levando consumidores a tomarem decisões subótimas baseadas em critérios superficiais como preço mais baixo ou nome mais atrativo. Esta disfunção informacional não apenas prejudica decisões individuais, mas gera consequências sistêmicas: redução da concorrência real baseada em qualidade, direcionamento de recursos para marketing em vez de melhorias substanciais nos serviços, judicialização excessiva quando consumidores descobrem limitações não antecipadas, e desconfiança generalizada no setor. O resultado é um mercado onde mais opções significam, paradoxalmente, menos liberdade real de escolha, subvertendo a promessa do livre mercado de que a competição levaria a produtos melhores e preços mais justos.

cobertura, que praticam reajustes sistemáticos acima da média, quais têm redes credenciadas instáveis, ou quais enfrentam problemas financeiros que podem afetar a continuidade dos serviços.

O problema não se encerra na escolha inicial do plano de saúde, mas persiste ou até se agrava quando consideramos a inércia humana, vista como um viés comportamental que nos impede de agir mesmo diante de evidências claras de prejuízo. Imagine um consumidor que, após anos com um plano ineficiente, identifica opções melhores com coberturas mais amplas e custos menores, mas hesita em trocar por medo de burocracias ou apego ao status quo – essa "paralisia por inércia" reforça falhas de mercado na saúde suplementar. Estudos em economia comportamental destacam que tal inércia leva a uma adesão prolongada a contratos subótimos (THALER, SUNSTEIN, 2023), perpetuando desigualdades e ineficiências no sistema regulado pela ANS. Assim, mesmo reconhecendo uma situação pior, o indivíduo tende a manter o plano atual, agravando o impacto das falhas comportamentais na tomada de decisão racional.

5.2.2 O IDSS: Um propósito louvável, uma execução deficiente

Para auxiliar o consumidor nesse contexto complexo de decisão, a ANS desenvolveu uma ferramenta simples e direta: o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS). Assim como consultamos avaliações de hotéis antes de fazer uma reserva ou verificamos rankings de restaurantes antes de jantar, o IDSS se apresenta como um "guia de qualidade", com a proposta de transformar informações complexas em uma nota, representativa do melhor desempenho entre as opções disponíveis.

O IDSS foi criado pela ANS como parte do Programa de Qualificação das Operadoras (PQO)⁴⁶. A sua criação foi precedida da Consulta Pública ANS nº 46,

⁴⁶ De acordo com a agência, a ideia de criação de um Programa de Avaliação da Qualidade das Operadoras (PQO) surgiu em 2004, e vem sendo consolidada ao longo das duas últimas décadas (ANS, 2024). O Programa de Qualificação das Operadoras (PQO), atualmente instituído pela RN ANS n. 505, substituiu os mecanismos anteriores de avaliação de desempenho, previstos nas revogadas

ocorrida de 28 de setembro a 4 de novembro de 2011, onde foram apresentadas propostas técnicas, as quais foram posteriormente discutidas e aprofundadas no âmbito da Câmara Técnica criada especificamente para tratar do assunto (ANS, 2011b). O propósito do indicador é inquestionavelmente louvável: criar uma métrica objetiva e comparável que traduza, em uma escala de 0 a 1, a qualidade e o desempenho das operadoras em quatro dimensões críticas⁴⁷. A nota das dimensões é apurada por um conjunto de 33 indicadores. A ideia é possibilitar ao usuário que, insatisfeito com seu plano atual, consulte o IDSS para comparar indicadores de qualidade, como sustentabilidade econômico-financeira e satisfação dos beneficiários, facilitando uma decisão mais informada e racional na hora de trocar por uma opção melhor.

De acordo com a ANS (2025), dentre principais objetivos do IDSS, constam a redução da assimetria de informação no setor, estimular a qualidade setorial, propiciar um *benchmarking* entre as operadoras e subsidiar a escolha de um plano de saúde.

Nos termos da Resolução Normativa ANS n. 505⁴⁸, os indicadores avaliados para a composição do IDSS são agregados em 4 dimensões (art. 10). A primeira dimensão, "da qualidade na atenção à saúde" (IDQS), avalia aspectos como promoção da saúde, prevenção de riscos e doenças, e qualidade assistencial. A dimensão da "garantia de acesso" (IDGA) avalia condições relacionadas à rede assistencial, verificando a adequada oportunidade, no tempo e no espaço, da rede ofertada ao usuário, a compreender o plexo de consultórios, hospitais, ambulatórios, laboratórios e centros diagnósticos da rede própria ou credenciada. A dimensão da

Resoluções Normativas nº 386/2015 e nº 423/2017. O objetivo do programa é fomentar a transparência, a concorrência baseada em valor e a melhoria contínua na prestação de serviços de saúde, avaliando anualmente o desempenho das operadoras de planos médico-hospitalares, médico-hospitalares com odontologia ou exclusivamente odontológicos por meio do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS). Essa nova estrutura regulatória visa não apenas corrigir falhas de mercado, como a assimetria informacional que afeta escolhas de beneficiários, mas também integra o PQO a outros programas regulatórios, como, por exemplo, a Acreditação de Operadoras (RN nº 507/2022), já que se exige um IDSS mínimo de 0,6 para elegibilidade à certificação voluntária de boas práticas, fomentando assim um ecossistema de qualificação contínua que equilibra inovação setorial com proteção ao usuário.

⁴⁷ Uma proposta ampliada de pesquisa poderia ainda abranger o chamado "Caminho do Consumidor", um submenu presente no site da ANS que supostamente se presta a esclarecer o consumidor para uma decisão mais informada.

⁴⁸ Uma análise detida desta resolução, sob a ótica da arquitetura de escolhas, permite identificar dispositivos que já tangenciam estratégias comportamentais — como a saliência de informações e o uso de feedback contínuo. O mapeamento completo desses dispositivos e as respectivas intervenções de economia comportamental sugeridas para potencializar a eficácia do índice estão consolidados no Apêndice B.

“sustentabilidade no mercado” (IDSM) avalia o equilíbrio econômico-financeiro das operadoras, examinando a solidez financeira, a capacidade de honrar compromissos futuros e a adequação das reservas técnicas. Também é neste indicador que se perquire aspectos associados à satisfação dos usuários com os serviços prestados e adquiridos, a partir de indicadores como o de permanência dos beneficiários e de medição de gravidade das infrações à legislação cometidas por parte das operadoras. Por fim, a dimensão de “gestão de processos e regulação” (IDGR) avalia a plena aderência às exigências regulatórias e o cumprimento da legislação, especialmente quanto ao cumprimento das obrigações técnicas e cadastrais das operadoras junto a ANS (ex.: padrão TISS, DIOPS, SIB, etc).

Em teoria, o IDSS deveria funcionar como uma bússola confiável para consumidores, permitindo escolhas mais informadas e racionais. Deveria reduzir significativamente a assimetria informacional, democratizar o acesso a informações de qualidade, e criar incentivos de mercado para melhoria contínua do setor. Nesse sentido, a regulação da agência busca induzir o mais amplo alcance do IDSS, de modo que o usuário tenha acesso facilitado às notas obtidas por sua operadora de preferência. Para tanto, é dever da operadora divulgar o resultado do IDSS geral e de cada uma das dimensões do programa em seu sítio institucional na internet, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data de divulgação dos resultados pela ANS (art. 22 da RN ANS n. 505). Os resultados do IDSS devem ser mantidos no sítio institucional da operadora na internet até que seja substituído pelos resultados da divulgação do ano seguinte (parágrafo único do art. 22). Além disso, a ANS confere facultatividade às operadoras para que estas divulguem, na propaganda de seus produtos, os resultados obtidos no IDSS (art. 21 da RN ANS n. 505).

Outro poderoso instrumento notabilizado pela ANS com o uso do IDSS é por meio das pesquisas de satisfação dos usuários, as quais devem compor o índice de avaliação na dimensão de sustentabilidade no mercado (IQSM). Evidências sugerem que a contabilização dos resultados das pesquisas de satisfação servem para uma melhor avaliação da experiência em geral, induz a fidelização e o engajamento do usuário, que passa a interagir melhor com a empresa que desenvolve uma cultura centrada no cliente (REICHHELD, 2011). De acordo com a metodologia *Net Promoter Score* (NPS), desenvolvida por Frederick Reichheld, a medição sistemática da satisfação por meio de pesquisas está positivamente correlacionada com

rentabilidade e crescimento organizacional, estabelecendo a base teórica para a relação entre mensuração de satisfação, fidelização e desempenho empresarial. Atenta a isso, a ANS conferiu uma pontuação bônus ao IDSS relacionada à satisfação do usuário e divulgou ao setor um documento técnico para a realização de pesquisa de satisfação de beneficiários de planos de saúde, contendo a metodologia a ser seguida, os critérios de elegibilidade para pontuação e exigências técnicas para o formato do relatório de pesquisa e para o parecer de auditoria a ser contratado pelas operadoras (ANS, 2020).

Em 2024, foram também recepcionadas pela ANS, 272 pesquisas de satisfação realizadas pelas operadoras, das quais 266 cumpriram os critérios preconizados pela ANS, representando 67,3% dos beneficiários do setor (ANS, 2025a). De fato, há registros a sugerir que os resultados ano a ano (2004-2014), tem apontado que os planos de saúde mais novos demonstram, à luz do índice da ANS, maior qualificação com relação aos anos anteriores (OLIVEIRA, KORNIS, 2017). Não obstante, na prática, um conjunto de evidências sugerem que o índice ainda falha ao tentar cumprir seus objetivos fundamentais, por razões que vão desde problemas de *design* até deficiências na implementação e da divulgação do indicador ao grande público.

O primeiro e mais fundamental problema do IDSS parece ser sua virtual invisibilidade para o consumidor final. A própria disposição e apresentação do índice no site oficial da ANS⁴⁹ sugere que a grande maioria dos beneficiários de planos de saúde sequer conhece a existência do índice⁵⁰. Diferentemente de outros setores regulados, onde indicadores de qualidade são amplamente divulgados e utilizados, o IDSS permanece confinado ao universo técnico-regulatório. Uma evidência de que o indicador somente é conhecido e discutido no âmbito das operadoras é que durante a Consulta Pública n. 46 da ANS, no ano de 2011, que discutiu os indicadores e os pesos das dimensões avaliativas do IDSS, das 459 contribuições recebidas pela ANS,

⁴⁹ De acordo com a RN ANS n. 505: “Art. 15. O IDSS será divulgado ao público, conforme definição da Diretoria Colegiada”.

⁵⁰ Ao tempo da pesquisa, em agosto de 2025, o alcance das informações referentes ao IDSS demanda ao usuário mais experimentado no site da ANS (ans.gov.br) primeiro o acesso ao menu “Espaço do consumidor”, onde então há 18 possíveis escolhas. Caso o usuário siga pela opção “Avaliação das Operadoras”, encontrará uma opção para conhecer o IDSS. A página referente ao IDSS, contudo, não apresenta as avaliações das operadoras, sendo o usuário remetido a um link chamado de “Resultados do IDSS”, onde, mais uma vez, o usuário não conseguirá saber o IDSS da sua operadora.

419 foram originadas por operadoras e apenas 8 contribuições vieram da sociedade civil e de entidades de defesa do consumidor (ANS, 2011a).

A acessibilidade das informações é igualmente problemática. Os dados estão disponíveis no site da ANS, mas de forma que requer conhecimento prévio sobre como navegar no sistema, quais operadoras procurar, e como interpretar os resultados. Não existe uma ferramenta intuitiva e amigável que permita comparações diretas entre operadoras, filtros por região ou tipo de plano, ou explicações claras sobre o significado prático das notas atribuídas. Mesmo quando os consumidores conseguem acessar as informações do IDSS, enfrentam o problema da ininteligibilidade. A nota final, expressa em uma escala decimal de 0 a 1, não possui significado intuitivo para o consumidor médio. O que significa, na prática, uma operadora ter IDSS 0,7 versus outra com 0,6? Qual a diferença real, em termos de qualidade de atendimento ou probabilidade de problemas, entre essas duas notas?

A metodologia de cálculo do IDSS, embora tecnicamente adequada sob perspectiva matemática, apresenta elevado grau de complexidade e opacidade para o consumidor leigo. As quatro dimensões são ponderadas e agregadas por intermédio de fórmulas matemáticas que impedem ao consumidor a compreensão acerca de quais aspectos específicos se mostraram determinantes para a composição da nota final, de modo que nuances substantivas — como uma operadora com excelente desempenho financeiro concomitantemente a atendimento deficiente ao cliente — dissolvem-se na nota agregada. Agrava-se a problemática pela ausência de contexto comparativo e *benchmarks* claramente definidos, deixando os consumidores sem referências para interpretar adequadamente se uma nota 0,6 é favorável ou desfavorável em termos relativos, como se distribui a pontuação no mercado, ou como sua operadora se posiciona frente às concorrentes. De fato, problema particularmente grave evidencia-se na desconexão entre o IDSS e a experiência prática vivenciada pelo beneficiário, dado que muitos indicadores utilizados no cálculo fundamentam-se em dados administrativos e regulatórios que não necessariamente espelham a qualidade efetiva da experiência do consumidor. A agência, por sua vez, confere peso reduzido aos resultados das pesquisas de satisfação, que atualmente proporcionam apenas um bônus de 0,25 pontos na Dimensão de Satisfação — correspondente a apenas trinta por cento da nota total da operadora (ANS, 2025b) — permitindo que uma operadora com excelentes indicadores financeiros, baixo volume de reclamações

formalizadas e ainda assim atendimento telefônico deficiente, autorização de procedimentos com demora excessiva ou rede credenciada inadequada, não manifeste essas deficiências substantivas claramente no índice, não obstante impacte diretamente a satisfação e a qualidade de vida dos beneficiários.

A limitação do IDSS como instrumento balizador de decisões é evidente também quando comparado com sistemas robustos de indicadores utilizados por prestadores de serviços em saúde. A Associação Nacional de Hospitais Privados documenta através do seu “Observatório Anahp 2025” que hospitais-membros da associação conseguem monitorar sistematicamente 265 indicadores e 337 variáveis abrangendo desempenho assistencial, gestão operacional, qualidade e segurança, gestão econômico-financeira, gestão de pessoas e sustentabilidade ambiental (ANAHP, 2025b). Em contraste, o IDSS da ANS concentra-se em indicadores limitados de reclamações e cobertura contratual, negligenciando métricas fundamentais como taxas de infecção hospitalar, mortalidade ajustada por risco, tempo médio de permanência, satisfação do paciente e eficiência operacional que efetivamente determinam qualidade da experiência assistencial dos beneficiários. A experiência da Anahp sugere a viabilidade técnica de coleta estruturada de todos esses dados, visto que em 2024, 119 dos 169 hospitais associados (70,41%) alimentaram mensalmente o sistema com informações padronizadas⁵¹.

A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) apresentou crítica nesse sentido ao tempo da Consulta Pública n. 46, destacando a relevância da pesquisa de satisfação de beneficiários ser devidamente integrada ao IDSS, visto que a pesquisa é um instrumento importante de aproximação da agência com os reais problemas vivenciados pelos consumidores. A proposta chegou a ser endossada por outros agentes do setor (algumas operadoras, que entendiam que o indicador não conseguir aferir a satisfação do consumidor. Não obstante, a proposta foi rejeitada pela agência na ocasião (ANS, 2011a).

⁵¹ A viabilidade de disseminação de instrumentos regulatórios baseados em transparência informacional encontra validação empírica recente. O Sistema de Indicadores Hospitalares Anahp, tradicionalmente restrito a hospitais privados associados, expandiu-se a partir de 2020 para instituições públicas e filantrópicas mediante parcerias com o Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais, e Confederação das Santas Casas de Misericórdia (ANAHP, 2025b). Em agosto de 2024, termo de cooperação com o Ministério da Saúde garantiu acesso gratuito à plataforma para hospitais públicos federais, e em abril de 2025, acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo incorporou 107 hospitais estaduais ao sistema.

Talvez o problema mais grave do IDSS seja sua falta de consequencialidade efetiva. Diferentemente de outros sistemas de classificação que geram impactos reais no mercado — como *ratings* de crédito que afetam o custo de financiamento das empresas, ou classificações de qualidade que influenciam decisões de compra — o IDSS não produz consequências significativas nem para as operadoras nem para os consumidores. Operadoras com notas persistentemente baixas no IDSS continuam operando normalmente, sem enfrentar sanções administrativas proporcionais ou crescentes. Não há um sistema claro de consequências escalonadas que incentive melhorias contínuas. Uma operadora pode ter IDSS baixo por anos consecutivos sem que isso resulte em restrições operacionais, limitações para comercialização de novos produtos, ou requisitos especiais de monitoramento. Esta ausência de consequencialidade parece minar completamente o pleno potencial do índice como instrumento ótimo de regulação. Se não há custos reais associados ao desempenho deficiente, as operadoras têm poucos incentivos para investir recursos significativos na melhoria dos aspectos avaliados pelo IDSS.

No ambiente atual, o IDSS também não gera pressão reputacional suficiente para modificar comportamentos. Como os consumidores não conhecem ou não compreendem o índice, operadoras com notas baixas não enfrentam perda de clientes ou danos à reputação que justifiquem investimentos em melhoria. Esta situação contrasta fortemente com outros mercados onde indicadores de qualidade têm impacto reputacional real. No setor automotivo, por exemplo, classificações de segurança⁵² influenciam diretamente as vendas. No setor financeiro, *ratings*⁵³ de crédito afetam a percepção do mercado e o custo de captação. No setor de saúde suplementar brasileiro, entretanto, o IDSS permanece como um exercício burocrático com pouco impacto prático.

⁵² Programas como o Latin NCAP (Latin New Car Assessment Programme) e o Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) avaliam e divulgam amplamente classificações de segurança veicular por meio de testes de colisão, atribuindo notas de zero a cinco estrelas. Estudos demonstram que essas classificações influenciam significativamente as decisões de compra dos consumidores e incentivam fabricantes a investirem em tecnologias de segurança. Ver: LATIN NCAP. About Latin NCAP. Disponível em: <https://www.latinncap.com>. Acesso em: 12 dez. 2025.

⁵³ Agências de classificação de risco como Standard & Poor's, Moody's e Fitch Ratings atribuem ratings de crédito a instituições financeiras e instrumentos de dívida, avaliando a capacidade de pagamento e o risco de inadimplência. Essas classificações afetam diretamente a percepção de investidores, o custo de captação de recursos no mercado e a reputação institucional.

5.2.3 *Nudges* para a democratização e a efetivação do IDSS

Para que o IDSS cumpra efetivamente seu papel de reduzir assimetrias informacionais e incentivar melhorias setoriais, e assim auxiliar o usuário na sua tomada de decisão, são necessárias algumas alterações estruturais. Nesse sentido, algumas estratégias da economia comportamental como o rearranjo do *design* do programa e o uso de *nudges* podem se mostrar como ferramentas úteis e com baixo custo regulatório⁵⁴.

Com efeito, se o objetivo é estimular comportamentos benéficos e assim possibilitar que o usuário contrate a melhor opção de plano de saúde – e mantenha-se bem informado ao longo do tempo – dada as suas condições pessoais, é preciso então ajudá-lo no sentido de que esta também seja a opção mais fácil. Nessa perspectiva, o *nudge* sugerido é o aprimoramento do IDSS para que a consulta simples e facilitada do indicador sirva de verdadeiro atalho cognitivo (heurística) para ajudar o consumidor a avaliar a qualidade sem que ele precise analisar dezenas de outras variáveis. O objetivo é claro: diminuir a carga mental necessária para entender o que se está contratando, aumentando a probabilidade de uma escolha mais informada.

Atualmente, o detalhamento dos resultados do IDSS de cada operadora, por dimensão, indicador e faixa avaliativa, está disponível para consulta no sítio da ANS na internet, especialmente na forma de um Relatório anual (geralmente divulgado em dezembro) e do *Painel Dinâmico*, que foi atualizado em 27/12/2024 e que apresenta os resultados dos últimos cinco anos, por indicador e por operadora. Aos que dominam a linguagem regulatória mais técnica, é possível conferir também os resultados do IDSS Geral do setor, desagregado por segmento, modalidade e porte. Os resultados são exibidos em gráficos dinâmicos e tabelas, e estão disponíveis para consulta, por meio de um painel de *Business Intelligence* (BI). Com efeito, a apresentação, a leitura e o entendimento dos documentos são para poucos.

⁵⁴ Outro caminho para a agência poderá ser no sentido de redesenhar a experiência do usuário para remover o *sludge*, entendido como qualquer burocracia excessiva, papelada complicada ou processo administrativo que dificulte ou impeça as pessoas de acessarem um direito, um serviço ou uma oportunidade. (SUNSTEIN, THALER, 2023).

Nesse ponto, a ANS já apresenta iniciativas com vistas à simplificação da informação, com tabelas comparativas, infográficos e linguagem acessível, de modo a ajudar os consumidores a entenderem melhor as opções. Um exemplo de promoção de transparência e simplificação pela agência está na criação da aba “Espaço do Consumidor”, logo na página inicial do sítio eletrônico da agência⁵⁵. Ao clicar na referida aba, o usuário é levado a um submenu onde constam opções como o “Caminho do Consumidor”, “Cartilha para o consumidor”, “Qualidade de hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais da saúde” e “Avaliação das operadoras”. Ocorre que o processo seguido pelo usuário não costuma seguir de forma simplificada e direta, a exemplo do “Caminho do consumidor”, onde o próximo submenu apresenta notável dispersão, com novos encaminhamentos de *links* desacompanhados de uma explicação ou de um roteiro lógico, à luz dos objetivos e dos melhores interesses do usuário. No mesmo sentido, ao clicar na aba “Avaliação das operadoras”, o usuário é levado a um novo submenu, onde inexistem quaisquer instruções ou comentários da agência, cabendo apenas ao usuário mais esclarecido continuar sua busca de forma bem situada⁵⁶.

A democratização do acesso ao IDSS pode se beneficiar da criação de plataformas digitais intuitivas e amigáveis, comparáveis às ferramentas de comparação já estabelecidas em outros setores. Imagine uma plataforma similar ao *Google Flights* ou ao *Booking.com*, onde consumidores possam inserir seus critérios específicos (região, faixa etária, necessidades médicas, orçamento) e receber comparações claras entre operadoras, incluindo as notas do IDSS traduzidas em linguagem acessível. Esta plataforma deveria incluir funcionalidades de filtragem avançada, permitindo aos usuários priorizarem as dimensões mais relevantes para seu perfil específico. Um jovem saudável pode dar mais peso à sustentabilidade financeira e ao preço, enquanto uma família com histórico de doenças crônicas pode priorizar a qualidade da atenção à saúde e a satisfação dos beneficiários.

⁵⁵ A ANS disponibiliza no portal oficial o “Espaço do Consumidor”, seção dedicada à orientação de beneficiários sobre direitos, coberturas e comparação de planos. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor>. Acesso em: 12 dez. 2025.

⁵⁶ Ao clicar no submenu “Avaliação das Operadoras”, o único conteúdo disponível restringe-se a outro *submenu*, sem qualquer descrição ou direcionamento pela agência, onde o usuário deve optar pelos seguintes conteúdos: “Programa de Avaliação das Operadoras - IDSS”, “Acreditação das Operadoras”, “Índice de Reclamações” e “Monitoramento da Garantia de Atendimento”. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor/avaliacao-das-operadoras>. Acesso em: 15 set. 2025.

Nesse sentido, a plataforma Healthcare.gov⁵⁷, criada pelo governo federal dos Estados Unidos após o Affordable Care Act (Obamacare), permite que consumidores comparem planos de seguro de saúde inserindo código postal, renda estimada, idade e tamanho da família. A ferramenta oferece estimativas personalizadas de prêmios, subsídios governamentais e permite filtrar planos por nível de cobertura (Bronze, Silver, Gold, Platinum), rede de provedores e necessidades específicas. O governo australiano mantém uma plataforma oficial de comparação de seguros de saúde privados⁵⁸ que permite aos consumidores comparar mais de 40.000 políticas de diferentes seguradoras. Os usuários podem filtrar por tipo de cobertura (hospital, extras, ambulatorial), localização, idade e situação familiar. As chamadas *exchanges* para a escolha de seguros de saúde nos Estados Unidos, criadas pelo governo federal no âmbito do programa *Medicare* e do mercado de planos de medicamentos criados pelo *Medicare Part D*, criado em 2003, incentivam as seguradoras privadas a entrarem nas plataformas estaduais e competir pelos clientes (SINAIKO; HIRTH, 2009). Nesses ambientes de competição administrada, os consumidores normalmente têm muitas opções, em alguns casos até 40 ou 50, e no entanto, contam com processos de simplificação que acompanham as preferências manifestadas pelos usuários durante os vários ciclos de contratação (CHANDRA; HANDEL; SCHWARTZSTEIN, 2019).

A integração com outros dados relevantes do IDSS também é fundamental. Nesse sentido, a plataforma deveria combinar informações do IDSS com dados sobre rede credenciada por região, histórico de reajustes, tempo médio de autorização de procedimentos, e outros indicadores práticos que impactam diretamente a experiência do usuário. A construção comparativa, a partir de determinados critérios eleitos pelo usuário ao tempo da consulta, parece viável e até de simples implementação, na medida que o IDSS nada mais é que o conjunto de outros tantos indicadores, capazes de abordar individualmente cada um dos critérios realmente levados em consideração pelo usuário ao avaliar uma operadora e seus produtos.

A simplificação da comunicação é essencial para tornar o IDSS útil. As notas decimais atuais poderiam ser complementadas ou substituídas por classificações intuitivas — sistemas de estrelas (como os utilizados em aplicativos de transporte),

⁵⁷ Department of Health and Human Services. Health Insurance Marketplace. Disponível em: <https://www.healthcare.gov>. Acesso em: 12 dez. 2025.

⁵⁸ Department of Health and Aged Care. Private Health Insurance Ombudsman - Compare Policies. Disponível em: <https://www.privatehealth.gov.au>. Acesso em: 12 dez. 2025.

cores (verde/amarelo/vermelho), ou categorias descritivas (excelente/bom/regular/inadequado). Essa classificação indicativa serviria como contraponto ao problema identificado acima, referente ao excesso de linguagem *marketizada* na oferta dos produtos pelas operadoras de planos de saúde, na medida em que uma abordagem terminológica ruim compõe um problema complexo (THALER; SUNSTEIN, 2023). Outra sugestão seria a padronização de planos em categorias claras e comparáveis, como "bronze", "prata" e "ouro", com base no grau de cobertura, facilitaria a comparação entre produtos.

Cada categoria poderia vir acompanhada de explicações práticas sobre o que significa, na experiência real do beneficiário, contratar uma operadora com aquele nível de desempenho. Por exemplo: "Operadoras na categoria 'Excelente' têm histórico de autorizar 95% dos procedimentos solicitados em até 48 horas, recebem menos de 2 reclamações por 1000 beneficiários, e praticam reajustes consistentemente abaixo da média do setor". A comunicação deveria incluir alertas específicos para problemas recorrentes. Se uma operadora tem histórico de negativas excessivas de cobertura, demora na autorização de procedimentos, ou reajustes acima da média, essas informações deveriam ser destacadas de forma clara e objetiva.

Por fim, a plataforma poderia efetivamente sugerir planos baseadas no perfil do consumidor, utilizando algoritmos para reduzir a carga decisória, e ferramentas interativas, como simuladores que mostram em tempo real os impactos de diferentes escolhas no custo e na cobertura. De fato, trata-se do *framing* positivo, que destaca os benefícios de escolher o plano adequado, como economia a longo prazo ou segurança em situações de emergência, motivando-se decisões acertadas. A integração de incentivos e nudges pode potencializar resultados caso a plataforma digital ofereça sugestões personalizadas e comparações simplificadas (nudges), aliada a recompensas para os usuários que a utilizam (incentivos), tornaria o processo de escolha mais eficiente e satisfatório.

É preciso ainda lidar com a falta de consequencialidade, produzindo-se incentivos reais para a melhoria. Para que o IDSS gere mudanças comportamentais efetivas, é necessário estabelecer consequências progressivas para operadoras com desempenho deficiente. Operadoras com notas consistentemente baixas deveriam enfrentar sanções escalonadas: desde requisitos de planos de melhoria com metas

específicas e prazos definidos, até restrições para comercialização de novos produtos ou aumento de margem de solvência exigida. O sistema deveria incluir também incentivos positivos para operadoras com desempenho superior. Aquelas com IDSS consistentemente alto poderiam receber benefícios como redução na frequência de fiscalizações, fast-track para aprovação de novos produtos, ou reconhecimento público por meio de selos de qualidade que poderiam ser utilizados em materiais de marketing.

A transparência ativa também é fundamental. A ANS deveria promover campanhas educativas regulares para divulgar o IDSS, explicar sua importância, e orientar consumidores sobre como utilizá-lo em suas decisões. Esta divulgação deveria incluir parcerias com órgãos de defesa do consumidor, associações médicas, e mídias especializadas. O IDSS possui potencial para ser muito mais que um indicador burocrático — pode tornar-se um verdadeiro instrumento de transformação do mercado de saúde suplementar brasileiro. Para isso, precisa evoluir de sua atual condição de "segredo bem guardado" para uma ferramenta amplamente conhecida, compreendida e utilizada por consumidores, operadoras e reguladores.

A integração com ecossistemas digitais existentes seria um primeiro passo importante. Plataformas de comparação de preços, sites de reclamações de consumidores, aplicativos de saúde, e sistemas de recursos humanos de empresas poderiam incorporar informações do IDSS, criando múltiplos pontos de contato entre o índice e os consumidores finais. A padronização de comunicação entre diferentes *stakeholders* também é crucial. Corretores de seguros, departamentos de RH, consultores em benefícios, e profissionais de saúde deveriam receber treinamento sobre como interpretar e comunicar o IDSS, multiplicando o alcance e a utilidade da informação. Deve-se ainda reduzir etapas desnecessárias e simplificar fluxos para facilitar o acesso e a conclusão das ações pelos usuários. Utilizar ferramentas digitais para automatizar tarefas administrativas e operacionais, liberando tempo para cuidados diretos. Deve-se resistir à tentação de adicionar imediatamente um novo componente, como comunicações adicionais ou mais pessoal. Com efeito, papelada redundante e confusa e outros processos que podem ser assustadores e desgastantes.

Já a viabilidade econômica das proposições acima fundamenta-se em evidências internacionais sobre custos de implementação de *nudges* informacionais.

Com efeito, Thaler e Sunstein (2023) argumentam que intervenções digitais de simplificação informacional constituem investimentos de baixíssima magnitude quando comparados a alternativas regulatórias tradicionais, visto que aproveitam infraestrutura tecnológica preexistente mediante ajustes incrementais em interfaces e fluxos de dados. A OCDE (2017) documenta casos exemplares onde redesenho de portais governamentais para incorporar comparadores interativos e sistemas de recomendação personalizados custou entre €50.000 e €200.000 por jurisdição, produzindo elevações de 15% a 30% nas taxas de conclusão de processos pelos cidadãos. Halpern e Sanders (2016) demonstram que o custo marginal de cada usuário adicional alcançado por plataforma digital de comparação aproxima-se de zero após desenvolvimento inicial, gerando escalabilidade exponencial inexistente em mecanismos presenciais ou impressos.

Finalmente, a evolução metodológica contínua do índice deveria incorporar feedback dos usuários e evidências sobre quais aspectos do desempenho das operadoras mais impactam a satisfação e os resultados de saúde dos beneficiários. É importante ir informando ao longo do caminho, *feedbacks* inclusive (SUNSTEIN, 2018). O IDSS não deveria ser um instrumento estático, mas sim uma ferramenta em constante aperfeiçoamento, adaptando-se às mudanças no setor e às necessidades dos consumidores.

O IDSS representa uma tentativa louvável de enfrentar os desafios associados à falha correspondente à ausência de informação completa pelos agentes, fornecendo informação objetiva e comparável sobre o desempenho das operadoras. Entretanto, sua implementação atual ainda é deficiente no atingimento dos objetivos fundamentais de redução da assimetria informacional e no incentivo à melhoria setorial. Para cumprir seu potencial transformador, o IDSS necessita ser radicalmente democratizado, simplificado e tornado consequente. Precisa sair dos gabinetes e laboratórios regulatórios e chegar às mãos dos consumidores de forma compreensível e útil. Precisa gerar incentivos reais para que operadoras invistam em melhoria contínua e assim seguir, evoluindo constantemente, adaptando-se às mudanças do setor e às necessidades dos beneficiários.

Somente por meio de reformulações substantivas o IDSS poderá cumprir sua promessa original de transformar um mercado caracterizado por opacidade informacional e assimetria estrutural em um ambiente onde consumidores possam

efetivamente exercer escolhas verdadeiramente informadas, e onde operadoras sejam incentivadas à competição fundamentada na qualidade dos serviços oferecidos, dissociando-se de estratégias meramente mercadológicas ou de engenharia financeira. O IDSS configura-se como um potencial instrumento de intervenção comportamental capaz de induzir transformações no mercado. Não obstante, o desafio apresenta-se como substancial, o potencial de impacto positivo justifica plenamente os investimentos regulatórios e estruturais necessários. Considerando que o setor de saúde suplementar afeta diretamente a saúde e o bem-estar de mais de cinquenta milhões de brasileiros (ANS, 2025a), não se mostra defensável a manutenção de instrumentos regulatórios que subsistam meramente na formalidade normativa, sem que cumpram sua função social fundamental de proteção ao consumidor e provisão de informação qualificada para tomada de decisão.

5.3 Induza cuidado hoje (priorizamos o hoje e não damos valor ao amanhã)

5.3.1 As falhas comportamentais que impedem o cuidado adequado

A saúde suplementar no Brasil enfrenta um desafio significativo relacionado à falta de cuidado e prevenção por parte dos beneficiários dos planos de saúde⁵⁹. Segundo dados reportados pelas operadoras em suas demonstrações contábeis, os gastos relacionados a programas de prevenção não alcançam nem 0,5% das receitas do mercado (Anahp, 2025a), o que evidencia que o tema não vem sendo tratado como prioridade pelo setor. Por outro lado, de acordo com a teoria econômica clássica, é correto afirmar que o ser humano sempre desejará cuidar da própria saúde, como forma de agir orientada à maximização de seus interesses (utilidade), compreendidos aqui na forma da saúde enquanto um bem de consumo, que gera um bem-estar associados à produtividade, longevidade e capacidade de aproveitar a vida.

⁵⁹ Para um histórico completo sobre a evolução da preocupação global com a saúde, conferir Silveira (2004).

Assim, a decisão de contratar um plano de saúde de qualidade e agir conforme as diretrizes médicas, realizando check-ups e aderindo a tratamentos oportunos refletem a alocação racional de recursos escassos ao longo do tempo, condicionada apenas por preferências, custos de oportunidade e restrições orçamentárias.

A realidade, contudo, indica que o comportamento humano sofre a influência de forças conhecidas como vieses comportamentais, os quais impedem ou dificultam a tomada de decisão mais bem orientada. Na saúde suplementar, a não adesão a cuidados preventivos e o engajamento tardio em tratamentos costumam ocorrer por vieses como a inércia, o presenteísmo e o superotimismo. Esses fatores são documentados em estudos e revisões que mostram, por exemplo, como lembretes que aumentam saliência e reduzem fricções elevam vacinação, enquanto complexidade e defaults desfavoráveis reforçam a inércia e o adiamento de consultas e exames (DAI et al., 2021). A inércia e o viés do *status quo* são responsáveis pela manutenção de comportamentos inadequados, mesmo quando alternativas superiores estão disponíveis. Esta tendência manifesta-se na resistência à mudança de hábitos nocivos, na permanência em planos de saúde subótimos ou na continuidade de esquemas terapêuticos ineficazes simplesmente por representarem o estado atual das coisas (SAMUELSON; ZECKHAUSER, 1988). A inércia comportamental é particularmente problemática porque opera de forma inconsciente, criando uma preferência implícita pela manutenção do comportamento vigente independentemente de sua adequação.

O presenteísmo, ou o imediatismo (*present bias*), constitui também uma das principais barreiras, caracterizando-se pela tendência de supervalorizar custos imediatos (tempo, desconforto, pagamentos) em detrimento de benefícios futuros, como melhoria da saúde e longevidade (O'DONOGHUE; RABIN, 1999; WANG, 2018 *apud* WANG; SLOAN, 2018). Esta distorção temporal leva à procrastinação sistemática de exames preventivos, vacinas e início de tratamentos, onde indivíduos continuamente postergam decisões sob a crença equivocada de que "amanhã" será mais conveniente para iniciar o cuidado. O imediatismo é uma tendência natural que leva à valorização de recompensas de curto prazo em detrimento de benefícios futuros, dificulta a adesão a hábitos preventivos, como a prática regular de exercícios ou a realização de exames de rotina, pois esses exigem esforço imediato para resultados que só se manifestam com o tempo.

Outrossim, a aparente desconexão emocional com o "futuro eu" faz com que os indivíduos subestimem as consequências de suas escolhas presentes, como a negligência de tratamentos médicos, aumentando o risco de problemas de saúde futuros.

Já o otimismo irrealista (*optimism bias*) leva indivíduos a subestimarem sistematicamente sua própria probabilidade de desenvolver problemas de saúde, resultando em menor investimento em prevenção e menor adesão a regimes terapêuticos contínuos (NASEM, 2023). Esta superconfiança é frequentemente acompanhada pela ilusão de controle, onde pessoas acreditam poder "controlar" sua saúde por meio de força de vontade, minimizando a necessidade de intervenções médicas estruturadas. Esse otimismo excessivo leva muitos a acreditarem que são invulneráveis a problemas graves, ignorando medidas preventivas sob a justificativa de que "nada de ruim vai acontecer comigo" ou que "isso só acontece com os outros". Esse viés leva as pessoas a subestimarem seus próprios riscos, resultando em baixa adesão a exames preventivos e estilos de vida saudáveis.

Outra face desse problema exsurge da relação do usuário com a quantia a ser paga pelo plano de saúde, notadamente nos planos com coparticipação. No contexto da saúde suplementar, a mensalidade é um custo presente e tangível, enquanto a coparticipação é um custo futuro, abstrato e incerto. Assim, o viés do presente demonstra que o beneficiário é psicologicamente recompensado no presente por pagar uma mensalidade mais baixa, enquanto a dor de um gasto futuro com a coparticipação é desconsiderada ou minimizada. Essa procrastinação em lidar com a complexidade e a incerteza do custo futuro se manifesta na dificuldade que os indivíduos têm em escolher planos de forma ótima. A tarefa de entender os custos futuros é adiada indefinidamente, com a mentalidade de "eu lido com isso amanhã". Este viés, portanto, demonstra que o problema do desconhecimento de custos não é apenas uma questão de não ter a informação, mas de a informação, mesmo que presente no contrato, não ser percebida como relevante ou urgente o suficiente para ser processada. O foco na recompensa financeira imediata (mensalidade menor) leva o beneficiário a ignorar ou subestimar os custos futuros de utilização. O *design* do sistema, ao tornar o custo de uso abstrato, acaba por induzir um comportamento subótimo.

A aversão à perda, como visto, descreve a tendência de os indivíduos atribuírem uma importância significativamente maior às perdas do que aos ganhos de mesma magnitude. No contexto da saúde, a dor financeira de uma coparticipação inesperada é sentida de forma muito mais intensa do que a satisfação de uma mensalidade mensalmente mais baixa. A economia na mensalidade, que foi um "ganho", é rapidamente internalizada e se torna o status quo. A cobrança da coparticipação, no entanto, é enquadrada mentalmente como uma "perda" financeira, gerando um forte sentimento de injustiça, mesmo que o pagamento seja contratualmente devido e a economia cumulativa supere os custos de uso. A interação desses vieses cria um ciclo vicioso: o viés do presente leva à escolha de um plano de coparticipação com base na mensalidade baixa. A utilização do plano e a consequente cobrança inesperada ativam o mecanismo de aversão à perda, gerando insatisfação, percepção de falta de transparência e prejudicam essencialmente o cuidado preventivo.

Essas características combinadas resultam em consequências negativas para a saúde suplementar com o inevitável aumento nos custos de saúde, pois tratamentos para doenças avançadas são mais caros do que medidas preventivas⁶⁰. A prática resulta ainda na sobrecarga do sistema, com maior demanda por cuidados intensivos que pressiona prestadores de serviço. A maior consequência é a piora nos desfechos clínicos, devido à falta de adesão a check-ups e tratamentos preventivos. As evidências sugerem que as pessoas não se engajam em comportamentos preventivos de saúde, mesmo quando os benefícios a longo prazo são evidentes (MÖLLENKAMP; ZEPPERLICK; SCHREYÖGG, 2019).

A hipertensão, por exemplo, se não for adequadamente tratada, pode contribuir para o desenvolvimento de problemas cardiovasculares sérios, como doenças renais, acidentes vasculares cerebrais infarto do miocárdio. Já com a adoção de comportamentos saudáveis como dietas adequadas e exercícios físicos podem

⁶⁰ Martins et al. (2013) documenta em pesquisa algumas das estratégias das operadoras com vistas à redução de custos, destacando ações de negociações com fornecedores de medicamentos e materiais utilizados nos usuários pacientes, utilização de medicamentos genéricos, contratos com rede específica, consultas de 15 minutos de duração, uso de biometria, auditoria médica na liberação de exames a pacientes internados e nas contas hospitalares, ações educativas, tais como a medicina preventiva primária, o gerenciamento de pacientes crônicos dentre os quais consta a medicina preventiva secundária, o Home Care e a assistência domiciliar, a medicina preventiva terciária, além da introdução à coparticipação nos produtos oferecidos.

resultar na ausência de hipertensão (OCDE, 2021). E no Brasil, a prevalência média de pressão arterial elevada tem se mantido superior a 20%, acima da média dos países que compõem a OCDE (OCDE, 2021).

No caso da diabetes, Frederico Guanais *et al.* (2019) apontam que 21% de todos os brasileiros com diagnóstico de diabetes sequer recebem atendimento médico anual e que apenas 22% dos usuários do SUS indicaram ter recebido algumas recomendações sobre estilos de vida saudáveis de seu médico de família, sendo que menos de 40% dos usuários públicos fizeram consulta preventiva nos últimos dois anos. Justamente em um contexto em que as intervenções comportamentais adequadas são constantemente sugeridas para os itinerários clínicos, com forte indicação para o acompanhamento e monitoramento dos pacientes.

A ausência de acompanhamento adequado por parte das autoridades em saúde parece potencializar os efeitos da falha comportamental humana que se refere ao nosso superotimismo, que nos faz imaginar que nunca vamos ficar doentes. Uma explicação vem da literatura sobre organização industrial aplicada à saúde suplementar, que identifica que o descolamento entre tomador de decisão e responsável pelo pagamento resulta em incentivos perversos na cadeia, especialmente quanto à sobreutilização de serviços curativos em detrimento de investimentos preventivos (TAKAHASHI, 2022). Essa dinâmica agrava-se quando considerada sob perspectiva comportamental: beneficiários manifestam viés do presente ao subvalorizar sistematicamente benefícios futuros e probabilísticos da prevenção frente a custos imediatos e certos de tempo e esforço, enquanto operadoras enfrentam horizontes temporais encurtados pela rotatividade de beneficiários que desincentivam investimentos cujos retornos somente se manifestarão após anos. Takahashi demonstra empiricamente que novos modelos de negócios, especialmente healthtechs focadas em atenção primária e verticalizadas com controle sobre protocolos, buscam endereçar essa falha por meio de mecanismos que realinham incentivos, mas a efetividade dessas intervenções depende fundamentalmente de superar barreiras comportamentais mediante nudges que tornem o cuidado preventivo a opção padrão facilitada, não apenas economicamente incentivada.

5.3.2 O Promoprev e os programas de linha de cuidado: A saúde vista a partir do cuidado

A ANS desempenha um papel fundamental ao promover medidas que incentivem a prevenção e o cuidado proativo. A partir da Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001, ficou evidente que a saúde suplementar no país deve-se voltar ao cuidado geral da saúde dos beneficiários, na medida em que o art. 35-F da Lei n. 9.656/98 passou a prescrever que a assistência privada em saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.

No âmbito da agência, a primeira medida regulatória mais concreta nesse sentido parece ter ocorrido no ano de 2003, em decorrência da criação do Fórum de Saúde Suplementar, proposto pelo Ministério da Saúde⁶¹. De acordo com Gregori (2019), a iniciativa contou com todos os setores envolvidos, em conjunto com o Conselho Nacional de Saúde (CNS), com o objetivo de avaliar o marco jurídico vigente. As discussões foram então segmentadas em tópicos e foram produzidas diretrizes, sendo que a Diretriz 4 indicou que o modelo de atenção à saúde suplementar deve adotar medidas de promoção à saúde e prevenção e controle de doenças (GREGORI, 2019, p.49). A diretriz da gestão e integralidade do cuidado passou a ser incorporada na ação regulatória pela agência, constando inclusive no rol de diretrizes estratégicas para a Gestão da ANS anunciada no Relatório de Gestão da agência referente ao ano de 2005, quando a qualificação da Saúde Suplementar passou a prever a ação “Promoção da saúde e prevenção das doenças” (ANS, 2006).

Àquela época, os programas de promoção à saúde e prevenção de doenças também foram objeto de previsão na Resolução Normativa ANS n. 94, de março de 2005, que estabelecia um tratamento privilegiado em relação a certas exigências setoriais relacionadas a ativos garantidores e provisão de risco, restrito às operadoras

⁶¹ De modo isolado, foi possível encontrar uma citação anterior a programas de promoção da saúde e prevenção de doenças no texto da Resolução CONSU n.º 05, de 04/11/98. Na referida norma, que trata especificamente das autogestões, menciona-se no art. 5º que os programas das operadoras com estas finalidades devem ser protocolados no Ministério da Saúde. A presente pesquisa, no entanto, não encontrou qualquer vínculo a programa ou ação permanente da saúde suplementar, sugerindo que o tema era preocupação apenas da pasta ministerial, no bojo da política da atenção primária à saúde.

que adotassem programas de promoção à saúde e prevenção de doenças de seus beneficiários (art. 2º). Ainda segundo a RN ANS n. 94, o formato e os critérios de avaliação dos programas de promoção à saúde e prevenção de doença desenvolvidos pelas operadoras seriam definidos em instrução normativa da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – Dipro (art. 5º, §1º).

O cenário é alterado substancialmente a partir de abril de 2011, com a conclusão dos estudos regulatórios que levaram à realização do processo da Consulta Pública n. 42. De acordo com a Exposição de Motivos contida na Nota do Grupo Técnico Envelhecimento Ativo n. 1 (ANS, 2011c), a proposta da agência era a criação de incentivos para programas de promoção do envelhecimento ativo e promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças no âmbito da saúde suplementar. A agência destacou naquele momento a necessidade de se incentivar comportamentos que elevassem a capacidade funcional dos usuários, entendida como a capacidade demandada pelos indivíduos para a realização das atividades mais básicas do cotidiano, tais como: alimentar-se sozinho, caminhar, vestir-se, entre outras (ANS, 2011c). Também foi trazido ao seio da regulação da saúde suplementar o programa visa a promoção do envelhecimento saudável, por meio do desenvolvimento de ações que orientem os idosos e a população em geral para a importância da melhoria constante de suas habilidades funcionais, mediante a adoção precoce de hábitos saudáveis de vida e a eliminação de comportamentos nocivos à saúde.

A justificativa técnica trouxe, ao mesmo tempo, as preocupações e desafios comportamentais a serem enfrentados, *verbis*:

Considerando este cenário e em consonância com as políticas públicas que vem sendo implementadas no país pelo Ministério da Saúde - que focalizam ações de promoção e prevenção voltadas para o envelhecimento ativo da população – fez-se necessário introduzir o tema na agenda das políticas regulatórias da ANS. A preocupação do ente regulador é incentivar, como preconizado pela Política Nacional de Saúde do Idoso, **a criação de ambientes físicos, sociais e comportamentais com vistas à promoção de melhorias na condição de saúde dos indivíduos, especialmente os idosos, bem como ampliar a participação social dos mesmos.** Essa, porém, não é uma questão fácil, pois envolve mudanças culturais e comportamentais dos vários segmentos sociais que atuam na saúde suplementar – beneficiários, operadoras e prestadores. A dificuldade de adesão desses vários segmentos pode ser ilustrada, por exemplo, pela

potencial baixa adesão dos beneficiários na ausência de medidas de incentivo – quer financeiros ou não.

(grifou-se)

(ANS, 2011c, p. 8)

Segundo a ANS, o debate público do tema ocorreu ainda no ano de 2010, com a participação da sociedade por meio do seminário "Desafios Assistenciais e Econômico-Financeiros do Envelhecimento Populacional na Saúde Suplementar", realizado no dia 17 de novembro de 2010, na cidade do Rio de Janeiro. Após o evento, comissões técnicas debateram as primeiras propostas e dentre as principais questões surgidas, houve o destaque à ideia de se mudar a orientação do sistema, que era pautado pelo ciclo de tratamento da doença e não da saúde, e com isso alterar a regulação para a criação de benefícios indutores (inclusive pecuniários) para o cuidado com a saúde. Daí então ganhou destaque a proposta que possibilitava a adoção de incentivos não apenas pecuniários, por meio da bonificação para a participação em programas de envelhecimento ativo, mais também, por exemplo, por meio de premiações para participação em programas específicos de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças para determinados grupos de beneficiários (ANS, 2011c).

A ANS seguiu então com a Consulta Pública n. 42, aberta em 16 de maio de 2011, com prazo de 30 dias para recebimento de contribuições da sociedade. Durante as primeiras sete horas de disponibilização, a consulta recebeu aproximadamente três mil contribuições, volume quase 1.000% superior à média das consultas públicas anteriores no mesmo período, evidenciando forte interesse social no tema⁶².

O processo de participação social culminou na publicação, em agosto de 2011, da Resolução Normativa ANS n. 264 tratou sobre os programas de saúde suplementar voltados à promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças (Promoprev), agora com a estatura normativa de uma resolução. O objetivo da norma, segundo o art. 2º, II, foi estabelecer incentivos para as operadoras e para os beneficiários com vistas à adesão a um conjunto de estratégias e ações programáticas integradas para a promoção da saúde e a prevenção de riscos, agravos e doenças. O programa mira

⁶² Conforme *release* da ANS disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sociedade/contribuicoes-a-consulta-publica-sobre-envelhecimento-ativo-alcancam-recorde>. Acesso em: 5 set. 2025.

ainda na compressão da morbidade, na redução de anos perdidos por incapacidade e no aumento da qualidade de vida dos indivíduos e populações. Para tanto, a agência desenhou subprogramas com focos em segmentos específicos da população, com destaque para pessoas idosas, portadores de fatores de risco e pacientes crônicos.

A indução setorial previu para as operadoras de planos de saúde que aderissem ao programa o incentivo do aproveitamento das despesas com esses programas como fator redutor da exigência mensal de margem de solvência, recebimento de pontuação Bônus no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar da Operadora – IDSS, além de outros a serem regulamentados pela ANS (art. 5º, I, II e III)⁶³. Já aos beneficiários que aderirem aos programas para promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, a Resolução Normativa previu que as operadoras poderiam oferecer como incentivos a concessão de bonificação e de premiações, além de outros a serem regulamentadas pela ANS (art. 4º, I, II e III).

A concessão de bonificação aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde pela participação em programas para promoção do envelhecimento ativo ao longo do curso da vida e de premiação pela participação em programas para população-alvo específica e programas para gerenciamento de crônicos foi tema da Resolução Normativa n. 265, também editada em agosto de 2011. A bonificação, segundo o art. 2º, I, da RN ANS 265, consistia em vantagem pecuniária representada pela aplicação de desconto no pagamento da contraprestação pecuniária, concedida pela operadora ao beneficiário de plano privado de assistência à saúde como incentivo à sua participação em programas de cuidado. Já a premiação consistia em vantagem representada pela oferta de prêmio, concedida pela operadora ao beneficiário de plano privado de assistência à saúde como incentivo à sua participação em programa para população-alvo específica e programa para gerenciamento de crônicos (art. 2º, II). As Resoluções Normativas n. 264 e n. 265 foram formalmente revogadas pelas RN ANS n. 498 e 499, de 2022, tratando-se, contudo, de mera atualização do estoque

⁶³ A análise da RN 498 apresentada no Apêndice C destaca que esses incentivos institucionais, embora financeiros, dependem de feedback reputacional para serem efetivos. O bônus no IDSS, por exemplo, só funciona como nudge para a operadora se o mercado consumidor reagir a essa pontuação, o que nos remete novamente aos problemas de visibilidade do índice discutidos anteriormente.

regulatório da agência⁶⁴. Não obstante a continuidade normativa e regulatória do programa, a implementação efetiva do Promoprev no setor ainda enfrenta desafios.

Para fins desta investigação, procedeu-se à dissecação dos dispositivos destas normas vigentes. O Apêndice C apresenta a análise da RN n. 498/2022, focada na estruturação dos programas de promoção da saúde, evidenciando oportunidades para aplicação de *framing* positivo e segmentação de público. Já o Apêndice D dedica-se ao exame da RN n. 499/2022, explorando especificamente a mecânica de bonificações e premiações sob a perspectiva dos incentivos e *nudges*, como a simplificação de regras e o uso de padrões (*defaults*) de renovação.

A despeito do número total de usuários da saúde suplementar já superar a marca de 52 milhões de brasileiros, nem 2 milhões de brasileiros estão inseridos em algum dos 415 programas do Promoprev vigentes em dezembro de 2024 (ANS, 2025a). No âmbito da agência, o número de servidores destacados ao acompanhamento das propostas oferecidas pelas operadoras interessadas em aderir ao programa é baixo, notadamente diante da complexidade envolvida pelos inúmeros fatores a serem verificados, tanto no processo de adesão quanto no processo de aferição dos desfechos. A inconsistência na forma como a agência historicamente trata o tema também é um fator. Mesmo tendo sido iniciado formalmente no ano de 2014, a ausência de protagonismo na agenda regulatória para programas vinculados ao cuidado e prevenção tem deixado as iniciativas e esforços de implementação em um segundo plano. Durante muitos anos o programa sequer teve impulsionamento oficial, e durante os anos em que a população se recuperava dos efeitos da pandemia de Covid-19 não se viu qualquer esforço oficial no sentido de incentivar o setor a aderir ao Promoprev. O baixo interesse manifestado pelas operadoras também é sintomático. Com efeito, os incentivos oferecidos não parecem cativar as empresas que, em sua maioria, buscam retornos financeiros de curto prazo.

Para piorar, o benefício que permitia às operadoras, desde a edição da RN ANS 264 em 2011, contabilizar as despesas com Promoprev como forma de reduzir as exigências vinculadas à margem de solvência, restou suprimido com a edição da

⁶⁴ A Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, também conhecida como Lei das Agências, ao dispor sobre a gestão, a organização e o controle social das agências reguladoras federais, estabeleceu a necessidade de que estas mantivessem um registro organizado e atualizado de seus atos normativos, promovendo a transparência e o acesso à informação.

Resolução Normativa ANS nº 569, de dezembro de 2022. Esta resolução simplesmente aboliu o modelo de margem de solvência para a determinação do capital regulatório, passando a adotar o chamado capital baseado em risco (CBR), que agora considera os riscos de subscrição, crédito, operacional e de mercado.

Já o incentivo às empresas na forma de bônus no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar da Operadora (IDSS) parece ainda pouco explorado pelo setor. Como visto, o IDSS foi criado pela ANS como instrumento de avaliação da qualidade das operadoras de planos privados de assistência à saúde no Brasil. Sua finalidade primordial é fornecer parâmetros objetivos que permitam a comparação do desempenho das operadoras, estimulando a melhoria contínua dos serviços oferecidos e promovendo maior transparência no setor (ANS, 2024). O IDSS integra o Programa de Qualificação das Operadoras (PQSS-ANS), estabelecendo critérios que avaliam aspectos como atenção à saúde, garantia de acesso, sustentabilidade no mercado e gestão de processos e regulação. O índice utiliza indicadores quantitativos e qualitativos, atualizados periodicamente, que refletem tanto a capacidade das operadoras de garantir cobertura assistencial quanto a eficiência administrativa e financeira (ANS, 2024).

Entre as características mais atuais do IDSS, destaca-se a ênfase em ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, conforme disposto na Resolução Normativa nº 498/2022. Operadoras que desenvolvem programas aprovados pela ANS nessa área recebem bonificação no IDSS, o que reforça o papel do índice como indutor de boas práticas assistenciais (ANS, 2024). Além disso, a metodologia do índice passou a incorporar indicadores relacionados à experiência do usuário, à resolutividade das demandas e à adoção de práticas baseadas em evidências científicas (ANS, 2024).

Apesar de sua aparente relevância regulatória, o consumidor médio ainda desconhece o IDSS ou não sabe como interpretar e utilizar as informações disponibilizadas para tomar decisões mais informadas sobre a escolha de planos de saúde. Esse cenário revela um descompasso entre a função pública do IDSS e sua apropriação social, limitando o potencial do instrumento como mecanismo de empoderamento do usuário e de indução à concorrência por qualidade no setor (ANS, 2024).

A crítica central ao instrumento reside na persistência da assimetria informacional que ele deveria mitigar. Observa-se um desequilíbrio funcional: enquanto as operadoras instrumentalizam o IDSS para seu compliance regulatório, os consumidores permanecem cognitivamente distantes de seu conteúdo, incapazes de decodificar a complexidade técnica dos indicadores. O índice falha, assim, em sua função primordial de reduzir custos de busca e qualificar a decisão de consumo. A superação desse impasse exige mais do que publicidade; demanda uma reformulação na arquitetura de apresentação dos dados. É imperativo investir em estratégias de *disclosure* simplificado e educação em saúde que democratizem a inteligibilidade do índice, transformando o IDSS de uma ferramenta burocrática em um instrumento efetivo de empowerment do beneficiário e de cidadania sanitária (ANS, 2024).

As questões referentes à confecção e à calibragem dos incentivos ao setor no sentido da maior promoção da saúde pelos entes regulados foram novamente enfrentadas pela agência por meio da Tomada Pública de Subsídios (TPS) das linhas de cuidado prioritárias na saúde suplementar⁶⁵. A TPS esteve aberta à colheita de subsídios de 01/12/2023 a 30/06/2024, e a iniciativa esteve alinhada à finalidade institucional e às competências da ANS, assim como o Planejamento Estratégico da ANS, de 2021 a 2024, e o Plano Anual de 2023, que preveem dentre os objetivos da ANS induzir a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo setor de saúde suplementar, de modo a zelar pela qualidade dos serviços prestados na saúde suplementar, por meio de programas de indução e avaliação da qualidade em saúde e da adoção de modelos de atenção à saúde e de remuneração baseada em valor.

A ANS deliberou sobre o tema mais uma vez em 2025, por meio de provocação gerada pela Diretoria de Desenvolvimento Setorial da ANS (Dides/ANS). A discussão se deu durante a 620ª Reunião da Diretoria Colegiada e mais uma vez não houve uma deliberação positiva no sentido de se conferir maiores incentivos a programas de promoção de saúde e prevenção de doenças⁶⁶. Apesar disso, os benefícios previstos para os usuários que aderirem ao Promoprev persistem e seguem disciplinados por meio da Resolução Normativa ANS n. 499, de março de 2022⁶⁷. De

⁶⁵ ANS. TPS nº 2 - Linhas de Cuidado prioritárias na saúde suplementar. Disponível em: <https://componentes-portal.ans.gov.br/link/TomadaPublica/2>. Acesso em: 15 jun. 2025.

⁶⁶ ANS. 620ª Reunião da Diretoria Colegiada. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=B9NN1KQ92ZM>. Acesso em: 15 jun. 2025.

⁶⁷ Mais uma vez, trata-se de normativo que apenas replicou os termos de resolução normativa anterior, no caso, a de n. 264, publicada em agosto de 2011.

acordo com o programa desenhado pela agência, os beneficiários podem ser enquadrados em programas para promoção do envelhecimento ativo ao longo do curso da vida e de premiação pela participação em programas para população-alvo específica e programas para gerenciamento de crônicos.

A primeira forma para incentivar a mudança no comportamento das pessoas é a bonificação, onde se permite a concessão de vantagem pecuniária, representada pela aplicação de desconto no pagamento da contraprestação pecuniária, e a segunda forma é a premiação, que consiste em vantagem, representada pela oferta de prêmio, concedida pela operadora ao beneficiário de plano privado de assistência à saúde como incentivo à sua participação em programa para população-alvo específica e programa para gerenciamento de crônicos. A adesão ao programa, contudo, depende de ato volitivo do beneficiário, expressando a intenção de participar de programa de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças (art. 2º, III)⁶⁸. Como visto, exigir uma conduta ativa do beneficiário nem sempre é melhor disposição em termos de arquitetura de escolhas, na medida em que a inércia tende a nos colocar em situação de paralisia, sendo, em parte, a justificativa para baixas adesões aos programas de cuidado. Ademais, a hipótese onde a regulação indica como escolha padrão a que melhor pode refletir os interesses do optante parece trazer melhores resultados conforme a larga demonstração apresentada pelos estudos empíricos desenvolvidos no âmbito da economia comportamental.

Outro ponto que merece atenção é o fato da operadora que se cadastra junto ao Promoprev não estar obrigada a oferecer bonificação em todos os seus planos de assistência à saúde. Isso implica em desestímulo à adesão aos planos com foco na promoção de saúde e prevenção de doenças, visto que estes tendem a ser oferecidos com mensalidades mais altas especialmente em relação aos entrantes no sistema, que ordinariamente não utilizam coberturas vinculadas a eventos em saúde. Uma vez incluído no programa, parece evidente que o beneficiário deveria ter assegurado o direito de permanecer nesta condição, já que este promoveu um esforço pessoal no sentido de cumprir com as regras fixadas pela operadora, comparecendo em eventos e adotando práticas nem sempre aderentes ao seu próprio interesse mais imediato.

⁶⁸ Esta exigência normativa de opt-in (adesão ativa) é identificada no estudo do Apêndice D como um ponto crítico de atrito. Ao classificar a participação como um ato estritamente voluntário, a regulação deixa de explorar o 'paternalismo libertário' por meio de defaults de renovação automática ou adesão facilitada, que venceriam a inércia do beneficiário sem ferir sua autonomia.

No entanto, o §1º do art. 6º da RN ANS n. 498 permite à operadora interromper o programa, desde que venha a comunicar ao beneficiário com três meses de antecedência do seu término⁶⁹. A bonificação conferida ao usuário aderente ao Promoprev deve ser um percentual sobre o valor da mensalidade, e este não pode variar conforme as faixas etárias dos beneficiários da carteira da operadora. Estranhamente, contudo, poderá variar conforme a região de residência do beneficiário, de acordo com as abrangências geográficas representadas por município, grupos de municípios, estado, grupo de estado ou nacional (art. 9º da RN ANS n. 498).

Uma decisão regulatória importante foi impedir que as operadoras fixem certos filtros discriminatórios e irrazoáveis. Assim, a adesão só dependerá do usuário interessado, e jamais estará condicionada à ausência de doença, faixa etária, sexo, ou mesmo pendente de determinada meta ou resultado em saúde, diminuição de sinistralidade ou utilização de certos procedimentos. O tempo de permanência do beneficiário na operadora também não pode ser um fato a condicionar a adesão aos programas de promoção à saúde e prevenção de doenças.

Já a premiação prevista como incentivo à participação dos beneficiários em programas voltados para população-alvo específica e para gerenciamento de crônicos segue critérios similares à bonificação vista acima. As regras da premiação devem constar de contrato acessório, que formaliza a adesão do beneficiário ao programa e que deve conter regras claras e pré-estabelecidas. Além da simples adesão pelo usuário interessado em participar do programa, a operadora não poderá condicionar o recebimento do prêmio ao alcance de determinada meta ou resultado em saúde, à diminuição de sinistralidade ou utilização de procedimentos; ou mesmo ao tempo de permanência do beneficiário na operadora.

Como demonstração de que nem sempre é possível à regulação limitar-se a instrumentos cooperativos e facultativos, a ANS editou um forte sancionamento às operadoras que descumprirem as regras gerais do Promoprev, com previsão de advertência e multa nas hipóteses previstas entre os artigos 65 e 71 da RN ANS n. 489. Assim, violar as regras setoriais quanto à bonificação ou à premiação podem

⁶⁹ O prazo mínimo de vigência da concessão de bonificação é de doze meses, contado da datada assinatura do termo aditivo contratual, e renovável automaticamente por igual período.

render à operadora multas de até R\$ 35.000,00. Outros bons exemplos de esforços regulatório no sentido de se incentivar o beneficiário a aderir a linhas cuidados temos a Resolução Normativa ANS n. 505, de 30 de março de 2022, que dispõe sobre o Programa de Qualificação de Operadoras.

Para além do Promoprev, a ANS também desenvolve outros programas e ações congêneres, direcionados à qualidade na prestação dos serviços de saúde aos usuários de planos de saúde. Dentre eles constam o Programa de Certificação de Boas Práticas em Atenção à Saúde, o Projeto OncoRede, o Parto Adequado, o QUALISS - Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços de Saúde, o Projeto Enfrentamento da Obesidade e do Sobrepeso, o Programa Modelos de Remuneração Baseados em Valor (ANS, 2025a).

O Programa de Certificação de Boas Práticas em Atenção à Saúde foi lançado no final do ano de 2018, e o objetivo da agência foi justamente incentivar as operadoras a apresentarem linhas de cuidados preventivos e redes de atenção primária. Posteriormente, a Resolução Normativa ANS n. 507, de 30 de março de 2022, instituiu o Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde⁷⁰. O programa é uma certificação de boas práticas em gestão organizacional e em gestão em saúde, de caráter voluntário, realizado por entidades acreditadoras, cujo objetivo é a qualificação da prestação dos serviços, induzindo a mudança no modelo de atenção à saúde existente, propiciando uma melhor experiência para o beneficiário. As operadoras podem se submeter de forma voluntária ao programa. Um dos requisitos é possuir IDSS e de suas dimensões no Programa de Qualificação de Operadoras (PQO) da ANS igual ou maior a 0,6 (seis décimos), para as operadoras médico-hospitalares; (Redação dada pela RN nº 630, de 31/03/2025).

Na análise da Consulta Pública n. 145/2024 também se buscou vincular a revisão técnica ao oferecimento de um compromisso da operadora sobre metas de

⁷⁰ Acreditações hospitalares constituem sinalizações de qualidade processáveis cognitivamente que poderiam ser incorporadas também como componente saliente no IDSS aprimorado. Dados do Observatório Anahp 2025 revelam que hospitais-membros da associação responderam por 28,19% das acreditações totais no Brasil em 2024, mas impressionantes 46,30% das acreditações internacionais (ANAHP, 2025b). Especificamente, 89,47% das certificações Joint Commission International (JCI), 80% das ACSA International e 66,67% das DIAS/NIAHO concentram-se nesses hospitais, evidenciando correlação forte entre participação em sistemas robustos de monitoramento e busca por certificações exigentes.

saúde. Não obstante os esforços acima, o comando e controle também deve ser usado na caixa de ferramentas regulatória. Nesse sentido, restringir as hipóteses de cancelamento unilateral é uma importante medida para incentivar as operadoras a adotarem linhas de cuidado e prevenção, com destaque para as comorbidades e doenças crônicas (medida de comando e controle). Fale assim no fim do cancelamento imotivado para criar um incentivo à política de cuidado e prevenção, com controle de doenças crônicas e comorbidades. Além disso, evita-se a seleção de risco pelas operadoras.

A síntese dos achados é que a ANS trata o tema da promoção da saúde de forma descontínua, com hiatos institucionais relevantes que acabam indicando ao setor que o tema não é prioridade na agenda regulatória. Já as empresas vêm demonstrando que ainda não possuem interesse em instituir programas internos com vistas a oferecer produtos com atenção na saúde e a causa maior é a ausência de incentivos regulatórios. Por parte dos beneficiários, os maiores problemas parecem advir de comportamentos desalinhados com os interesses individuais de longo prazo, visto que os dados mostram que as pessoas seguem priorizando benefícios mais imediatos e não há informação adequada para induzir maior autocuidado.

O resultado é visto nos números. Segundo o Observatório 2025 da Anahp, o investimento em prevenção não chega a 0,5% das receitas das operadoras (ANAHp, 2025a). De acordo com as demonstrações contábeis das operadoras de planos de saúde, apenas 0,25% das receitas geradas pelo segmento no ano de 2024 foram revertidas em programas de prevenção (ANAHp, 2025a). Na prática, no universo de aproximadamente trezentos e cinquenta bilhões de reais, nem um bilhão foi gasto em programas vinculados ao cuidado, mostrando que a lógica hospitalocêntrica do “reparo” ainda predomina no setor. O cenário observado em 2024 aponta ainda que a tendência é de queda nos gastos com prevenção, na medida em que, em termos percentuais, o mercado aplicava próximo a 0,35% das receitas com prevenção.

5.3.3 *Nudges* para ampliar a adesão ao cuidado na saúde suplementar

Para enfrentar esse desafio, estratégias que contraponham essas falhas comportamentais, como incentivos e *nudges*, podem ser adotadas para motivar e facilitar a adoção de hábitos saudáveis.

Os incentivos, que utilizam recompensas ou punições para estimular comportamentos desejados, podem incluir descontos em planos de saúde para pacientes que realizam check-ups regulares ou mantêm um estilo de vida saudável, bem como programas de recompensas que oferecem pontos acumuláveis para ações preventivas, trocáveis por benefícios. A regulamentação do Promoprev, no âmbito agência, já adota inclusive a possibilidade de as operadoras concederem bonificações e premiações aos seus usuários (vide art. 1º da Resolução Normativa ANS n. 499). Já os *nudges*, vistos como intervenções mais sutis que guiam decisões sem também restringir a liberdade de escolha, podem abranger lembretes automatizados para agendar consultas ou tomar medicamentos, simplificação de processos como o agendamento digital de consultas, e ferramentas digitais que monitoram atividades físicas e fornecem *feedback* personalizado. A integração dessas abordagens pode potencializar os resultados, como no exemplo de um aplicativo que rastreia hábitos saudáveis e recompensa os usuários com pontos que reduzem a mensalidade do plano de saúde, além de agendar automaticamente consultas de acompanhamento.

Como visto, o sistema de saúde suplementar brasileiro tem operado sob um modelo de atenção reativa, focado no tratamento de doenças já instaladas e na remediação de agravos. E como forma de tentar reorientar essa lógica, a ANS tem estimulado as operadoras a desenvolverem e implementarem programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças (Promoprev). Não obstante a relevância desses programas, sua adesão e efetividade enfrentam barreiras que não se restringem a meras lacunas de informação, mas estão profundamente enraizadas em vieses cognitivos e falhas comportamentais dos indivíduos (BAICKER; MULLAINATHAN; SCHWARTZSTEIN, 2013).

Nesse sentido, a aplicação de *nudges* pela ANS ainda se mostra muito limitada. Isso porque, a exemplo da RN 265/2011, a opção pela bonificação no programa

Promoprev é facultativa e não se apresenta como opção padrão. O que existe é apenas a imposição às operadoras do dever de comunicar anualmente, “por qualquer meio que assegure a ciência”, da possibilidade de adesão, mecanismo que funciona como lembrete institucional, que desponta como um *nudge* na redação oficial. Sunstein (2018) estabelece que lembretes automatizados para procedimentos preventivos representam intervenções de custo marginal próximo a zero quando operadoras já mantêm sistemas de relacionamento com beneficiários via SMS, e-mail ou aplicativos, exigindo apenas programação de rotinas de disparo baseadas em perfis cadastrais e históricos assistenciais.

Outro *nudge* que emerge da regulação da ANS é derivado da simplificação de etapas e na “redução de cliques”, ou ainda, na simplificação dos cálculos para bonificação, que elevam consistentemente a participação e a qualidade das decisões, evidência disponibilizada às operadoras dentro do marco das RNs 264 e 265, sem necessidade de alteração normativa. A consolidação pela opção do Promoprev pelos usuários pode ser alavancada com agendamento proativo e confirmação simples, prompts personalizados e mensagens salientes em canais preferidos, desde que preservada a liberdade de escolha e a não discriminação (OECD, 2017).

A análise de custo-efetividade desses nudges preventivos na saúde suplementar deve considerar tanto investimentos diretos quanto economias prospectivas decorrentes de redução de eventos evitáveis. Nesse sentido, a OCDE (2017) quantificou impactos orçamentários dessa categoria de *nudge* ao relatar que o programa australiano de lembretes para vacinação custou A\$0,80 por beneficiário alcançado, elevando cobertura vacinal em 12 pontos percentuais e gerando economia estimada de A\$15 milhões anuais em hospitalizações evitadas, razão custo-benefício superior a 1:18.

O programa Promoprev pode ser também uma plataforma ideal para a aplicação de *nudges* que alinham pequenos incentivos financeiros ao plano de longo prazo com o objetivo de prevenir riscos. Um bom exemplo disso é a sugerida isenção de coparticipação para serviços de valor em saúde, a exemplo das medidas associadas ao cuidado preventivo e à promoção da saúde. A vedação de coparticipação quando o plano custeia ações de promoção e prevenção se adequa à economia comportamental porque elimina custos marginais e fricções que desincentivam o uso de serviços preventivos, elevando a adesão por meio do “efeito

preço zero”, redução de aversão à perda imediata e maior previsibilidade para o usuário (ANS, 2017). Em termos teleológicos, a própria regulação da ANS explicita que isenções em procedimentos preventivos e de cuidado crônico servem para “incentivar o adequado cuidado à saúde” e aumentar a participação dos beneficiários em programas de promoção e prevenção mantidos pelas operadoras, o que corresponde à utilização de incentivos econômicos de baixo atrito consistentes com a arquitetura de escolhas da economia comportamental (ANS, 2017).

Sob a ótica da teoria do comportamento, pequenas cobranças atuam como barreiras desproporcionais em decisões intertemporais por conta de viés do presente, custos de atenção e de transação, e aversão a perdas, de modo que sua remoção tem efeito não linear sobre a procura por prevenção; experiências internacionais em políticas públicas mostram que reduzir fricções e simplificar custos de decisão eleva substancialmente a adesão e a qualidade das escolhas do consumidor, especialmente quando combinadas com mensagens salientes e padrões informacionais claros (OECD, 2017). Assim, a isenção de coparticipação funciona como um *nudge* de preço que preserva a liberdade de escolha, mas reequilibra o *trade-off* psicológico e financeiro entre o benefício futuro da prevenção e o custo imediato, tornando a opção preventiva mais acessível cognitivamente e financeiramente sem impor obrigatoriedade, o que é típico do uso de insights comportamentais em regulação pró-bem-estar (OECD, 2017).

Em 2018, a ANS chegou a publicar a Resolução Normativa n. 433, que foi revogada sob intensa pressão política e judicial⁷¹. A resolução isentava a incidência de coparticipação e franquia em mais de 250 procedimentos, como exames preventivos e de pré-natal e tratamentos de doenças crônicas, incluindo tratamento contra o câncer e hemodiálise. Mais recentemente, em 2024, a agência publicou a Consulta Pública n. 145, que tratou de reabrir o debate regulatório⁷². A minuta de resolução normativa sugerida indicada que a coparticipação e a franquia não poderão

⁷¹ A notícia consta do site do STF. “Presidente do STF suspende resolução da ANS que mudou regras de coparticipação e franquias dos planos de saúde”. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384048>

⁷² A composição das contribuições recebidas na consulta pública revelou, mais uma vez, uma participação desproporcional do setor regulado, com 80% das manifestações vindas de operadoras e entidades representativas, enquanto apenas 10% foram de consumidores e seus defensores.

incidir sobre um rol de mais de 250 procedimentos. Este rol inclui exames preventivos, de pré-natal, neonatal e tratamentos para doenças crônicas.

A proposta previa, por exemplo, a isenção de cobrança em até quatro consultas anuais com médicos generalistas e em exames como mamografia, colonoscopia, glicemia de jejum e testes de HIV. A agência também buscava definir o limite financeiro do fator moderador por procedimento, além de estabelecer limites mensais e anuais, em uma tentativa de dar maior previsibilidade ao consumidor. Até o presente, a consulta não se encerrou, tendo sido prorrogada sob a justificativa de garantir a "ampla participação social"⁷³.

Não obstante, a proposta de isenção de coparticipação para cuidados preventivos e de doenças crônicas é um *nudge* regulatório promissor que tem o potencial de beneficiar a saúde do beneficiário e, a longo prazo, a sustentabilidade do setor. Vale referir que atualmente, ainda valem as regras que tratam de coparticipação e franquia constam da resolução do Conselho de Saúde Suplementar – Consu, datada de novembro de 1998, que são genéricas e não estabelecem com clareza condições, critérios e limites para aplicação⁷⁴.

Outro achado relevante indica que a utilização mais contínua dos serviços de saúde, típica das ações preventivas, cria ancoragem comportamental que reduz dramaticamente probabilidade de cancelamento dos planos de saúde, revelando um paradoxo na lógica preventiva. Nesse sentido, Souza et al. (2024) estimam que cada consulta mensal adicional reduz risco de cancelamento ou troca para plano mais restrito em aproximadamente 47,2%, enquanto beneficiários com doenças crônicas têm probabilidade de permanência substancialmente maior (47,57% dos que permaneceram vs. 35,35% dos que saíram tinham diagnóstico crônico). Os autores documentam que beneficiários que permaneceram no plano apresentavam média de 0,54 consultas mensais comparado a 0,46 entre os que saíram, e 0,93 internações no período versus 0,70. Essa relação inversa entre utilização e probabilidade de cancelamento tem outra implicação comportamental crucial, demonstrando que indivíduos saudáveis que deveriam engajar-se em prevenção para evitar futuros

⁷³ Vide “ANS prorroga prazo da Consulta Pública 145”. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sociedade/ans-prorroga-prazo-da-consulta-publica-145>. Acesso em: 15 de set. 2025.

⁷⁴ CONSU n. 8.

problemas de saúde são precisamente aqueles com maior propensão a cancelar cobertura por perceberem o “baixo retorno” imediato de mensalidades pagas, enquanto aqueles que já enfrentam condições crônicas permanecem devido a saliência de necessidades assistenciais presentes e concretas. Este padrão parece também validar a predição da economia comportamental sobre o viés de disponibilidade, onde experiências recentes com sistema de saúde tornam-se psicologicamente salientes, ancorando decisões de permanência, enquanto benefícios prospectivos e probabilísticos de prevenção permanecem abstratos e descontados excessivamente.

No modelo de negócios das *healthtechs*, conforme documenta Takahashi (2022), as ações de saúde focam na atenção primária, com triagem centralizada e uso intensivo de tecnologia para coordenação do cuidado. Embora o autor analise essa estratégia sob ótica de alinhamento de incentivos econômicos, sua efetividade depende crucialmente de mecanismos comportamentais: ao exigir ou incentivar fortemente triagem pelo time de saúde antes de acesso a especialistas, essas operadoras estabelecem *default* que explora inércia dos beneficiários, tornando o caminho preventivo a opção padrão facilitada. Adicionalmente, Takahashi identifica que algumas *healthtechs* não cobram coparticipação quando atendimento é direcionado pelo time de saúde, mecanismo que combina incentivo econômico tradicional com enquadramento comportamental que destaca ganhos de seguir recomendação profissional ao invés de perdas de autonomia decisória. Essa combinação de *nudges* estruturais e incentivos econômicos representa aplicação prática dos princípios do paternalismo libertário aplicados à arquitetura de escolhas em saúde suplementar.

A literatura internacional oferece lições fundamentais ainda não incorporadas ao desenho do Promoprev quanto ao poder das opções padrões. Handel (2013) documenta que novos empregados ingressando em anos subsequentes à mudança nas opções de planos de saúde oferecidos por empregador apresentam distribuição de escolhas dramaticamente distinta daquela de cortes anteriores sujeitas a inércia (21% vs. 11% escolhendo plano mais abrangente), evidenciando que o momento de escolha ativa forçada determina a trajetória de longo prazo dos usuários. Para o Promoprev, essas evidências sugerem que modelo atual de opt-in onde beneficiário deve manifestar adesão ativa desperdiça uma janela comportamental crítica: o

momento de contratação inicial de plano ou de renovação anual, quando o beneficiário já está cognitivamente engajado em decisão de saúde, constitui oportunidade para *default* de inclusão automática em programa preventivo com opt-out preservado.

No âmbito da regulação, a ANS ainda não aborda o uso de novas ferramentas eletrônicas, projetadas para auxiliarem os usuários na mudança de comportamentos relacionados à saúde. Nessas aplicações, é possível monitorar o número de passos percorridos por dia, estimar calorias de alimentos consumidos, melhorar a literacia acerca de calorias e descrição nutricional de alimentos, gerar gráficos sobre o histórico de condutas saudáveis e até localizar profissionais e instalações de saúde vinculadas ao bem-estar. Tais ferramentas estão se integrando a programas de recompensas e promovendo comportamentos saudáveis (OCDE, 2019).

Por óbvio, as expectativas sobre a efetividade dos *nudges* aqui sugeridos devem ser calibradas realisticamente com base em evidências empíricas disponíveis. Conforme Engelen e Schmidt (2020) documentam, para um *nudge* típico em cafeteria (maças posicionadas ao nível dos olhos), um aumento de 10% no consumo de maçãs já seria considerado sucesso, mesmo que 90% dos consumidores resistam ou ignorem a intervenção. Este dado empírico tem implicação dupla. Por um lado, valida a preocupação sobre a resistibilidade já que *nudges* efetivos não eliminam escolha individual, mantendo autonomia de decisão para vasta maioria. Por outro, tempera expectativas infladas sobre a capacidade transformadora dessas intervenções: aumentos modestos de 10-15% em comportamentos desejados representam um patamar realista e não mudanças revolucionárias. Para o Promoprev na saúde suplementar, isso significa que as intervenções comportamentais bem-sucedidas poderiam elevar taxa de adesão a programas preventivos de, hipoteticamente, 15% para 25% dos beneficiários elegíveis – resultado que, embora modesto percentualmente, representaria milhões de pessoas adicionais engajadas em cuidado preventivo e potencial redução de centenas de milhões de reais em custos assistenciais futuros. Em operações verticalizadas, há inclusive maior capacidade de implementar *nudges* estruturais ao longo da jornada assistencial, visto que controlam pontos de contato decisórios onde a arquitetura de escolhas pode ser desenhada intencionalmente (TAKAHASHI, 2022).

A chave parece residir na combinação de *nudges* com outras políticas complementares, reconhecendo que nenhuma intervenção isolada constitui solução

acabada, mas um conjunto coordenado de instrumentos que pode gerar impactos agregados significativos.

CONCLUSÃO

A presente pesquisa partiu da hipótese de que a regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar deveria incorporar princípios e ferramentas inspirados na economia comportamental como instrumentos de baixo custo regulatório voltados à promoção da saúde e prevenção de doenças no setor de saúde suplementar brasileiro. Ao longo do trabalho, buscou-se demonstrar que a ANS tem desenvolvido mecanismos regulatórios por incentivos alinhados à lógica do *law and economics*, reconhecendo falhas de mercado como assimetria informacional, seleção adversa e risco moral.

As evidências colhidas ao longo da investigação demonstram que a agência reguladora efetivamente já identifica problemas associados a falhas comportamentais dos agentes econômicos e dos beneficiários, reconhecendo limitações como inércia, viés do presente, otimismo irrealista e dificuldades cognitivas na tomada de decisão em contextos complexos, especialmente na escolha de planos de saúde e na adesão a programas preventivos. No entanto, a análise detalhada dos instrumentos regulatórios revela que as soluções implementadas até o momento exploram de forma assimétrica os *insights* comportamentais disponíveis.

A regulação concentra-se predominantemente na constituição de incentivos dirigidos às operadoras de planos de saúde por meio de bonificações no IDSS, programas de acreditação voluntária, incentivos econômico-financeiros e exigências de governança, enquanto as intervenções dirigidas aos usuários permanecem limitadas, fragmentadas e desprovidas de arquitetura de escolhas consistente com os achados empíricos da economia comportamental. O estudo do IDSS evidenciou que, embora o indicador tenha sido concebido como ferramenta de redução de assimetria informacional e empoderamento do consumidor, sua execução padece de graves deficiências na comunicação, simplicidade e transparência, resultando em um instrumento conhecido e utilizado predominantemente pelas próprias operadoras para fins de marketing institucional e obtenção de benefícios regulatórios, mas que permanece inacessível e incompreensível para o consumidor médio que deveria utilizá-lo como parâmetro de decisão na escolha de um plano de saúde.

A arquitetura regulatória do Promoprev revela uma assimetria fundamental: enquanto fomenta a oferta de prevenção pelas operadoras, ignora as heurísticas que governam a decisão dos beneficiários. Ao impor um modelo de adesão ativa, a

regulação desafia o princípio da inércia e desperdiça o potencial dos padrões (*defaults*) automáticos, amplamente validados por Thaler e Sunstein (2008). A eficácia do programa é ainda erodida pela falta de saliência informacional e pela ausência de *reminders* automatizados, gerando custos cognitivos que desestimulam a participação. Nesse cenário, a proibição de cobrança de coparticipação em eventos preventivos destaca-se como um raro exemplo de alinhamento com a economia comportamental. Tal medida atua removendo fricções financeiras e psicológicas, operando como um incentivo de baixo atrito que sinaliza corretamente a prioridade do cuidado preventivo, confirmando que intervenções de baixo custo podem gerar impactos assistenciais substantivos.

Os achados desta pesquisa sugerem que a ANS avança na incorporação da economia comportamental à sua prática regulatória. A agência demonstra consciência das falhas comportamentais e das limitações cognitivas dos agentes, mas ainda não desenvolveu um *framework* regulatório sistematizado e abrangente para enfrentá-las de forma consistente e coordenada. Medidas simples como a simplificação da linguagem e da apresentação visual do IDSS, a criação de plataformas digitais interativas de comparação de planos com sugestões personalizadas baseadas no perfil do usuário, a implementação de lembretes automatizados para exames preventivos e consultas de acompanhamento, a adoção de inscrição automática com opção de *opt-out* nos programas de prevenção, a gamificação de aplicativos de saúde com recompensas por comportamentos saudáveis, e a padronização de categorias de planos em bronze, prata e ouro para facilitar comparações representam intervenções de baixo custo regulatório que poderiam gerar ganhos significativos na qualidade das decisões dos consumidores, na adesão a programas preventivos e, consequentemente, na sustentabilidade econômico-financeira do setor e na saúde da população coberta pela saúde suplementar.

A contribuição central do trabalho reside na demonstração empírica de que a regulação da saúde suplementar brasileira já tangencia, ainda que de forma incipiente e desconexa, os princípios do *behavioral law and economics*, reconhecendo falhas comportamentais e criando alguns incentivos alinhados a essa lógica, mas que permanece distante de explorar plenamente o potencial transformador dessas ferramentas, especialmente no que se refere à comunicação com os consumidores, à

simplificação de processos decisórios complexos e à arquitetura de escolhas que facilite comportamentos alinhados ao interesse de longo prazo dos beneficiários.

Por fim, espera-se que este trabalho contribua para o avanço do debate acadêmico e regulatório sobre a aplicação da economia comportamental na regulação setorial brasileira, demonstrando que pequenos ajustes na arquitetura regulatória, fundamentados em evidências empíricas sólidas sobre o comportamento humano real, podem produzir ganhos significativos em eficiência, equidade e qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. A agenda de pesquisa futura deve incluir a avaliação experimental de intervenções comportamentais específicas no contexto brasileiro, a mensuração de seus efeitos sobre indicadores de saúde populacional e sustentabilidade do setor, a análise de experiências internacionais adaptáveis à realidade nacional, e o desenvolvimento de diretrizes metodológicas para incorporação sistemática de *behavioral insights* ao processo regulatório da ANS.

Como visto, o propósito central não foi comprovar empiricamente a efetividade de *nudges* específicos na saúde suplementar brasileira ou mesmo estimar custos e retornos precisos de implementação de determinadas intervenções. A principal contribuição residiu em identificar, por meio de análise da regulação vigente e literatura especializada, uma expressiva lacuna comportamental nas políticas da ANS e sugerir categorias de intervenções baseadas em economia comportamental que têm suporte em experiências internacionais e evidências teóricas consolidadas. Essas proposições fornecem referência qualificada para trabalhos futuros, acadêmicos e institucionais, capazes de conduzir testes empíricos, pilotos ou avaliações de custo-benefício detalhadas. Portanto, espera-se que este trabalho tenha cumprido com a necessária função de diagnóstico, fundamentação e proposição para um campo ainda incipiente, fortalecendo a base para pesquisas e inovações regulatórias futuras.

O setor de saúde suplementar brasileiro, que atende mais de 50 milhões de beneficiários e movimenta centenas de bilhões de reais anualmente, não pode prescindir de ferramentas regulatórias modernas, eficientes e cientificamente fundamentadas que promovam simultaneamente a sustentabilidade econômico-financeira das operadoras, a qualidade e segurança dos serviços prestados e, sobretudo, a saúde, o bem-estar e a capacidade de escolha informada dos cidadãos brasileiros que dependem desse sistema.

REFERÊNCIAS

AKERLOF, George A. The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, v. 84, n. 3, p. 488-500, ago. 1970.

AMORIM, Laíres Cristina; CHERCHIGLIA, Mariangela Leal; REIS, Ilka Afonso. Beneficiários de planos privados de saúde que utilizaram a rede pública de hemodiálise ambulatorial no Brasil entre 2012 e 2019. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 39, n. 8, e00188422, 2023.

ANAHP. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS PRIVADOS. Balanço – Observatório Anahp. 5ª edição. 2025 Disponível em: <https://www.anahp.com.br/publicacoes/balanco-observatorio-anahp-5a-edicao/>. Acesso em: 14 jun. 2025.

ANAHP. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HOSPITAIS PRIVADOS. Observatório Anahp 2025. Disponível em: <https://www.anahp.com.br/publicacoes/observatorio-anahp-2025/>. Acesso em: 14 jun. 2025.

ANDRADE, Mônica Viegas; GAMA, Marina Moreira da; RUIZ, Ricardo Machado; MAIA, Ana Carolina; MODENESI, Bernardo; TIBURCIO, Daniel Matos. Mercados e concentração no setor suplementar de planos e seguros de saúde no Brasil. *Pesquisa e Planejamento Econômico*, v. 42, n. 3, p. 329-377, dez. 2012. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstreams/f7c0ec9a-1be9-4297-90df-e9cb24dd6386/download>. Acesso em: 12 nov. 2025.

ANDRADE, Mônica Viegas; MAIA, Ana Carolina; LIMA, Helena Wajnman; CARVALHO, Lucas Resende de. Estrutura de concorrência no setor de operadoras de planos de saúde no Brasil. *Série Cooperação em Saúde Suplementar no Brasil*. Brasília: ANS, 2015.

ANDRADE, Mônica Viegas; NORONHA, Kenya; SÁ, Edvaldo Batista; PIOLA, Sergio; VIEIRA, Fabiola Sulpinho; VIEIRA, Roberta da Silva; BENEVIDES, Rodrigo Pucci de Sá e. Desafios do Sistema de Saúde Brasileiro. in: *Desafios da nação: artigos de apoio*, volume 2. 1ed. Brasília: Ipea, 2018, p. 357-414.

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Relatório de Gestão Exercício de 2004. 2005. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/aceso-a-informacao/transparencia-institucional/prestacao-de-contas/relatorios-de-gestao/relatorio-gestao-2004-pdf>. Acesso em: 15 jun. 2025.

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Relatório de Gestão Exercício de 2005. 2006. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/aceso-a-informacao/transparencia-institucional/prestacao-de-contas/relatorios-de-gestao/relatorio-gestao-2005-pdf/view>. Acesso em: 15 jun. 2025.

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Relatório de Gestão Exercício de 2008. 2009. Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/aceso-a-informacao/transparencia-institucional/prestacao-de-contas/relatorios-de-gestao/Relatorio_Gestao_2008.pdf. Acesso em: 15 nov. 2025.

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Relatório Final da Consulta Pública n. 46 Compilado. Indicadores do Programa de Qualificação da Saúde Suplementar Componente Operadoras – 1ª ETAPA DA 4ª FASE. 2011. Disponível em: <https://componentes-portal.ans.gov.br/link/ConsultaPublica/46>. Acesso em: 17 set. 2025.

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nota Técnica - RN Incentivos à participação em programas de promoção à saúde e prevenção de riscos e doenças. 2011. Disponível em: <https://componentes-portal.ans.gov.br/link/ConsultaPublica/46>. Acesso em: 17 set. 2025.

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Exposição de Motivos - Nota do Grupo Técnico Envelhecimento Ativo n.º 1. 2011. Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/aceso-a-informacao/participacao-da-sociedade/consultas-publicas/cp42/cp_42_exposicao_de_consulta.pdf. Acesso em: 24 set. 2025.

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Relatório de Análise de Impacto Regulatório. Mecanismos Financeiros de Regulação – Coparticipação e Franquia. 2017. Disponível em: <https://componentes-portal.ans.gov.br/link/ConsultaPublica/60>. Acesso em: 15 set. 2025.

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Documento técnico para a realização da pesquisa de satisfação de beneficiários de planos de saúde. Rio de Janeiro: ANS, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/aceso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor/dados-do-programa-de-qualificacao-de-operadoras/Documento_tecnico_da_pesquisa_de_satisfacao.pdf. Acesso em: 15 set. 2025.

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Relatório do programa de qualificação de operadoras 2024 (ano base 2023) - Índice de desempenho da saúde suplementar IDSS. Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES). e-Pub. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/Relatorio do Programa de Qualificacao de Operadoras IDSS 2024r4 atualizacao fev2025 errata fig3.pdf>. Acesso em: 24 set. 2025.

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Relatório anual de gestão e de atividades 2025 – Exercício 2024 / Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). Diretoria Colegiada. Secretaria Geral. Gerencia de Planejamento e Acompanhamento. Rio de Janeiro: ANS, 2025.

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Apresentação durante a Oficina IDSS-TISS, realizada em 26/02/2025. 2025. Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/Oficina_IDSS 26fev2025 vf.pdf. Acesso em: 12 out. 2025.

ARIDA, Pérsio. A Pesquisa em Direito e Economia: em torno da historicidade da norma. IN: ZYLBERSZTAJN, Decio e SZTAJN, Rachel. Direito & Economia – Análise Econômica do Direito e das Organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, pp. 60-73.

ARIELY, D. Predictably irrational: The hidden forces that shape our decisions. New York: HarperCollins, 2008.

ARROW, Kenneth J. Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. The American Economic Review, vol. 53, N. 5. 1963.

AZEVEDO, Paulo Furquim; ALMEIDA, Silvia FÁga de; ITO, Nobuiuki Costa; MORON, Caroline Raiz; INHASZ, William; BOARATI, Vanessa; ROUSSET, Fernanda. A Cadeia de Saúde Suplementar no Brasil: Avaliação de Falhas de Mercado e Propostas de Políticas. White Paper Nº 1, Insper - Centro de Estudos em Negócios, mai. 2016. Disponível em: < <https://repositorio.insper.edu.br/entities/publication/96d64c68-609d-4671-8a7b-d09e50d3e917> >. Acesso em: 10 nov. 2025.

BAGNOLI, Vicente. Credenciamento e descredenciamento de prestadores sob a ótica concorrencial: verticalização. In: Eduardo Molan Gaban; Tainá Leandro; Tatiana de Campos Aranovich; Vinicius Klein. (Org.). Concorrência e a saúde suplementar. 1ed. São Paulo: Instituto Brasileiro de Concorrência e Inovação - IBCI, 2023, v. 1, p. 367-389.

BAICKER Katherine, MULLAINATHAN, Sendhil, SCHWARTZSTEIN, Joshua. Behavioral hazard in health insurance. Natl Bur Econ Res Bull Aging Health. 2013. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4657453/>. Acesso em: 15 de set. 2025.

BALDWIN, R.; CAVE, M.; LODGE, M. Understanding regulation: theory, strategy, and practice. 2ª ed. New York: Oxford University Press, 2012.

BHARGAVA, Saurabh. LOEWENSTEIN, George. Behavioral Economics and Public Policy 102: Beyond Nudging. American Economic Review, v. 105, n. 5, pp. 396-401, 2015.

BECKER, Gary S. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, v. 76, n. 2, p. 169-217, 1968

BECKER, Gary S.; BECKER, Guity Nashat. The economics of life: from baseball to affirmative action to immigration, how real-world issues affect our everyday life. New York: McGraw-Hill, 1997.

CADE. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. Mercado de saúde suplementar: condutas. Edição revista e atualizada. Cadernos do Cade. Brasília: Departamento de Estudos Econômicos – DEE/CADE, 2021.

CALABRESI, Guido. Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts. Yale Law Journal, New Haven, v. 70, n. 4, p. 499-553, mar. 1961.

CALABRESI, Guido. The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis. New Haven: Yale University Press, 1970.

CALABRESI, Guido. The Future of Law and Economics: Essays in Reform and Recollection. New Haven: Yale University Press, 2016.

CAMBOTA, Jacqueline Nogueira; ROCHA, Fabiana Fontes. Determinantes das desigualdades na utilização de serviços de saúde: análise para o Brasil e regiões. *Revista Pesquisa e Planejamento Econômico*, v. 45, n. 2, p. 219-243, 2015. Disponível em: <http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/1528/1204>. Acesso em: 16 jun. 2025.

CAMERER, C.; ISSACHAROFF, S.; LOEWENSTEIN, G.; O'DONOGHUE, T.; RABIN, M. Regulation for conservatives: behavioral economics and the case for "asymmetric paternalism". *University of Pennsylvania Law Review*, v. 151, n. 3, p. 1211-1254, 2003.

CAMPANA, Gustavo Aguiar; OPLUSTIL, Carmen Paz; FARO, Lorena Brito de. Tendências em medicina laboratorial. *Bras Patol Med Lab*. v. 47. n. 4. 2011.

CARDOSO, Henrique Ribeiro. O Poder Normativo das Agências Reguladoras. 2ª Ed. Revista e Atualizada. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

CHANDRA, Amitabh; HANDEL, Benjamin; SCHWARTZSTEIN, Joshua. "Behavioral Economics and Health-Care Markets." Chap. 6 in *Handbook of Behavioral Economics: Foundations and Applications 2*, edited by B. Douglas Bernheim, Stefano DellaVigna, and David Laibson, 459–502. Amsterdam: Elsevier/North-Holland, 2019.

CNSaúde. Confederação Nacional da Saúde. Cenário dos Hospitais no Brasil 2021-2022. Disponível em: <http://cnsaude.org.br/wp-content/uploads/2022/07/CNSAUDE-FBH-CENARIOS-2022.pdf>. Acesso em 02/02/2025.

COASE, Ronald. The Problem of Social Cost. *Journal of Law and Economics*, v. 3, p. 1-44, out. 1960.

COOTER, Robert; ULEN, Thomas. *Law and economics*. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 2000.

CRISP, Nigel. *Health Is Made at Home, Hospitals Are For Repairs: Building a Healthy and Health-Creating Society*. Londres: Salus, 2020.

DAI, H.; SACCARDO, S., HAN, M.A. et al. Behavioural nudges increase COVID-19 vaccinations. *Nature* 597, 404–409 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03843-2>.

ENGELLEN, B.; SCHMIDT, A. 'The Ethics of Nudging: An Overview', *Philosophy Compass*. 2020. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/phc3.12658>. Acesso em: 24 out. 2025.

FLEURY, Sônia. *Saúde e democracia no Brasil: valor público e capitalismo político*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2011.

FORGIONI, Paula Andrea. *Contratos empresariais: Teoria Geral e Aplicação*. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.

FRIEDMAN, David D. *Law's order: what economics has to do with law and why it matters*. Princeton University Press, 2000.

GELTER, Martin; GRECHENIG, Kristoffel. History of Law and Economics. Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods, n. 2014/5, Bonn, 2014.

GICO JR., Ivo. Introdução ao Direito e Economia. In: Direito e Economia no Brasil. TIMM, Luciano Benetti (Org.). 4. ed. São Paulo: Foco, 2021.

GIGERENZER, Gerd. The Bias Bias in Behavioral Economics. Review of Behavioral Economics, 2018, 5: 303–336.

GLEICHER, Érika Cristina Araújo Brandão. Análise econômica da saúde suplementar: judicialização e aplicação da reserva do possível. 2023. Dissertação (Mestrado em Direito da Regulação) – Escola de Direito do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2023.

GORDON, W. J.; MARCIANO, A.; RAMELLO, G. B. The Future of Law and Economics and the Legacy of Guido Calabresi. European Journal of Law and Economics, v. 48, p. 1-8, 2019

GREGORI, Maria Stella. Planos de Saúde: a ótica da proteção do consumidor. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

GUANAIS, Frederico; REGALIA, Ferdinando; PÉREZ-CUEVAS, Ricardo; ANAYA, Milagros. From the patient's perspective: experiences with primary health care in Latin America and the Caribbean, Inter-American Development Bank, Washington. 2019.

HALPERN, D.; SANDERS, M. Nudging by government: Progress, impact, & lessons learned. Behavioral Science & Policy, 2(2). 2016, pp. 53–65.

HANDEL, Benjamin R. Adverse Selection and Inertia in Health Insurance Markets: When Nudging Hurts. American Economic Review. 2013. 103(7): 2643–2682. <http://dx.doi.org/10.1257/aer.103.7.2643>.

HAYEK, F. A. A ordem econômica e a livre iniciativa. São Paulo: Avis Rara, 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agência de Notícias. Sob efeitos da pandemia, consumo de bens e serviços de saúde cai 4,4% em 2020, mas cresce 10,3% em 2021. 05 abr.2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/33484-despesas-com-saude-em-2019-representam-9-6-do-pib>. Acesso em: 15 jun. 2025.

IYENGAR, Sheena S.; LEPPER, Mark R. When choice is demotivating: Can one desire too much of a good thing? Journal of Personality and Social Psychology, v. 79, n. 6, p. 995–1006, 2000.

JOLLS, C.; SUNSTEIN, C. R.; THALER, R. A Behavioral Approach to Law and Economics. Stanford Law Review, v. 50, p. 1471-1550, 1998.

KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar: duas formas de pensar. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

KHADZHYRADIEVA, Svitlana; HRECHKO, Tetiana; SAVKOV, Anatolii. Behavioral Insights in Public Policy: Ukrainian Case. *Public Policy And Administration*. 18. 2019.

LADEIRA, Fernando de Oliveira Domingues. *Regulação estatal e assistência privada à saúde: liberdade de iniciativa e responsabilidade social na saúde suplementar*. Belo Horizonte, Fórum, 2012.

LAZZARINI, Marilena. A Voz dos Consumidores nas Agências Reguladoras. In: PROENÇA, Jadir Dias; COSTA, Patrícia Vieira; MONTAGNER, Paula (org.). *Desafios da regulação no Brasil*. Brasília: ENAP, 2006. Pp. 59-72.

LEONETTI, Carlos Araujo; FERIATO, Juliana Marteli. Análise Econômica do Direito Tributário: O fato gerador presumido. In: GONÇALVES, Everton das Neves; AZEVEDO, Lyza Anzanello de; GONÇALVES, Jéssica. *Direito, Justiça e Economia – a influência dos parâmetros econômicos legais na esfera legal*. 1ed. Florianópolis: EMais, 2019. p .223-233.

LIMA, Dagoberto José Steinmeyer. *Os bastidores da saúde suplementar no Brasil: memórias de um advogado*. 1. ed. São Paulo: Edição do Autor, 2016.

MAIER, M; BARTOŠ, F.; STANLEY, T.D.; WAGENMAKERS, E. No evidence for nudging after adjusting for publication bias. 2022. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 119 (31). Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.2200300119>. Acesso em: 17 out. 2025.

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. *Regulação estatal e interesses públicos*. São Paulo: Malheiros, 2002.

MARTINS, Ana Virgínia Feitosa; FEITOSA, Ana virginia; PETER, Maria da Gloria Arrais Peter; MACHADO, Marcus Vinicius Veras Machado; CATRIB, Ana Maria Fontenelle Catrib; RODRIGUES, Maria Denise Nunes. Estratégias para redução de custos em operadoras de plano de saúde. *Revista de Informação Contábil*, v. 7, n. 1, p. 55-72, 2013.

MERTENS, S.; HERBERZ, M.; HAHNEL, U. J. J.; BROSCH, T. The effectiveness of nudging: A meta-analysis of choice architecture interventions across behavioral domains. 2022. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.2107346118>. Acesso em: 17 out. 2025.

MÖLLENKAMP, Meilin; ZEPPERINICK, Maike; SCHREYÖGG, Jonas. The effectiveness of nudges in improving the self-management of patients with chronic diseases: A systematic literature review. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2019.09.008>. Acesso em: 15 de set. 2025.

MONTONE, Januário. “Evolução e desafios da regulação do setor de saúde suplementar.” In: MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANS. *Documentos técnicos de apoio ao Fórum de Saúde Suplementar em 2003*. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2004, p. 9-48.

MORAES, Alice Ferry de; ARAÚJO, Leonardo Martins de. A assimetria de informação presente nos contratos de planos de saúde. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 10., 2009, João Pessoa. Anais... João Pessoa: ANCIB, 2009. Disponível em: <http://enancib.ibict.br/index.php/enancib/xenancib/paper/viewFile/3256/2382>. Acesso em: 12 dez. 2025.

NASEM. NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. 2023. Behavioral Economics: Policy Impact and Future Directions. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/26874>.

NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa e Burocracia: impacto da eficiência no direito administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012.

OCDE. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Estudo da OCDE da Atenção Primária à Saúde no Brasil. OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9bf007f4-pt>. 2021.

OCDE. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around the World, OECD Publishing, Paris. 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264270480-en>. Acesso em: 06 nov. 2025.

OCDE. Institucionalização das contas de saúde no Brasil: Uma revisão sobre métodos, dados e relevância para as políticas públicas. OECD Publishing, Paris, 2025. <https://doi.org/10.1787/76fe796c-pt>.

OLIVEIRA, Daniela Furtado de; KORNIS, George Edward Machado. A política de qualificação da saúde suplementar no Brasil: uma revisão crítica do índice de desempenho da saúde suplementar. Physis: revista de saúde coletiva. Jan-Mar 2017. <https://doi.org/10.1590/s0103-73312017000200003>.

OLIVEIRA, Jaime A. de Araujo; TEIXEIRA, Sônia M. Fleury. (Im)previdência social: 60 anos de história da previdência no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1985.

PAIM, Jairnilson Silva. Reforma Sanitária Brasileira: contribuição para compreensão e crítica. Salvador: Editora Fiocruz, 2008

PAIM, Jairnilson Silva. S. A reforma sanitária brasileira e o Sistema Único de Saúde. In: CAMPOS, G. W. S. et al. (Org.). Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2013. p. 69-102.

PEREIRA, João Márcio Mendes. As estratégias de assistência do Banco Mundial para o Brasil em perspectiva política (1990-2020). Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 14, n. 37, p. e0301, 2022. DOI: 10.5965/2175180314372022e0301. Disponível em: <https://revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/2175180314372022e0301>. Acesso em: 16 jun. 2025.

PIGOU, Arthur Cecil. The Economics of Welfare. London: Macmillan, 1920.

POLINSKY, A. Mitchell. An introduction to law and economics. 2. ed. Boston: Little, Brown, 1989.

POSNER, Richard A. Rational choice, behavioral economics, and the law. Stanford Law Review, 50(5), 1551-1575, 1998.

POSNER, Richard A. Economic analysis of law. 8. ed. New York: Aspen Publishers, 2011.

QUIRINO, Carina de Castro. Políticas Regulatórias e a Caixa de Ferramentas da Economia Comportamental. In: Regulação e infraestrutura. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 167-186.

REICHHELD, Frederick F. A pergunta definitiva 2.0: como as empresas que implementam o net promoter score prosperam em um mundo voltado aos clientes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. A atuação dos grupos de interesse nas consultas e audiências públicas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Revista Estudos Institucionais, v. 7, n. 1, p. 22-53, jan./abr. 2021.

SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da Atividade Econômica: Princípios e Fundamentos Jurídicos. 3ª. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2021.

SAMUELSON, William; ZECKHAUSER, Richard. Status Quo Bias in Decision Making. Journal of Risk and Uncertainty, Vol. 1, No. 1, pp. 7-59. 1988. Published by: Springer. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/41760530>. Acesso em: 15 set. 2025.

SCAFF, Fernando Campos. Direito à Saúde no Âmbito Privado. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

SCHWARTZ, Barry. The Paradox of Choice: Why More Is Less. New York: Harper Perennial, 2004.

SILVA, José Luiz Toro da. Comentários à Lei dos Planos de Saúde. 2. ed. Porto Alegre: Síntese, 1998.

SILVEIRA, Luciana Souza da. Prevenção de doenças e promoção da saúde: diferenciais estratégicos na conjuntura da saúde suplementar. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro. Fundação Oswaldo Cruz. 2004.

SIMON, Herbert A. "A behavioral model of rational choice." The Quarterly Journal of Economics, v. 69, n. 1, p. 99-118, 1955.

SIMON, Herbert A. "Models of Man: Social and Rational." Mathematical Essays on Rational Human Behavior in a Social Setting. John Wiley & Sons, 1957.

SINAIKO, A. D.; HIRTH, R. A. Consumers, Health Insurance and Dominated Choices. Cambridge: National Bureau of Economic Research, 2009. Disponível em:

https://www.bu.edu/sph/files/2010/10/Sinaiko_and_Hirth_092109.pdf. Acesso em: 12 dez. 2025.

SOUZA, A. de; Viegas Andrade, M., Noronha, K.V.M.S.; Souza, I. V. M. . A escolha individual de cobertura privada de saúde em diferentes etapas do ciclo de vida em uma operadora de saúde no Brasil. *Revista Brasileira De Estudos De População*, 41, 1–22. 2024. <https://doi.org/10.20947/S0102-3098a0270>.

STIGLER, George J. The theory of economic regulation. *The Bell journal of economics and management science*, p. 3-21, 1971.

SUNSTEIN, Cass R. Nudges That Fail. Harvard Public Law Working Paper Forthcoming. 2016. Disponível em: SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2809658>. Acesso em: 17 out. 2025.

SUNSTEIN, Cass R. *The Cost-Benefit Revolution*. Cambridge, 2018. MIT Press.

TAKAHASHI, Gabriel Silva. Novos modelos de negócios de planos de saúde e incentivos na cadeia de saúde suplementar. 2022. Dissertação (Mestrado em Economia) – Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, São Paulo, 2022.

TEIXEIRA, Luiz Felipe Drummond. *Nudges e Intervenção Estatal*. São Paulo: Singular, 2024.

THALER, Richard H. *Misbehaving: The Making of Behavioral Economics*. New York: W. W. Norton & Company, 2015.

THALER, Richard. H.; SUNSTEIN, Cass R. Libertarian paternalism. *American Economic Review*, v. 93, n. 2, p. 175-179, 2003.

THALER, Richard. H.; SUNSTEIN, Cass R. Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron. *The University of Chicago Law Review*, Vol. 70, No. 4 (Autumn, 2003), pp. 1159-1202, 2003.

THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. *Nudge: Como tomar melhores decisões*. Trad. Ângelo Lessa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2023.

TIMM, Luciano Benetti. *Direito e Economia no Brasil*. TIMM, Luciano Benetti (Org.). 4. ed. São Paulo: Foco, 2021.

TIROLE, Jean. *Economia do bem comum*. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

TOR, Avishalom; TEICHMAN, Doran; ZAMIR, Eyal. If You Can't Beat Them, Join Them: Richard Posner and Behavioral Law and Economics, 31 *Hist. Econ. Ideas* 67 (2023). Disponível em: https://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/1544. Acesso em: 22 set. 2025.

TVERSKY, A.; KAHNEMAN, D. Availability: A heuristic for judging frequency and probability. *Cognitive Psychology*, v. 5, n. 2, p. 207-232, 1973.

TVERSKY, A.; KAHNEMAN, D. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, v. 185, n. 4157, p. 1124-1131, 1974.

TVERSKY, A.; KAHNEMAN, D. Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, v. 47, n. 2, p. 263-291, 1979.

TVERSKY, A.; KAHNEMAN, D. The framing of decisions and the psychology of choice. *Science*, v. 211, n. 4481, p. 453-458, 1981.

TYLER, Tom R. *Why people obey the law*. Princeton University Press, 2006.

VECINA, Gonzalo. O sistema de atenção à saúde privado no Brasil. *CNN Brasil*, 4 ago. 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/colunas/gonzalo-vecina/saude/o-sistema-de-atencao-a-saude-privado-no-brasil/>. Acesso em: 3 mai. 2025.

VON NEUMANN, John.; MORGENSTERN, Oskar. *Theory of games and economic behavior*. Princeton: Princeton University Press, 1944.

VORONOFF, Alice. Sobre agências reguladoras, sanções e preços: um olhar a partir das lentes da análise econômica do direito. In: *Regulação e infraestrutura*. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 63-79.

WANG, Yang; SLOAN, Frank A. Present bias and health. *Journal of risk and uncertainty*. Vol. 57, p.177-198. 2018. doi:10.1007/s11166-018-9289-z

WRIGHT, Joshua D.; GINSBURG, Douglas H. Behavioral Law and Economics: Its Origins, Fatal Flaws, and Implications for Liberty. *Northwestern University Law Review*, v. 106, n. 3, p. 1033-1079, 2012.

YEUNG, Luciana Luk Tai. Comportamento judicial, decisões judiciais, consequencialismo e efeitos bumerangues. In: YEUNG, Luciana Luk Tai (coord.). *Análise econômica do direito: temas contemporâneos*. São Paulo: Almedina, 2020.

YEUNG, Luciana Luk Tai. Pode algum paternalismo ser libertário? *Revista Veja*, São Paulo, 25 nov. 2024. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/coluna/direito-e-economia/pode-um-paternalismo-ser-libertario/>. Acesso em: 17 nov. 2025.

YEUNG, Luciana Luk Tai; CAMELO, Bradson. *Curso de análise econômica do direito*. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2024.

**APÊNDICE A – RELAÇÃO DAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANS
EXAMINADAS**

Nº da RN	Ano	Objeto Resumido
RN nº 137	2006	Regulamentação das entidades de autogestões de assistência à saúde (autogestões).
RN nº 264	2011	Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos (PROMOPREV) — REVOGADA.
RN nº 265	2011	Incentivos para usuários aderir à prevenção (PROMOPREV) — REVOGADA.
RN nº 323	2013	Criação de ouvidorias nas operadoras de planos de saúde.
RN nº 413	2016	Comercialização eletrônica e venda online de planos de saúde.
RN nº 424	2017	Junta médica para desempate em análises de cobertura assistencial.
RN nº 441	2018	Estabelecimento de teto para reajuste de planos individuais.
RN nº 465	2021	Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
RN nº 482	2022	Regimento Interno da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).
RN nº 483	2022	Ações fiscalizatórias e Núcleos de Informação ao Prestador (NIPs).
RN nº 489	2022	Infrações e Penalidades para operadoras de planos de saúde.
RN nº 498	2022	Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos (PROMOPREV).
RN nº 499	2022	Incentivos para Prevenção (PROMOPREV).
RN nº 503	2022	Contratualização entre operadoras e prestadores de serviços de saúde.

RN nº 505	2022	Programa de Qualificação de Operadoras (PQO) e Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS).
RN nº 518	2022	Práticas mínimas de governança corporativa, controles internos e gestão de riscos para operadoras.
RN nº 531	2022	Definição, segmentação e classificação de operadoras de planos de saúde por modalidade e tipo de atenção.
RN nº 543	2022	Concessão de Autorização de Funcionamento de operadoras e registro de produtos de planos de saúde.
RN nº 557	2022	Classificação e características dos planos privados de assistência à saúde (individual, coletivo empresarial e por adesão).
RN nº 558	2022	Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP), Cobertura Parcial Temporária (CPT) e Declaração de Saúde.
RN nº 559	2022	Transmissão de arquivos via Programa Transmissor de Arquivos (PTA) para NTRP, RPC e SIP.
RN nº 560	2022	Cadastro de planos de saúde privados pré-Lei 9.656/1998 ("planos antigos" ou "pré-lei").
RN nº 561	2022	Cancelamento de contratos individuais/familiares e exclusão de beneficiários em planos coletivos.
RN nº 562	2022	Adaptação e migração de planos de saúde antigos para conformidade com Lei 9.656/1998.
RN nº 563	2022	Limites para variação de preços por faixa etária (dez faixas) em planos de saúde.
RN nº 564	2022	Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP) para registro de produtos de saúde suplementar.

RN nº 565	2022	Reajustes anuais de contraprestações em planos de saúde individuais, familiares e coletivos.
RN nº 566	2022	Garantia de atendimento ao beneficiário: prazos máximos, indisponibilidade/inexistência de prestadores, transporte e reembolso.
RN nº 567	2022	Substituição de prestadores não hospitalares em planos de saúde.
RN nº 568	2022	Substituição de hospitais e redimensionamento de rede por redução.
RN nº 569	2022	Critérios para definição do capital regulatório de operadoras (Capital Base, Capital Baseado em Riscos).
RN nº 548	2022	Análise de Impacto Regulatório (AIR) e Participação Social (PS) no processo regulatório da ANS.
RN nº 555	2022	Rito processual contínuo de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (avaliação de tecnologias em saúde).
RN nº 621	2024	Sandbox Regulatório: ambiente experimental com autorização temporária para testar inovações em saúde suplementar.
RN nº 623	2024	Atendimento de pedidos de cobertura assistencial e não assistencial: canais, prazos, protocolos e metas de desempenho.

APÊNDICE B – RESOLUÇÃO RN 505/2022 – IDSS (PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE OPERADORAS)

Dispositivo	Conteúdo normativo	Intervenção de economia comportamental sugerida
Art. 2º	Define o foco na “produção de saúde”, com ênfase em promoção e prevenção	Framing positivo: mudar o foco de tratamento de doença para produção de saúde
Art. 3º	Incentiva operadoras como “gestoras de saúde” e beneficiários com “consciência sanitária”	Mudança de identidade e papel social: reposicionamento simbólico dos atores do sistema
Art. 6º	IDSS calculado a partir de indicadores avaliados permanentemente	Feedback contínuo: avaliação e retorno regulares sobre o desempenho das operadoras
Art. 10, §1º	Dimensão Qualidade contempla ações de promoção, prevenção e assistência	Saliência de objetivos preventivos: tornar a prevenção componente central do indicador
Art. 12	Pondera dimensões do IDSS: 30% qualidade, 30% acesso, 30% sustentabilidade, 10% gestão	Sinalização de prioridades via pesos: comunicar o que é mais importante para o regulador
Art. 15	ANS divulga o IDSS das operadoras anualmente	Transparência e pressão reputacional: exposição pública dos resultados gera incentivo à melhoria
Art. 22	Operadora deve divulgar o próprio IDSS em seu site em até 30 dias	Saliência e accountability: informação facilmente acessível para o usuário na escolha do plano

**APÊNDICE C – RESOLUÇÃO RN 498/2022 – PROMOÇÃO DA SAÚDE E
PREVENÇÃO DE RISCOS E DOENÇAS**

Dispositivo	Conteúdo normativo	Intervenção de economia comportamental sugerida
Art. 2º, I e II	Define Promoção da Saúde e Programas Promoprev como “conjunto orientado de estratégias e ações programáticas integradas”	Arquitetura de escolha: estruturação do ambiente decisório para facilitar escolhas saudáveis
Art. 3º, I	Programa de Envelhecimento Ativo ao longo do curso da vida, com ações desde pré-natal até idades avançadas	Framing temporal ampliado: enquadrar a decisão em horizonte de longo prazo, reduzindo desconto hiperbólico
Art. 3º, II e III	Modelagens para População-Alvo Específica e Gerenciamento de Crônicos	Segmentação e personalização: nudges ajustados a perfis populacionais específicos
Art. 4º	Prevê incentivos para beneficiários: bonificação, premiação e outros	Incentivos positivos: recompensas tangíveis para induzir adesão a comportamentos saudáveis
Art. 5º, I	Redução de margem de solvência para operadoras com programas aprovados	Incentivo financeiro institucional: nudge voltado à operadora para investir em promoção e prevenção
Art. 5º, II	Pontuação bônus no IDSS para operadoras com programas Promoprev	Feedback público e reputacional: sinalização de desempenho perante o mercado
Art. 7º	Programas estruturados segundo características sociodemográficas e epidemiológicas da população	Personalização baseada em dados: desenho de nudges a partir de evidências sobre o público-alvo

APÊNDICE D – RESOLUÇÃO RN 499/2022 – BONIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS

Dispositivo	Conteúdo normativo	Intervenção de economia comportamental sugerida
Art. 2º, I	Bonificação definida como desconto no pagamento da mensalidade	Incentivo pecuniário saliente: redução clara do custo percebido ao aderir ao programa
Art. 2º, II	Premiação definida como oferta de prêmio não pecuniário	Recompensa tangível: prêmios como reforço para participação em ações de promoção e prevenção
Art. 2º, III	Adesão descrita como ato volitivo do beneficiário (participação voluntária)	Paternalismo libertário: estruturação do contexto sem eliminar a liberdade de escolha
Art. 4º	Comunicação anual obrigatória sobre possibilidade de adesão aos programas	Saliência e lembretes periódicos: “cutucadas” regulares para manter a opção no radar do beneficiário
Art. 6º	Prazo mínimo de 12 meses, com renovação automática de participação/bonificação	Default de renovação (opt-out): uso do status quo como padrão para manter o beneficiário no programa
Art. 7º e 8º	Bonificação com percentuais uniformes para todas as faixas etárias	Simplicidade e equidade: regra simples, de fácil compreensão, que facilita adesão e aceitação
Art. 12, I–VI	Veda condicionar bonificação a condição de saúde, idade, sexo, alcance de meta, redução de sinistralidade ou tempo de permanência	Eliminação de barreiras comportamentais: evita penalidades e riscos que desestimulem a participação
Art. 12, parágrafo único	Permite aferição de metas, desde que não prejudique a bonificação	Monitoramento sem punição: feedback informativo sem efeito desmotivador

Art. 13, §2º	Estabelece que o ônus da prova da não participação é da operadora	Proteção contra práticas abusivas: reduz custo de contestação para o beneficiário e torna o incentivo crível
--------------	---	--